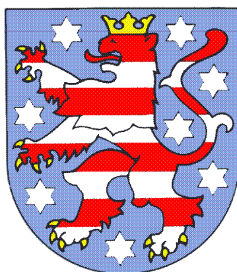


Thüringer Kultusministerium



Thüringer Lehrplan

für berufsbildende Schulen

Schulform: Dreijährige Höhere Berufsfachschule

Theoretischer Unterricht

Praktischer Unterricht

Beruf: Logopädin/Logopäde

Erfurt, den 08. Juni 2006

Herausgeber:

**Thüringer Kultusministerium
Werner-Seelenbinder-Straße 7, 99096 Erfurt**

Vorwort des Ministers

Thüringens Schulen werden sich noch stärker zu eigenverantwortlichen, selbstständigen und selbstbewussten Einrichtungen entwickeln, die die Schülerinnen und Schüler mit den Kompetenzen für lebenslanges Lernen und erfolgreiche berufliche Tätigkeit ausstatten. Damit werden sich ihre Lehrerinnen und Lehrer, ihre Schulleitungen sowie Eltern- und Schülervertretungen in den kommenden Jahren vielen neuen Anforderungen allgemeiner und beruflicher Bildung stellen.

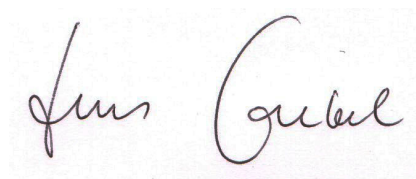
Der vorliegende Thüringer Lehrplan, die landesweit durchgeführten Fort- und Weiterbildungen und ein solides Unterstützungssystem, das ständig weiterentwickelt wird, bilden gute Voraussetzungen für erfolgreiche pädagogische Arbeit. Dabei spielen die neuen Medien im Unterricht eine wichtige Rolle.

Eine Vielzahl von Veränderungen in der beruflichen Ausbildung hat bereits Einzug gehalten: Die schrittweise Umstellung der dualen Ausbildung durch Anwendung lernfeldstrukturierter Lehrpläne stellt in diesem Bereich hohe Anforderungen an Pädagogen und Schulleitungen. In den berufsbildenden Schulen wird fächerübergreifendes Arbeiten bei starker Handlungsorientierung immer bewusster didaktisches Prinzip der Unterrichtsgestaltung. Doppelt qualifizierende Ausbildungen und rasche technologische Entwicklungen werden zur permanenten Herausforderung für die persönliche Fortbildung aller Beteiligten.

Wir wollen und wir brauchen berufsbildende Schulen, die Mobilität, Kommunikationsfähigkeit und vielfältige berufliche Chancen auf dem deutschen und europäischen Arbeitsmarkt sichern. Im Mittelpunkt aller pädagogischen Bemühungen der beruflichen Ausbildung steht der Jugendliche, der auf die komplexen Anforderungen des beruflichen Lebens optimal vorbereitet werden soll. Die konzeptionelle Basis zur Gestaltung der Thüringer Lehrpläne allgemein bildender Schulen und die Intentionen zur Kompetenzentwicklung der KMK-Rahmenlehrpläne berufsbildender Schulen liegen folgerichtig eng beieinander.

Der vorliegende Lehrplan ist zusammen mit der Stundentafel die verbindliche Grundlage für den Unterricht, er orientiert auf die Verbindung von Wissensvermittlung und Erziehung, er zielt auf die Entwicklung der beruflichen Handlungskompetenz mit all ihren Bestandteilen. Der Lehrplan beinhaltet bewusst auch pädagogische Freiräume, die der Lehrende eigenverantwortlich ausfüllen kann.

Allen Lehrerinnen und Lehrern wünsche ich viel Erfolg bei der ideenreichen Umsetzung des Lehrplanes und danke allen, die bei der Erarbeitung beteiligt waren und bei der künftigen Evaluierung mitwirken werden.

A handwritten signature in dark ink, reading "Jens Goebel". The signature is fluid and cursive, with the first name "Jens" and the last name "Goebel" clearly distinguishable.

Prof. Dr. Jens Goebel
Thüringer Kultusminister

Inhaltsverzeichnis

Seite

Vorwort des Ministers

Inhaltsverzeichnis

Abkürzungsverzeichnis

1	Vorbemerkungen	1
2	Mitarbeiterinnen der Lehrplankommission	2
3	Fachdidaktische Konzeption	3
4	Allgemeine Lernziele	5
5	Stundenübersicht	6
6	Lerngebiete	8
6.1	Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde	8
6.2	Anatomie und Physiologie	14
6.3	Pathologie	17
6.4	Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	25
6.5	Pädiatrie und Neuropädiatrie	27
6.6	Kinder- und Jugendpsychiatrie	34
6.7	Neurologie und Psychiatrie	38
6.8	Kieferorthopädie, Kieferchirurgie	44
6.9	Phoniatrie	47
6.10	Aphasiologie	60
6.11	Audiologie und Pädaudiologie	63
6.12	Elektro- und Hörgeräteakustik	68
6.13	Logopädie	70
6.14	Phonetik/Linguistik	99
6.15	Psychologie und klinische Psychologie	103
6.16	Soziologie	108
6.17	Pädagogik	109
6.18	Sonderpädagogik	111
6.19	Stimmbildung	114
6.20	Sprecherziehung	116
6.21	Fachenglisch	118

Abkürzungsverzeichnis

verwendete Abkürzung	Seite	Bedeutung
BDSG, LDSG	12	Bundesdatenschutzgesetz, Landesdatenschutzgesetz
FSME	31	Frühsommer-Meningo-Enzephalitis
PET	31	Positronen-Emissions-Tomographie
MCD	36	minimale zerebrale Dysfunktion
ADHS	36	Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom - Hyperaktivität
EMG	39	Elektromyographie
ENG	39	Elektronystagmographie
ECT	39	Emissions-Computer-Tomographie
AUOP	45	Alveolo-Urano-Osteo-Plastik
MFT	46	Myofunktionelle Therapie
SES	48	Sprachentwicklungsstörung
BSHG	50	Bundessozialhilfegesetz
RDVM	52	Resonanz-Durchschlag-Verlagerung-Mimik
VAR	58	verzögerte akustische Rückantwort
ICP	60	infantile Zerebralparese
CP	60	Zerebralparese
PNF	60	Propriozeptive Neuromuskuläre Faszilitation
MIT	64	Melodic Intonation Therapy
BERA	65	brainstem electric response audiometry (Hirnstammaudiometrie)
OAE	65	Oto-akustische Emmission
CI	68	Cochlea Implantat
ASA	74	Arbeitsschutzanweisungen
LE	77	Laryngektomie
ELFRA	79	Elternfragebogen für die Früherkennung von Risikokindern
LSV	81	Landauer Sprachentwicklungstest für Vorschulkinder
HSET	81	Heidelberger Sprachentwicklungstest
SETK	81	Sprachentwicklungstest für Kinder
DGS/PMS	84	Deutsche Gebärdensprache/Phonembestimmtes Manualsysteem
LOOFT	87	Logopädisch orientierte orofaziale Therapie
GRUMS	87	Heidelberger Gruppenkonzept für myofunktionelle Störungen
MODAK	89	Modalitätenaktivierung
REST	89	Reduzierte Syntaxtherapie
PACE	89	Promoting Aphasics Communicative Effectiveness
NAT	89	Neurolinguistische Aphasietherapie
EKN	89	Entwicklungsgruppe Klinische Neuropsychologie
MCD	92	Minimale Cerebrale Dysfunktion (siehe S. 36)
IPA	104	International Phonetical Alphabet
GMS	120	Graphemorientiertes Manualsysteem
PMS	120	Phonembestimmtes Manualsysteem (siehe S. 84)

1 Vorbemerkungen

Der vorliegende Thüringer Lehrplan für den Unterricht an der höheren Berufsfachschule im Ausbildungsberuf Logopäde/Logopädin basiert auf

- dem Thüringer Schulgesetz vom 6. August 1993 (GVBl. S. 445) in der Fassung vom 30. April 2003 (GVBl. S. 238).
- der Thüringer allgemeinen Schulordnung für berufsbildende Schulen sowie
- der Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden in der Bundesrepublik Deutschland (LogAPrO) vom 1. Oktober 1980 (BGBl. I S. 1892), geändert durch Art. 3 der Verordnung vom 6. Dezember 1994 (BGBl. I S. 3770).

Der Bildungsgang umfasst eine dreijährige schulische Ausbildung, die mit einer Abschlussprüfung, bestehend aus einem schriftlichen, praktischen und mündlichen Teil, endet. Die erfolgreich abgelegte staatliche Prüfung verleiht die Berechtigung, die Berufsbezeichnung Logopädin/Logopäde zu führen.

Die zentrale Aufgabe der Logopäden* ist die Prävention, Diagnostik, Therapie und Beratung von Patienten aller Altersgruppen mit Sprach-, Sprech-, Stimm-, Hör- und Schluckstörungen sowie den damit verbundenen Störungen der Kommunikationsfähigkeit und die Beratung der Angehörigen.

In der Ausbildung zum Logopäden werden Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten vermittelt, die erforderlich sind, um in der Kommunikationstherapie selbstständig und eigenverantwortlich tätig zu sein und die zu einer interdisziplinären Zusammenarbeit mit benachbarten Berufsgruppen befähigen.

Bei der Zeitplanung ist generell von 40 Unterrichtswochen pro Ausbildungsjahr auszugehen. Dabei ist zu beachten, dass die angegebenen Zeiten für die einzelnen Lerngebiete auch Zeiten für den pädagogischen Freiraum (20 %) sowie für Leistungskontrollen (10 %) enthalten.

Im pädagogischen Freiraum können zum Beispiel Schülerinteressen aufgegriffen, Themen in zeitintensiven Unterrichtsverfahren behandelt oder besondere Fähigkeiten des Lehrers in eigener pädagogischer Verantwortung eingebracht werden.

*Personenbezeichnungen im vorliegenden Lehrplan gelten für beide Geschlechter.

2 Mitarbeiterinnen der Lehrplankommission

Vorsitzende

Beensen, Monika

Staatliche Berufsbildende Schule
für Gesundheit und Soziales
Rudolf-Breitscheid-Straße 56/58
07747 Jena

Mitglieder

Paul, Susanne

Staatliche Berufsbildende Schule
für Gesundheit und Soziales
Rudolf-Breitscheid-Straße 56/58
07747 Jena

Lausch, Barbara

Die Schule - IFBE BZ GmbH
Höhere Berufsfachschule für Logopädie
Löberwallgraben 24
99096 Erfurt

Wir bedanken uns bei allen Fachdozenten und Kollegen für die hilfreichen Diskussionen im Rahmen der Lehrplanerarbeitung.

3 Didaktische Konzeption

Mit der Implementation der neuen Thüringer Lehrpläne in den allgemein bildenden Schulen in Thüringen wird die Schwerpunktsetzung auf die Entwicklung von Kompetenzen Veränderungen im Unterricht in Grundschule, Regelschule und Gymnasium bewirken.

Es kann daraufhin insbesondere eine verbesserte Lernkompetenz bei den Abgängern dieser Schularten erwartet werden.

In der Schulart berufsbildende Schule soll nun eine konzeptionale Basis verwendet werden, welche das Modell der genannten Schularten fortschreibt und gleichzeitig die Besonderheiten der berufsbildenden Schule einbezieht.

Dabei wird die berufliche Handlungskompetenz als Weiterentwicklung der Lernkompetenz in ihrer integrativen Form angestrebt.

Der Unterricht an berufsbildenden Schulen bereitet auf berufliches Handeln und auf die Mitgestaltung der Arbeitswelt in sozialer und ökologischer Verantwortung vor. Ziel eines solchen Unterrichts muss die Vermittlung einer Handlungskompetenz sein, die Sach-, Selbst-, und Sozial- und Methodenkompetenz als integrative Bestandteile enthält.

Der Begriff Sachkompetenz wird hier verwendet, da berufliches Lernen nicht mehr nur ausschließlich an einer aus der Wissenschaftssystematik gewonnenen Fachstruktur, sondern an beruflichen Arbeiten, d. h. an der Sache, orientiert werden soll.

Berufliche Handlungskompetenz entfaltet sich integrativ in den Dimensionen Sach-, Selbst-, Sozial- und Methodenkompetenz und umfasst die Bereitschaft und Fähigkeit des einzelnen Menschen, in beruflichen Anforderungssituationen sachgerecht, durchdacht, individuell und sozial verantwortlich zu handeln sowie seine Handlungsmöglichkeiten weiterzuentwickeln.

Sachkompetenz bezeichnet die Bereitschaft und Fähigkeit, Aufgaben- und Problemstellungen sachlich richtig, selbstständig, zielorientiert und methodengeleitet zu lösen bzw. zu bearbeiten und das Ergebnis zu beurteilen.

Selbstkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, die eigenen Entwicklungsmöglichkeiten, -grenzen und -erfordernisse in Beruf, Familie und Gesellschaft zu beurteilen und davon ausgehend die eigene Entwicklung zu gestalten. Selbstkompetenz schließt die reflektierte Entwicklung von Wertvorstellungen und die selbstbestimmte Bindung an Werte ein.

Sozialkompetenz bezeichnet die individuelle Bereitschaft und Fähigkeit, soziale Beziehungen zu leben und zu gestalten, sich mit anderen rational und verantwortungsbewusst auseinander zu setzen und zu verständigen, Verantwortung wahrzunehmen und solidarisch zu handeln.

Methodenkompetenz umfasst die Fähigkeit und die Bereitschaft, Lernstrategien zu entwickeln, unterschiedliche Techniken und Verfahren sachbezogen und situationsgerecht anzuwenden. Sie ermöglicht den Schülern mehr Selbstständigkeit und Selbstvertrauen, größere Sicherheit und Versiertheit sowie erhöhte Effizienz beim Lernen.

Kompetenzen werden in der tätigen Auseinandersetzung mit fachlichen und fächerübergreifenden Inhalten des Unterrichts erworben, sie schließen die Ebenen des Wissens, Wollens und Könnens ein. Die Kompetenzen haben Zielstatus und beschreiben den Charakter des Lernens.

Zur Gestaltung eines solchen Unterrichts mit fächerübergreifenden Ansätzen, Projektarbeit und innerer Differenzierung werden von den neuen Lehrplänen Freiräume geboten.

Dazu sollen die Lehrpläne die schulinterne Kommunikation und Kooperation zwischen den Lehrern anregen und fördern.

Handlungsorientierter Unterricht ist ein didaktisches Konzept, das sach- und handlungssystematische Strukturen miteinander verschränkt. Dies lässt sich durch unterschiedliche Unterrichtsmethoden verwirklichen.

Methoden, welche die Handlungskompetenz unmittelbar fördern, sind an folgenden Prinzipien orientiert:

- Didaktische Bezugspunkte sind Situationen, die für die berufliche Weiterentwicklung bedeutsam sind.
- Den Ausgangspunkt des Lernens bilden Handlungen, möglichst selbst ausgeführt oder gedanklich nachvollzogen.
- Die Handlungen sollen vom Lernenden möglichst selbstständig geplant, ausgeführt und bewertet werden.
- Diese Handlungen sollen ein ganzheitliches Erfassen der beruflichen Wirklichkeit fördern, z. B. technische, sicherheitstechnische, ökonomische, ökologische, rechtliche und soziale Aspekte einbeziehen.
- Bei den sozialen Aspekten sollen z. B. Interessenerklärung und Konfliktbewältigung einbezogen werden.

Die Umsetzung des Kompetenzmodells erfordert gleichzeitig ein erweitertes Leistungsverständnis, das mit der didaktisch-methodischen Kultur des Lernens verbunden ist und den Schülern handlungsorientiertes, entdeckendes Lernen ermöglicht.

Diese neue Herangehensweise bedingt eine neue Schwerpunktsetzung bei der Leistungsförderung und Leistungsbeurteilung, wobei die Gesamtpersönlichkeit des Schülers in einem mehrdimensionalen sozialen Lernprozess in den Blick genommen werden soll.

Die vom Lehrplan abgeleiteten und an den Schüler gestellten Anforderungen bilden dann die Basis der Leistungsbeurteilung, sie umfassen in verschiedenen Niveaustufen

- Reproduktion in unveränderter Form
- Reorganisation als Wiedergabe von Bekanntem in verändertem Zusammenhang
- Transfer von Gelerntem auf vergleichbare Anwendungssituationen
- Problembearbeitung

Der Komplexitätsgrad und die Niveaustufen der vom Schüler zu bearbeitenden Aufgaben und die daraus abgeleiteten Beobachtungskriterien des Lehrers bestimmen die Schwerpunkte und Gewichtungen in der Bewertung.

Der Thüringer Lehrplan des Ausbildungsberufs Logopäde enthält verbindliche Lernziele und Lerninhalte, deren Reihenfolge empfehlenden Charakter hat und durch gemeinsame, Fächer übergreifende Planung und fortlaufende Absprachen der Lehrkräfte abzustimmen ist.

Die didaktisch-methodischen Hinweise sind als Empfehlungen zu verstehen, die in keiner Weise die pädagogische Freiheit der Lehrenden bei der Unterrichtsgestaltung entsprechend der Zielstellung einengen sollen.

Das grundsätzliche didaktische Anliegen der Ausbildung besteht in einer engen Verknüpfung von Theorie und Praxis.

Im Vordergrund stehen eine praxisorientierte Vermittlung theoretischer Grundlagen und Erkenntnisse, die Entwicklung und Förderung der Selbstständigkeit der Schüler bei der Aneignung von Fähigkeiten und Fertigkeiten im praktischen Unterricht sowie die Befähigung zum beruflichen Handeln, zur Handlungskompetenz, d. h. Entwicklung von Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz, unter anderem durch Methoden- und Kommunikationstraining sowie Training zur Teamentwicklung.

Die logopädische Diagnostik und Therapie als interaktionsintensive Formen der Patientenbetreuung setzen den Aufbau eines vertrauensvollen Patient-Therapeuten-Verhältnisses voraus.

Auf die Einhaltung verbindlicher Qualitätsstandards bezüglich ihrer beruflichen Leistungen - sachkompetenz, Effizienz logopädischer Therapien sowie effektive kollegiale und interdisziplinäre Kooperation - sind die Schüler während ihrer Ausbildung durch die Entwicklung von Wertorientierungen unter besonderer Berücksichtigung berufsethischer Aspekte gründlich vorzubereiten.

Die Befähigung der Schüler zur selbstständigen Bewältigung berufstypischer Aufgabenstellungen muss unter Berücksichtigung der unterschiedlichen Fähigkeiten und Begabungen differenziert erfolgen.

Wissen, Können und Erkennen sollten beispielsweise entsprechend des Lernzieles über verschiedene, hierarchische Lernstufen erworben werden:

- Wissen: Einblick, Überblick, Kenntnis und Vertrautheit
- Können: Fähigkeit, Fertigkeit und Beherrschung
- Erkennen: Bewusstsein, Einsicht und Verständnis.

Es ist empfehlenswert, erreichte Ergebnisse kontinuierlich in Form schriftlicher, mündlicher oder praktischer Lernerfolgskontrollen zu überprüfen.

Der verstärkte Einsatz vielfältiger, besonders handlungsfördernder Methoden, Anschauungsmaterialien, moderner Medien, neuester Fachliteratur sowie eine enge Zusammenarbeit mit Praxiseinrichtungen sollte ebenso selbstverständlich sein, wie die eigenverantwortliche Einbeziehung neuester theoretischer Erkenntnisse, Untersuchungs- und Therapiemethoden durch die Lehrenden.

4 Allgemeine Lernziele

Die Schüler der Logopädie als klinisch-therapeutische Disziplin besitzen Sach-, Selbst- und Sozialkompetenz, d. h. sie

- haben grundlegende Kenntnisse, Einsichten und Fertigkeiten für das berufliche Handeln als Logopäde erworben, sie sind mit allen Arten von Störungen der Stimme, Sprache, der Artikulation, des Redeflusses, der Schriftsprache, des Schluckaktes sowie Auswirkungen von Hörstörungen auf die Stimme, Sprache und das Sprechen vertraut und kennen altersadäquate diagnostische Möglichkeiten sowie therapeutische Interventionen bei diesen Störungen, um kommunikativ behinderten Menschen die Teilnahme am sozialen Leben wieder zu ermöglichen,
- verfügen über Verantwortungsbereitschaft und Problemlösefähigkeit,
- sind in der Lage, im Rahmen der logopädischen Diagnostik, Therapie (Einzel- und Gruppentherapie) und Beratung (Patienten- und Angehörigenberatung) eigenverantwortlich bezüglich Planung, Selbstmanagement, Durchführung und Evaluation notwendiger Tätigkeiten zu handeln,
- haben den Stellenwert präventiver Maßnahmen erfasst, können diese propagieren und initiieren,
- setzen moderne technische Hilfsmittel zielgerichtet ein und sind sicher im Umgang mit diesen,
- sind sicher und korrekt im Umgang mit Patienten und Personal,
- sind zur qualifizierten konstruktiven Mitarbeit im therapeutischen Team bereit und fähig,
- haben Wertvorstellungen unter besonderer Berücksichtigung berufsethischer Aspekte entwickelt,
- sind bereit zur beruflichen Fort- und Weiterbildung,
- haben Flexibilität zur Bewältigung der sich verändernden gesellschaftlichen Anforderungen entwickelt.

5 Stundenübersicht

Lerngebiete	Gesamtstundenzahl	davon praktischer Unterricht
Theoretischer und praktischer Unterricht		
Berufs-, Gesetzes und Staatsbürgerkunde	60	
Anatomie und Physiologie	100	
Pathologie	40	
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	60	
Pädiatrie und Neuropädiatrie	80	
Kinder- und Jugendpsychiatrie	40	
Neurologie und Psychiatrie	60	
Kieferorthopädie, Kieferchirurgie	30	
Phoniatrie	150	
Aphasiologie	60	
Audiologie und Pädaudiologie	70	
Elektro- und Hörgeräteakustik	30	
Logopädie	560	280
Phonetik/Linguistik	100	
Psychologie und klinische Psychologie	150	
Soziologie	40	
Pädagogik	60	
Sonderpädagogik	80	
Stimmbildung	100	100
Sprecherziehung	100	100
Fachenglisch	40	
Gesamtstunden theoretischer und praktischer Unterricht	2010	480

Empfohlene Wochenstundenübersicht

Rahmenstundentafel

Logopädie (117 Wochen)

Lerngebiete	Ges.Std	1. Jahr		2. Jahr		3. Jahr	
Schulhalbjahr		1	2	3	4	5	6
		Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Theoretischer und praktischer Unterricht							
Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde	60						
• Berufskunde	20	1					
• Gesetzeskunde	20				1		
• Staatsbürgerkunde	20		1				
Anatomie und Physiologie	100	5					
Pathologie	40	1				1	
Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde	60	1	2				
Pädiatrie und Neuropädiatrie	80	2	2				
Kinder- und Jugendpsychiatrie	40			2			
Neurologie und Psychiatrie	60			1	1	2	
Kieferorthopädie, Kieferchirurgie	30		1,5				
Phoniatrie	150	2	2	2	1,5		
Aphasiologie	60				1	2	
Audiologie und Pädaudiologie	70		2	1,5			
Elektro- und Hörgeräteakustik	30				1,5		
Logopädie	560						
Logopädie (theoretischer Unterricht)	280	3	3	3	3	2	
Logopädie (praktischer Unterricht)	280	3	3	3	3	2	
Phonetik/Linguistik	100	2	1	1	1		
Psychologie und klinische Psychologie	150						
• Psychologie	60	2	1				
• Klinische Psychologie	90			2	1	1,5	
Soziologie	40				2		
Pädagogik	60	2	1				
Sonderpädagogik	80						
• Sonderpädagogik	40				2		
• Schwerhörigen-/Gehörlosen-pädagogik	40					2	
Stimmbildung	100	2	1	1	1		
Sprecherziehung	100	2	1	1	1		
Fachenglisch	40					2	
Summe	2010	28	21,5	17,5	20	14,5	0
Lerngebiete	Ges.Std	1. Jahr		2. Jahr		3. Jahr	
Schulhalbjahr		1	2	3	4	5	6
		Std.	Std.	Std.	Std.	Std.	Std.
Fachpraktische Ausbildung							
Hospitationen	340	4	4	4	2	3	
Praxis der Logopädie	1610	6	12	12	12	12	31,5
Praxis auf den Gebieten der	290						
• Audiologie/Pädaudiologie	80			1,5	1	1,5	
• Psychologie	120		2	2			2
• Musiktherapie	90			2	2	0,5	
Summe	2240	10	18	21,5	17	17	33,5

6 Lerngebiete

6.1 Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde (60 Stunden)

Lernabschnitte	Zeitrachtwerte
1 Gesetz über den Beruf des Logopäden	ca. 4 Stunden
2 Aufgaben des Logopäden	ca. 8 Stunden
3 Gesetzliche Regelungen für die übrigen Berufe des Gesundheitswesens	ca. 2 Stunden
4 Strafrechtliche und bürgerlich-rechtliche Bestimmungen, die für Ausübung des Berufes von Bedeutung sind	ca. 9 Stunden
5 Einführung in den Infektionsschutz sowie das Arznei- und Betäubungsmittelgesetz	ca. 2 Stunden
6 Einführung in das Arbeits- und Sozialrecht einschließlich Rehabilitationsgesetze, Jugendschutzrecht und Unfallverhütungsvorschriften	ca. 9 Stunden
7 Grundbegriffe der Krankenhausbetriebs- und Verwaltungslehre	ca. 3 Stunden
8 Das öffentliche Gesundheitswesen und Dokumentation, Statistik und Datenverarbeitung in der Medizin	ca. 3 Stunden
9 Grundlagen der staatlichen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland	ca. 16 Stunden
10 Die Europäische Union	ca. 4 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
-----------	-------------	---------------------------------

6.1.1 Gesetz über den Beruf des Logopäden (ca. 4 Stunden)

Die Schüler verfügen über Kenntnisse zur Berufsgeschichte.	Geschichte der Logopädie Berufsbild „Logopäde“ - Einordnung des Logopädenberufs - angrenzende, korrespondierende Berufsfelder	historischer Überblick ausführliche Darstellung des Berufsbildes; Überblick über weitere stimm-, sprech- und sprachtherapeutisch tätige Berufsgruppen und ihre Besonderheiten; Videoeinsatz; Darstellung der Kriterien für die persönliche Berufsentscheidung
Sie kennen das Berufsbild und besitzen die Fähigkeit zur Einordnung des Berufes des Logopäden in das Spektrum der therapeutisch-rehabilitativen Berufe.		
Sie erkennen die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit.	gesetzliche Grundlagen - Gesetz über den Beruf des Logopäden • Geltungsbereich • Inhalte • Interpretation des Gesetzestextes	Einführung; Arbeit mit dem Gesetzestext (Interpretation, Diskussion, evtl. Gruppenarbeit); Berufsgesetz und gegenwärtige Situation
Sie kennen das Berufsgesetz und sind zur sicheren Interpretation des Gesetzestextes fähig.	- Ausbildungs- und Prüfungsordnung für Logopäden (LogAPrO) - Lehrplan	(z. B. Zugangsvoraussetzungen); Auseinandersetzung mit den Anforderungen der LogAPrO; Vergleich LogAPrO und aktuelle Anforderungen an die Logopäden; Ausbildungsmodus in anderen Staaten der EU
Sie besitzen exaktes Wissen über Ablauf, Organisation und Inhalte des eigenen Bildungsganges.		

6.1.2 Aufgaben des Logopäden (ca. 8 Stunden)

Die Schüler erkennen die Vielfalt von Aufgaben und Einsatzmöglichkeiten, des hohen Anforderungsniveaus an die logopädische Leistung und großer Verantwortung des Logopäden und erfassen die unterschiedliche Stellung des Logopäden als Arbeitnehmer und Arbeitgeber sowie der sich daraus ergebenden Aufgaben.	Aufgaben, Rechte und Pflichten des Logopäden - Klientel, Tätigkeiten, Einsatzmöglichkeiten - Aufgaben, Rechte und Pflichten des angestellten Logopäden - Aufgaben, Rechte und Pflichten des frei niedergelassenen Logopäden	Einführung in das Aufgabengebiet eines Logopäden; Auseinandersetzung mit berufsethischen Fragen; Unterschiede herausarbeiten
---	--	--

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Kenntnisse - des Modus und formaler Anforderungen bei der Verordnung logopädischer Maßnahmen; - der formalen Anforderungen an eine Therapieeinheit.	Verordnung von Stimm-, Sprech-, Sprach- und Schlucktherapien - Verordnungsberechtigung - Erst- und Folgeverordnung die Therapiesitzung - Rahmenbedingungen - Aufbau usw.	Notwendigkeit einer einheitlichen Verfahrensweise diskutieren; Demonstration und Erläuterung des Verordnungsformulars 14 Konzentration auf organisatorische Fragen; Abstimmung mit dem Lerngebiet Logopädie Gegenüberstellen der Alternativen
Sie besitzen Wissen über Möglichkeiten der Vergütung erbrachter Leistungen. Sie haben Einblick in das Abrechnungswesen.	Vergütung logopädischer Leistungen - Privatpatienten - Kassenpatienten - Zuzahlungen usw. Vergütung der Arbeitsleistung - tarifvertragliche Regelungen • Regelungen des BAT über Arbeitszeit und Urlaub • Tätigkeitsmerkmale im Bereich des BAT • Vergütungsgruppen - Vergütung in privatrechtlichen Einrichtungen	Diskussion ausgewählter Fälle auf ausgewählte Probleme eingehen; Arbeit mit Fallbeispielen; Abstimmung mit dem Lernabschnitt Arbeitsrecht
Sie haben Kenntnisse über - tarifvertragliche Regelungen im öffentlichen Dienst sowie mögliche Abweichungen in privatrechtlichen Einrichtungen; - die Geschichte des Berufsverbandes, seine Organisation, Ziele und wichtigsten Aufgaben und über die berufsethischen Normen. Sie sind für die Arbeit des Berufsverbandes sensibilisiert.	Deutscher Bundesverband für Logopädie e. V. - Geschichte des DBL e. V. - Verbandsstruktur	historischer Abriss; Darstellung der Verbandsstruktur (Übersicht); Schülervorträge und Diskussionen zu: Verbandsgrundsatzprogramm, Berufsleitlinien, Berufsordnung, Satzung usw.; Einsatz von Informationsmaterial des DBL e. V.

6.1.3 Gesetzliche Regelungen für die übrigen Berufe des Gesundheitswesens (ca. 2 Stunden)

Die Schüler besitzen einen Überblick über das ärztliche Berufsrecht und das Berufsrecht ausgewählter Berufe im Gesundheitswesen mit therapeutischen Aufgabenfeldern. Sie sind zur Kooperationsbereitschaft motiviert.	gesetzliche Regelungen für weitere Berufe im Gesundheitswesen	Auswahl korrespondierender Berufsgruppen; Berührungspunkte und Grenzen aufzeigen; Erarbeitung spezifischer gesetzlicher Regelungen; Schülervorträge
---	--	--

6.1.4 Strafrechtliche und bürgerlich-rechtliche Bestimmungen, die für die Ausübung des Berufes von Bedeutung sind (ca. 9 Stunden)

Die Schüler haben erweiterte und gefestigte Grundkenntnisse über Aufbau, Wesen und Aufgaben des Rechts.	Wesen und Aufgaben des Rechts	Reaktivierung von Kenntnissen; Diskussion der Notwendigkeit der Fortentwicklung des Rechts (Wertewandel, EU usw.)
--	--------------------------------------	--

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die allgemeinen Bestimmungen des bürgerlichen Rechts.	Zivilrecht - Rechtssubjekte und Rechtsgeschäfte • Rechtsfähigkeit • Handlungsfähigkeit • Willenserklärung • Rechtsgeschäfte • Rechtsobjekte	Arbeit mit dem BGB; Erarbeitung von Grundbegriffen der Rechtsordnung; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit unterschiedlicher rechtlicher Regelungen in Abhängigkeit vom Lebensalter.		
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Bewertung des Grundsatzes der Vertragsfreiheit sowie zur Ableitung der Notwendigkeit ihrer Beschränkung.	- Vertragsfreiheit und ihre Grenzen • Minderjährigenrecht • Grade der Rechtswirksamkeit usw. - Kaufvertrag und andere Rechtsgeschäfte • normale Abwicklung • Störungen - Schadenersatzrecht • vertragliche Ansprüche • deliktische Ansprüche	Informationen über das allgemeine Vertragsrecht Erstellen einer Übersicht über mögliche Leistungsstörungen; Darstellen der Voraussetzungen und Rechtsfolgen
Sie kennen Arten, Zustandekommen, Beendigung, Anfechtbarkeit und Nichtigkeit von Rechtsgeschäften.		Ableitung zivilrechtlicher Haftungssituationen auf verschiedenen Rechtsgrundlagen, Unterschiede der Haftungsarten; Gruppenarbeit, Bearbeitung von Fallbeispielen, besonders aus dem Berufsalltag
Sie sind fähig zur Einordnung zivilrechtlicher Haftungssituationen.		
Sie haben Kenntnisse über die Rechtsnatur des Behandlungsvertrages und der sich daraus ergebenden Rechte und Pflichten für Patient und Therapeut.	- Rechtsprobleme bei der Behandlung Kranker • Behandlungsvertrag • Rechtsbeziehung zwischen Patienten, klinischer Einrichtung, Arzt, Logopäden sowie zwischen Patienten, Logopädischer Praxis, Krankenkasse • Haftung bei Eigenschäden des Logopäden	Anwendung von Kenntnissen aus dem allgemeinen Vertragsrecht; ausführliche Wissensvermittlung zum Behandlungsvertrag (Abschluss, Form, Inhalt, Erfüllung, Nichterfüllung seitens der Vertragspartner und Konsequenzen, Vertragsbeendigung)
Sie besitzen Fähigkeit zur Anwendung erworbener Kenntnisse bei der Lösung komplexer berufsrelevanter Rechtsfälle.		
Sie kennen die Aufgaben des Strafrechts sowie strafrechtlich geschützte Rechtsgüter, Werte und Interessen.	Strafrecht - Aufgaben des Strafrechts - Voraussetzungen und Elemente der Strafbarkeit - ausgewählte berufsrelevante Delikte	Arbeit mit dem StGB; Einbeziehung und Diskussion aktueller Fälle aus den Medien; Erarbeitung der Elemente einer Straftat, von Rechtfertigungsgründen, Schuldunfähigkeit sowie Übertragung auf berufstypische Delikte; Verletzung der Schweigepflicht, siehe auch unter 6.1.8; Aufzeigen wesentlicher Folgen ausgewählter Delikte anhand einfacher Fälle
Sie erfassen mögliche Rechtsfolgen einer Straftat.		
Sie verfügen über Kenntnisse der Besonderheiten des Jugendstrafrechts.	- Jugendgerichtsgesetz	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.1.5 Einführung in den Infektionsschutz sowie das Arznei- und Betäubungsmittelrecht (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über	Infektionsschutz, Arznei- und Betäubungsmittelrecht	Auseinandersetzung mit den gesetzlichen Bestimmungen (IfSG, AMG, BtMG);
- wesentliche Bestimmungen des Infektionsschutz-, Arzneimittel- und Betäubungsmittelgesetzes;	- gesetzliche Bestimmungen zur Bekämpfung übertragbarer Krankheiten (IfSG)	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Pathologie, Pädiatrie und Neuropädiatrie;
	- Arzneimittelgesetz (AMG)	Darbietung AMG und BtMG informativ
	- Betäubungsmittelgesetz (BtMG)	
- die allgemeinen Voraussetzungen zum Betreiben medizinisch-technischer Geräte sowie zum Unfallschutz.	Medizingeräteverordnung (MedGV)	MedGV und Geräte im logopädischen Arbeitsbereich; Behandlung der Unfallverhütungsvorschriften in Abstimmung mit Lernabschnitt 6.1.6
6.1.6 Einführung in das Arbeits- und Sozialrecht einschließlich Rehabilitationsgesetze, Jugendschutzrecht und Unfallverhütungsvorschriften (ca. 9 Stunden)		
Die Schüler kennen die Rechtsquellen und Grundbegriffe des Arbeitsrechts.	Arbeitsrecht	Einführung;
	- Leitgedanken	Grundlagenvermittlung;
	- Rechtsquellen	Erarbeitung der wesentlichen Grundbegriffe und Aufgaben;
	- Grundbegriffe	Vermittlung von Kenntnissen zum Tarifrecht, besonders BAT;
Sie haben Grundkenntnisse über das Tarifrecht.	- Arbeitsgerichtsbarkeit usw.	
	- kollektives Arbeitsrecht	
	- individuelles Arbeitsrecht	
Sie verfügen über Kenntnisse der Rechtsnormen für die in abhängiger Tätigkeit geleistete Arbeit.	• Arbeitsvertrag (Anbahnung, Begründung, Zustandekommen, Inhalt, Arten, Nichtigkeit und Anfechtbarkeit)	Anwendung von Wissen aus dem Vertragsrecht, Erörterung der Problematik berufsbezogen; Musterarbeitsverträge vorstellen
Sie besitzen Kenntnisse über Schutzbestimmungen einschließlich Kündigungsschutzrecht.	• Rechte und Pflichten des Arbeitnehmers und -gebers	
	- soziale Absicherung des Arbeitnehmers	Vorträge; Arbeit mit Fallbeispielen
	• Mutterschutzgesetz,	
	• Jugendarbeitsschutzgesetz,	
	• Schwerbehindertengesetz,	Abgrenzung der Begriffe Erwerbsunfähigkeit, Berufsunfähigkeit, verminderte Erwerbsfähigkeit und Schwerbeschädigung
	• Kündigungsschutzrecht (Arten, Gründe, Fristen von Kündigungen, Personen mit besonderem Kündigungsschutz)	
Sie haben einen Überblick über die Sozialversicherungen.	Sozialrecht und Sozialhilferecht	Einführung (historischer Überblick, gesetzliche Grundlagen, Bereiche); Einsatz von Informationsmaterial der Versicherungsträger;
	- Sozialrecht	Schülervorträge;
	Sozialversicherungen	Vorträge von Vertretern entsprechender Institutionen
Sie kennen die Grundzüge des Sozialhilferechts und weitere wichtige Sozialgesetze.	• Arten	
	• versicherter Personenkreis	
	• Versicherungsträger	
	• versicherte Risiken	
	• Leistungsumfang	
	• Finanzierung	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- Sozialhilferecht • Aufgaben der Sozialhilfe • Ansprüche • Art und Umfang der Leistungen - weitere wichtige Sozialgesetze • BaföG • Wohngeldgesetz usw.	Arbeit mit Fallbeispielen
6.1.7 Grundbegriffe der Krankenhausbetriebs- und Verwaltungslehre (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler sind über Grundlagen des Krankenhauswesens informiert.	- Einteilung der Krankenhäuser nach ihrer Aufgabenstellung - ordnungsbehördliche Genehmigungen und Beaufsichtigung der Krankenhäuser - Trägerschaft und Krankenhausleitung - Krankenhausbedarfsplanung - Krankenhausfinanzierung - Gesundheitsstrukturgesetz (GSG)	Auseinandersetzung mit dem Gesetz zur Neuordnung der Krankenhausfinanzierung (KHNG) und Bundespflegesatzverordnung (BPflV), dem Gesundheitsstruktur- sowie Gesundheitsmodernisierungs-Gesetz (GMG); aktuelle Veränderungen sind jeweils einzuordnen
6.1.8 Das öffentliche Gesundheitswesen und Dokumentation, Statistik und Datenverarbeitung in der Medizin (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnis	das öffentliche Gesundheitswesen	Erstellen von Übersichten zum Aufbau und den Aufgaben des Gesundheitswesens
- über den Aufbau und die Aufgaben besonders des öffentlichen Gesundheitswesens;	- Zielstellung (WHO/EU) - internationale Gesundheitsbehörden - nationales Gesundheitswesen • öffentliches Gesundheitswesen: Gesundheitsbehörden auf Bundes- und Länderebene und ihre Aufgaben • nachgeordnete Dienststellen	(Aufsicht über die Berufe des Gesundheitswesens, Gesundheitsfürsorge und -erziehung); Analysieren der Ziele des Gesundheitswesens und Ableitung des eigenen Beitrags durch die Schüler
- zur korrekten Dokumentation, Statistik und Datenverarbeitung in der Medizin sowie über ihre gesetzlichen Grundlagen.	Dokumentation, Statistik und Datenverarbeitung in der Medizin	Herausarbeiten der Bedeutung der Dokumentationspflicht für eine ordnungsgemäße Patientenversorgung und in Bezug auf Haftungsansprüche
Sie erkennen Vorteile und Gefahren der maschinellen Datenverarbeitung.	- Dokumentationspflicht • Dokumentationsinhalte • Sicherung und Aufbewahrungsfristen von Dokumenten, besonders Patientenakten • Einsichtsrecht in und Herausgabe von Krankenunterlagen - Statistiken - Forschung mit Patientendaten - Umgang mit personenbezogenen Daten (Erheben, Speichern, Verändern, Übermitteln, Sperren, Löschen, Nutzen)	Abgrenzung objektiver und subjektiver Aufzeichnungen bezüglich des Einsichtsrechts des Patienten; rechtliche Grundlagen der Dokumentationspflicht
Sie besitzen Kenntnisse über den Umgang mit personenbezogenen Daten.		
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit des Datenschutzes und die gesetzliche Offenbarungspflicht;	- Datenschutz • Notwendigkeit • Ziel • gesetzliche Grundlagen: BDSG, LDSG und spezielle Rechtsvorschriften, • Kontrollorgane - gesetzliche Verpflichtung der Offenbarung und Offenbarungsbefugnis	Einbeziehung von Kenntnissen zu Schweige- und Offenbarungspflicht, Lernabschnitt 6.1.4; Was, wie, wovor schützen? evtl. Vortrag und Diskussion mit dem Datenschutzbeauftragten der Einrichtung
Sie verfügen über Kenntnisse der gesetzlichen Grundlagen des Datenschutzes, der Kontrollorgane und ihrer Aufgaben.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.1.9 Grundlagen der staatlichen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland (ca. 16 Stunden)		
Die Schüler sind motiviert.	der Staat - Theorien - Formen - Definition - Aufgaben	unterschiedliche Auffassungen diskutieren (z. B. am Text „Sparta“)
Sie besitzen aktivierte und vertiefte Kenntnisse über die verfassungsrechtlichen Grundlagen der staatlichen Ordnung.	das Grundgesetz (GG) - Geschichte und Entstehung - Aufbau - Grundrechte (Grundrechte im Einzelnen) - organisatorischer Teil • Strukturprinzip der staatlichen Ordnung in der Bundesrepublik Deutschland (Bundesstaat, Demokratie, Rechtsstaat, Sozialstaat)	Arbeit mit dem Gesetzestext; Funktion der Grundrechte; Unterscheidung Bürger- und Menschenrechte; Beziehung herstellen zwischen GG und aktuellen Ereignissen (z. B. Ausländerhass); grundlegende Merkmale der Demokratie und das Gewaltenteilungsprinzip (Legislative, Judikative, Exekutive) sowie weitere Begriffe wie Gesetzmäßigkeitsgrundsatz, Daseinsvorsorge, usw. erarbeiten; Herausarbeiten der Gemeinsamkeiten und Gegensätze von Bundestag und Bundesrat; Überparteilichkeit und Neutralität des Staatsoberhauptes; Aufbau und Zusammensetzung der obersten Bundesorgane erläutern; Einsatz von Schaubildern und Filmmaterial
Sie erkennen die Bedeutung der Verfassung.		
Sie verfügen über Kenntnisse der Bedeutung des Bundestages als oberste Volksvertretung und des Bundesrates als oberste Ländervertretung sowie der Anforderungen an das Bundespräsidentenamt.	• Bundesorgane, ihre Funktionen und Aufgaben (Bundestag, Bundesrat, Bundespräsident, Bundesregierung, Bundesverfassungsgericht)	
Sie können den Stellenwert des Bundeskanzlers und der Abhängigkeiten der Minister erfassen. Sie erfassen die Bedeutung als oberstes gesetzliches Organ.		
Sie kennen die Hauptziele des geltenden Wahlrechts.	Wahlrecht und politische Meinungsbildung - Stellung der Parteien • Parteienspektrum in der Bundesrepublik Deutschland • verfassungsrechtliche Stellungen und Aufgaben der Parteien	Begriffe Mehrheits-, Verhältniswahlrecht, Listenwahl und Persönlichkeitswahl klären; praktische Ausgestaltung des Wahlrechts am Bundeswahlgesetz erläutern; Rolle der Medien; Einbeziehen persönlicher Erfahrungen; Arbeit mit dem GG und Parteiengesetz;
Sie haben Überblick über weitere Formen der politischen Meinungsbildung.		Diskussion zu aktuellen gesundheitspolitischen Themen in verschiedenen Parteiprogrammen
Sie erfassen die Rolle der Parteien in einer Demokratie.		
Sie haben einen Überblick über den Gang der Gesetzgebung im Bund.	Gesetzgebung (Zustimmungs-, Einspruchsgesetze)	Vermittlung von Grundkenntnissen; Bedeutung des Bundesrates bei Zustimmungsgesetzen
Sie erfassen die Regelmechanismen innerhalb der sozialen Ordnung.	soziale Ordnung der Bundesrepublik Deutschland	wechselseitige Abhängigkeit von sozialer Ordnung, Rechts- und Wirtschaftsordnung möglichst an berufsrelevanten Beispielen erklären (Logopäde als Unternehmer)

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über den Gerichts Aufbau.	Gerichtsbarkeit in der Bundesrepublik Deutschland	Darstellen der fünf Gerichtsbarkeiten; Arbeit mit Fallbeispielen
6.1.10 Die Europäische Union (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler haben Einsicht in die Notwendigkeit eines vereinten Europas.	- Entstehungsgeschichte - Organe - Europäischer Gerichtshof - Europarat	historischer Abriss; Maastrichter Beschlüsse schwerpunktmäßig vorstellen; Arbeit mit Schaubildern und Informationsmaterial
6.2 Anatomie und Physiologie (100 Stunden)		
Lernabschnitte		Zeitrichtwerte
1 Zelle und Gewebe		ca. 7 Stunden
2 Fortpflanzung, Wachstum und Reifung		ca. 3 Stunden
3 Organsysteme und deren Funktion		
3.1 Atmungsorgane		ca. 20 Stunden
3.2 Stimm- und Sprechorgane		ca. 15 Stunden
3.3 Sinnessystem		ca. 12 Stunden
3.4 Zentrales und peripheres Nervensystem		ca. 25 Stunden
3.5 Herz-Kreislauf-System		ca. 4 Stunden
3.6 Verdauungssystem		ca. 4 Stunden
3.7 Hormonsystem		ca. 5 Stunden
4 Ganzheitliche Betrachtung des menschlichen Organismus		ca. 5 Stunden
6.2.1 Zelle und Gewebe (ca. 7 Stunden)		
Die Schüler kennen den Bau und die Funktion einer menschlichen Zelle. Sie verstehen die Zelle als kleinste morphologischfunktionelle Einheit des menschlichen Organismus.	- Zellorganellen - Zellarten	Der Einsatz von Anschauungsmaterialien z. B. Modellen, Lehrtafeln, Tafelbildern, Videos, Präparaten usw. sowie die Nutzung weiterer modernster Lernmedien sollte bei der gesamten Lernstoffvermittlung erfolgen.
Sie beherrschen das hierarchische Bauprinzip des menschlichen Organismus und kennen die gewebliche Zusammensetzung der Organe.	Gewebe - Epithelgewebe - Binde- und Stützgewebe - Muskelgewebe - Nervengewebe	
6.2.2 Fortpflanzung, Wachstum und Reifung (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über	- Chromosomen (haploider und diploider Chromosomensatz, Chromosomenaberrationen)	Abstimmung mit dem Lerngebiet Pädiatrie und Neuropädiatrie
- die Grundlagen der Zellteilung und ihre möglichen Störungen. - physiologische Entwicklungs- und Wachstumsprozesse.	- Entwicklungs- und Wachstumsstufen vom Embryo bis zum Greisenalter	
6.2.3 Organsysteme und deren Funktion (ca. 85 Stunden)		
6.2.3.1 Atmungsorgane (ca. 20 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über	- knöcherner Thorax (Sternum, Claviculae, Scapulae, Costae)	Mundhöhle ausführlich unter 6.2.3.2 behandeln; Abstimmung mit den Lerngebieten Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Phoniatrie, Stimmbildung und Phonetik/Linguistik
- den knöchernen Aufbau des Thorax, die Atem- und Atemhilfsmuskulatur sowie das Atemsystem;	- Atemmuskulatur (Mm. intercostales, Diaphragma, Mm. abdominales usw.) - Atemsystem (Nase, Pharynx, Trachea, Bronchialsystem, Lunge, Pleuraverhältnisse)	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
- die physiologische Atemmechanik, Atemarbeit und Atemleistung;	- Mechanismen der Inspiration und Expiration (Abdominal-, Thorakalcosto-, abdominale Atmung; Ruhe- und Phonationsatmung; PV-Diagramm)	Lungenvolumina PV-Diagramm
- die Strömungsgesetze und Atemwiderstände;	- Strömungsgesetze und Atemwiderstände (laminare und turbulente Strömung; elastische und Verformungswiderstände)	
- die Mechanismen der Atemregulation.	- Atemregulation (zentrale Rhythmogenese und Atmungsregulation, Hering-Breuer-Reflex, chemische Regulation)	

6.2.3.2 Stimm- und Sprechorgane (ca. 15 Stunden)

Die Schüler verfügen über reaktivierte und gefestigte allgemeine anatomisch-physiologische Kenntnisse im Kopf-Hals-Bereich und haben sich spezielle Kenntnisse über die Phonation und die Artikulation angeeignet.	anatomisch-physiologische Grundlagen der Phonation und Artikulation - Kehlkopf (Aufbau: Knorpel, Bänder, Gelenke, Muskeln, Gefäße, Innervation, Innenrelief) - Artikulationsorgane (Kaumuskulatur, Mundhöhle, Zunge, obere und untere Zungenbeinmuskulatur, imische Muskulatur) - Mechanismus der Phonation (Bernoulli-Schwingungen, Phonationstheorien, Grundton, Frequenzumfang der menschlichen Stimme, Register, Flüstern, Kehlkopffunktionen) - Mechanismus der Artikulation (Eigenfrequenz, Resonanz; Vokale, Konsonanten, Formanten) - Primärfunktionen des oropharyngealen Systems (Atmung, Nahrungsaufnahme und -zerkleinerung, Schluckakt)	Vermittlung des Themenkomplexes in enger Abstimmung mit den Lerngebieten Kieferorthopädie, Kieferchirurgie, Phoniatrie, Phonetik/Linguistik, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Logopädie und Stimm-bildung; Geschlechtsunterschiede und Altersveränderungen ansprechen; darstellen des Aufbaus sowie der Primär- und Sekundärfunktionen des oropharyngealen Systems Ausführungen zur Atmung siehe unter 6.2.3.1
--	---	---

6.2.3.3 Sinnessystem (ca. 12 Stunden)

Die Schüler besitzen einen Überblick über das Sinnessystem.	Sinnesorgane	Vermittlung orientierender Kenntnisse über den Bau und die Funktion;
Sie haben allgemeine Kenntnisse über Bau und Funktion der Sinnesorgane.	- Sehorgan - Geruchs- und Geschmacksorgan - Tastorgane - propriozeptives System	Umfang ergibt sich hinsichtlich logopädischer Relevanz
Sie kennen die Teile des peripheren und zentralen Hör- und Gleichgewichtsorgans.	- Hör- und Gleichgewichtsorgan • embryonale Entwicklung • Auris externa • Auris media	Abstimmung mit den Lerngebieten Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde sowie Audiologie und Pädaudiologie

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	• Auris interna • Hörbahn • Schallübertragung und Schallverarbeitung (Helmholtzsche Hörtheorie) • Gleichgewichtsbahn (Bildung und Leitung des Aktionspotentials im Gleichgewichtsorgan)	
6.2.3.4 Zentrales und peripheres Nervensystem (ca. 25 Stunden)		
Die Schüler erfassen die anatomischen Voraussetzungen des zentralen Nervensystems (makroskopische Anatomie der Hirnabschnitte).	Gehirn - Telencephalon - Diencephalon - Mesencephalon - Metencephalon - Myelencephalon - Basalganglien - Hüllen und Gefäße des ZNS	Vertiefung in nachfolgenden Lerngebieten wie z. B. Neurologie und Psychiatrie sowie Aphasieologie
Sie besitzen anatomische Kenntnisse über das Rückenmark und die Bahnsysteme.	Rückenmark - Rückenmark im Querschnitt - sensible und motorische Nervenbahnen	
Sie verfügen über erweiterte anatomische Vorkenntnisse und spezielle Kenntnisse über das periphere und vegetative Nervensystem.	peripheres und vegetatives Nervensystem - Hirnnerven - Spinalnerven - periphere Nerven (Übersicht) - Sympathikus, Parasympathikus	
Sie kennen die Phänomene der Erregungsphysiologie.	Funktionen des zentralen Nervensystems - Ruhepotential und Aktionspotential - saltatorische Leitung des Aktionspotentials - Neuronenverbände - Reflexe	
6.2.3.5 Herz-Kreislauf-System (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler besitzen reaktivierte anatomische Vorkenntnisse und erweiterte Kenntnisse über die verschiedenen Gefäßabschnitte des Blutkreislaufs, den Gefäßbau sowie die Topographie und den Bau des Herzens.	Gefäßlehre - allgemeine Gefäßlehre - Blut- und Lymphgefäßsystem; - Aufbau des Herzens (Wandschichten des Herzens, Lage und Form der Herzklappen, Verteilung der Arbeits- und der spezifischen Herzmuskulatur)	Diskussion von Fallbeispielen zum Verständnis von Störungen der Blutzirkulation und Blutdruckregulation
Sie besitzen die Fähigkeit zur Interpretation der Blutdruckregulation am Beispiel von Regelkreisen.	Herz-Kreislauf-Funktion (myogene und chemische Gefäßregulation, Systemregulation des Blutdrucks unter Einbeziehung nervaler und humoraler Komponenten)	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.2.3.6	Verdauungssystem (ca. 4 Stunden)	
Die Schüler haben Kenntnisse über die Organe des Gastrointestinaltrakts und deren Funktion.	Bau und Funktion der Verdauungsorgane (Ösophagus, Gaster, Duodenum, Jejunum, Ileum, Caecum, Colon, Rektum, Hepar, Pankreas)	Begrenzung auf die Nahrungsaufnahme, -zerkleinerung und -weiterleitung
Sie verfügen über spezielle Kenntnisse zum ersten Verdauungsabschnitt und über allgemeine Kenntnisse zum weiteren Trakt.		
6.2.3.7	Hormonsystem (ca. 5 Stunden)	
Die Schüler besitzen allgemeine Grundkenntnisse über das Hormonsystem und können die enge Wechselbeziehung zwischen diesem und dem Nervensystem erfassen.	Hormondrüsen und deren Hormone in ihrer Wirkungsweise - Hypothalamus, Hypophyse, Epiphyse, Schilddrüse, Nebennieren - Keimdrüsen	Darstellung der Zusammenhänge von Geschlechts-, Stimm- und Persönlichkeitsentwicklung; Anwendung des Regelkreisprinzips am Beispiel ausgewählter endokriner Krankheitsbilder
6.2.4	Ganzheitliche Betrachtung des menschlichen Organismus (ca. 5 Stunden)	
Die Schüler haben einen Überblick über die Regulationsebenen des Organismus und können die Zusammenhänge und das Zusammenwirken der Organsysteme erkennen.	Systematisierung und Klassifizierung der Stoffgebiete	Reaktivierung und Vertiefung von Einsichten in die dynamische Gesundheits-Krankheits-Beziehung und der sich daraus ableitenden Prophylaxe
6.3	Pathologie (ca. 40 Stunden)	
Lernabschnitte		Zeitrichtwerte
1 Krankheit und Krankheitsursachen		ca. 5 Stunden
2 Reaktionen, Entzündungen		ca. 4 Stunden
3 Wachstums- und Stoffwechselstörungen von Zellen und Gewebe		ca. 3 Stunden
4 Tumoren		ca. 3 Stunden
5 Kreislaufstörungen		ca. 3 Stunden
6 Wunden, Blutungen, Wundheilung		ca. 2 Stunden
7 Erste Hilfe		
7.1 Allgemeines Verhalten bei Notfällen		ca. 4 Stunden
7.2 Lebensbedrohliche Zustände		ca. 3 Stunden
7.3 Erste Hilfe bei Blutungen		ca. 2 Stunden
7.4 Maßnahmen der Ersten Hilfe bei Wunden		ca. 3 Stunden
7.5 Gelenk- und Knochenverletzungen		ca. 2 Stunden
7.6 Vergiftungen und Verätzungen		ca. 2 Stunden
7.7 Verletzungen durch thermische Einwirkungen		ca. 2 Stunden
7.8 Maßnahmen bei weiteren Notfällen		ca. 2 Stunden
6.3.1	Krankheit und Krankheitsursachen (ca. 5 Stunden)	
Die Schüler sind vertraut im Umgang mit den Grundkategorien Gesundheit, Krankheit und weiteren Termini.	Gesundheit und Krankheit - Definitionen Gesundheit/Krankheit weitere Grundbegriffe (Morbidity, Mortalität, Letalität, Inzidenz, Prävalenz)	Einführung in das Lerngebiet; Diskussion über die WHO-Definition von Gesundheit Erarbeiten weiterer wesentlicher Begriffe

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie erfassen Gesundheit und Krankheit als zwei alternative Erscheinungsformen des Lebens.	grundlegende Prinzipien des gesunden Lebens - Ausbildung differenzierter Strukturen - Prinzipien der biologischen Ordnung und der Regulation - biologische Reagibilität - Adaptation - Disposition - Konstitution	Erläuterung der Grundlagen von Leben und Gesundheit
Sie haben Grundkenntnisse über die Krankheit als komplexes Geschehen.	Krankheit - als körperliche Funktionsstörung - als Störung des psychischen Gleichgewichts	Krankheitsbegriff; auf die Wechselwirkung von Struktur und Funktion hinweisen; Erläuterung der Begriffe Epidemie, Endemie, Pandemie; Diskussion
Sie erkennen Krankheit als Störung der biologischen Wirkprinzipien, als Atypien struktureller und funktioneller Art.	- in Abhängigkeit von sozialen Bedingungen	
Sie kennen Krankheit als individuelles Phänomen und als Massenerscheinung.	Krankheitserkennung - klinische Methoden - paraklinische Methoden	Vorstellen der wichtigsten Methoden zur Klärung einer Diagnose
Sie haben Kenntnisse über die wichtigsten Nachweismethoden von Krankheiten.		
Sie kennen die wesentlichen Ursachenkomplexe für die Krankheitsentstehung.	Ätiologie und Pathogenese - Ätiologie • äußere Krankheitsursachen (belebte, unbelebte) • innere Krankheitsursachen (genetische Faktoren, Disposition, Konstitution) • soziale Krankheitsursachen - formale Pathogenese	Anpassungsfähigkeit und Umwelteinflüsse; Problem der Polyätiologie ansprechen; Hinweise auf das Infektionsschutzgesetz; Aufzeigen weiterer Schutzmaßnahmen (Arbeitsschutz, Strahlenschutz etc.); Arbeit mit Fallbeispielen; Einbeziehen eigener Erfahrungen der Schüler
Sie erkennen die Zusammenhänge von Krankheitsentstehung und der jeweiligen Körperreaktion.	Krankheitszeichen - Symptome (objektive, subjektive, spezifische, unspezifische) - Syndrom	Zuordnung von Krankheitsbildern; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie kennen die Verlaufsformen von Krankheiten und Grundformen der Krankheitsstadien.	Krankheitsverlauf - Verlaufsformen (akut, subakut, chronisch, progredient, rezidivierend) - Krankheitsstadien (Latenz-, Prodromal-, Manifestations-, Rekonvaleszenzstadium)	Variabilität des Ausprägungsgrades der allgemeinen Krankheitsstadien unterstreichen (Stärke, Zeitdauer); fließende Übergänge zwischen allen Verlaufsformen hervorheben
Sie besitzen einen Überblick über mögliche Ausgänge von Krankheiten.	Krankheitsausgänge und -folgen - Restitutio ad integrum - Chronizität - Defektheilung - Tod	Erläutern verschiedener Krankheitsbilder hinsichtlich, Ätiologie, Symptomatik, Krankheitsverlauf und -ausgang
	Prognose	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.3.2 Reaktionen, Entzündungen (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler kennen	die Entzündung	Reaktivieren von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Anatomie und Physiologie;
- die Elementarantwort der Zelle bei Schädigung sowie die spezifischen Abwehrmechanismen des Organismus	- Definition	strukturelle und funktionelle Pathophysiologie der Entzündung; Arbeit mit Anschauungsmaterial; konkrete Beispiele erarbeiten lassen
- Ursachen, Pathogenese, Symptomatik, Formen, Einteilungsmöglichkeiten, Phasen und Folgen einer Entzündung.	- Ursachen (mechanische Einflüsse, physikalische Faktoren, Mikroorganismen, autogene Reize)	
	- lokale Entzündungszeichen	
	- Ablauf der lokalen Entzündungsreaktion und Kardinalsymptome	
	- allgemeine Reaktion des Organismus	
	- Einteilung der Entzündungen	
	- Folgen	
6.3.3 Wachstums- und Stoffwechselstörungen von Zellen und Gewebe (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zur Ätiologie, Pathogenese und den Folgen.	- Regeneration und Degeneration	siehe auch Lerngebiet Anatomie und Physiologie;
	• Definitionen	Wachstum als Anpassungsreaktion (Kompensation, Adaptation); Arbeit mit Beispielen;
Sie besitzen die Fähigkeit zur Definition und Abgrenzung der verschiedenen Termini.	• Formen der Regeneration (physiologische, adaptive, kompensatorische)	Einsatz von Anschauungsmaterial; Hinweis auf altersbedingte Störungen
	• Einflussfaktoren	
	- Hypertrophie und Hyperplasie	
	- Atrophie	
	- Nekrose (Nekroseformen)	
6.3.4 Tumoren (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler besitzen die Fähigkeit zur Abgrenzung des Tumors gegenüber allen anderen Wachstumsformen und können zwischen benignen und malignen Formen differenzieren.	- morphologische Grundlagen des autonomen Wachstums	Besonderheiten des Tumorwachstums herausarbeiten;
	- kausale Genese	Übersicht über die wichtigsten endogenen und exogenen Ursachen;
	- Klassifikation von Tumoren nach	Darstellen der Unterschiede im Verhalten gut- und bösartiger Tumoren;
	• biologischem Verhalten	Aufzeigen möglicher Verschleppungswege von Tumorzellen;
	• histogenetischer Systematik	Arbeit mit Fallbeispielen
	• klinischem und pathologischem Befund (z. B. TNM-Klassifikation)	(näheres Eingehen auf Tumoren der Luftwege und des Nervensystems);
Sie besitzen einen Überblick über die wichtigsten ätiologischen Faktoren der Krebsentstehung und kennen die Folgen von infiltrativem und destruierendem Wachstum sowie der Metastasierungstypen.	- Arten der Metastasierung	Ausführungen zur Epidemiologie und Geschlechterverteilung bei ausgewählten malignen Tumoren; Stellenwert der Prophylaxe
6.3.5 Kreislaufstörungen (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler erkennen den Zusammenhang von Lebensweise, Ursachen, Symptomen und Folgen bei ausgewählten Störungsbildern.	- Hyper- und Hypotonie	Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Anatomie und Physiologie;
	- Angina pectoris	Darstellung von Ursachen, Pathogenese und ggf. Organmanifestation;
	- Herzinsuffizienz	Eingehen auf die Erkrankungen, dabei besondere Berücksichtigung berufsrelevanter Störungen wie z. B. zerebro-vaskulärer Störungen;
	- Hyperämie	Einsatz von Bildmaterial und Videos
	- Ischämie	
	- Thrombose	
	- Embolie	
	- Infarkt	
	- Arteriosklerose	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.3.6	Wunden, Blutungen, Wundheilung (ca. 2 Stunden)	
Die Schüler besitzen Kenntnisse über Ursachen, Wesen, Art und Komplikationen von Wunden.	Wunden und Wundheilung - Ursachen, Symptome und Folgen verschiedener Gewalteinwirkung - ungestörte Wundheilung • Faktoren • Phasen - Störungen der Wundheilung	Einbeziehen individueller Kenntnisse der Schüler; Charakteristik der Wunden; Ablauf der ungestörten Wundheilung erarbeiten; Ursachen und Formen von Wundheilungsstörungen darstellen
Sie sind fähig zur Unterscheidung der Wundheilung von der physiologischen Regeneration .		
Sie kennen die Ursachen, Pathogenese, Formen, Symptome und Folgen von Blutungen.	Blutungen - Ursachen - Einteilungsmöglichkeiten - Folgen von Blutungen	Reaktivieren von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Anatomie und Physiologie; Darstellen der vielgestaltigen kausalen Genese von Blutungen; bei der Erarbeitung der Folgen von Blutungen besonders auch berufsrelevante Beispiele heranziehen; Bezug zur Ersten Hilfe (6.3.7.3 und 6.3.7.4); Hinweise zu Unfällen und dem Stellenwert der Unfallprophylaxe
Sie erfassen den Zusammenhang von Ausmaß-Lokalisation und Blutungsfolgen.		
6.3.7	Erste Hilfe (ca. 20 Stunden)	
6.3.7.1	Allgemeines Verhalten bei Notfällen (ca. 4 Stunden)	
Die Schüler erkennen die Pflicht zur Hilfeleistung.	- Ziele der Ersten Hilfe - Grundsätze des Verhaltens des Ersthelfers	Eingehen auf: - Folgen der unterlassenen Hilfeleistung
Sie verfügen über Kenntnis der Bedeutung der Ersten Hilfe.	- Rettungskette - allgemeine Maßnahmen der Ersten Hilfe	- Umfang der Ersten Hilfe - materielle Voraussetzungen (Demonstration)
Sie besitzen Verantwortungsbewusstsein für das Leben anderer und das eigene Leben.	• Bergung • Beurteilung, Einstufung • Versorgung • Lagerung • Transport	- Notruf - grundsätzliche Maßnahmen der Ersten Hilfe • Bergung (Selbstschutz, Rettung aus dem Kfz) • Kontrolle und Beurteilung des/der Geschädigten • Lagerung nach Verletzungsart • Hilfeleistung nach Art und Dringlichkeit • Transport (Transportfähigkeit, -voraussetzungen, -arten)
Sie haben gesicherte Kenntnisse als Voraussetzung für Entscheidungen im Rahmen der Ersten Hilfe.		Demonstration und praktische Übungen; Arbeit mit Fallbeispielen; Einsatz von Anschauungsmaterial (Folien, Poster, Filme usw.)
6.3.7.2	Lebensbedrohliche Zustände (ca. 3 Stunden)	
Die Schüler kennen die Anzeichen, die den Ausfall lebenswichtiger Funktionen signalisieren.	Begriffserklärung Schock und Maßnahmen der Ersten Hilfe - Schock • Ursachen • Schockphasen	Klärung der Begriffe klinischer und biologischer Tod Vielfalt schockauslösender Faktoren herausarbeiten; Darstellung des Wesens und der Symptome des Schocks;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für die optimale Erstversorgung lebensbedrohlich Geschädigter am Unfallort.	- Erste Hilfe bei Schockgefährdung und Schock • Schockprophylaxe • Maßnahmen bei Schockzuständen	Maßnahmen der Ersten Hilfe wie Kreislaufstabilisierung, Kontrolle der Lebensfunktionen, psychische Betreuung, Schmerzlinderung etc. herausarbeiten; Arbeit mit Fallbeispielen; Demonstration und praktische Übungen
Sie sind fähig zur Anleitung weiterer Helfer und zur Koordinierung erforderlicher Maßnahmen.	Atemstillstand und Maßnahmen der Ersten Hilfe - Ursachen, Symptome und Folgen eines Atemstillstandes - Überprüfung der Atmung - Maßnahmen der Ersten Hilfe • Vorbereitung zur Atemspende • Formen der Atemspende	Erarbeitung möglicher Folgen eines Atemstillstandes; Demonstration und Übungen zur Atemkontrolle; Einsatz von Anschauungsmaterial und Training am Übungsmodell
	Herzstillstand und Maßnahmen der Ersten Hilfe - Symptome des Herzstillstandes - Methoden zur Überprüfung der Herzaktivität - Maßnahmen der Ersten Hilfe • Voraussetzungen für eine Herzdruckmassage • Durchführung der Herzdruckmassage • Herz-Lungen-Wiederbelebung	Demonstration der richtigen Lagerung und Techniken der Atemspende; praktische Übungen Einbeziehen vorhandenen Wissens über Lage, Bau und Funktion des Herzens; Einbeziehung von Eigenbeobachtungen; Erarbeitung folgender Schwerpunkte: • Vorbereitung des Geschädigten • Körperhaltung und Arbeitstechnik des Helfers • Wechselrhythmus Atemspende/ Herzdruckmassage; 1 bzw. 2 Helfer • Besonderheiten bei Säuglingen und Kleinkindern • Stellenwert der Atemspende bei der Wiederbelebung
		Einsatz von Anschauungsmaterial, besonders Lehrfilmen bzw. Videos; Demonstration und Übung der Herzdruckmassage am Phantom

6.3.7.3 Erste Hilfe bei Blutungen (ca. 2 Stunden)

Die Schüler haben reaktivierte und erweiterte Kenntnisse über Blutungen.	Arten der Blutungen	Einbeziehen von Wissen aus 6.3.6
Sie besitzen die Fähigkeit zur exakten Beobachtung und zum Erkennen von Blutungen nach ihren Erscheinungsmerkmalen.	Erste Hilfe bei: - starken äußeren Blutungen - inneren sichtbaren Blutungen - inneren unsichtbaren Blutungen	Erarbeitung der spezifischen Versorgung arterieller, venöser und Kapillarblutungen; besonders eingehen auf das sachgemäße Anlegen eines Druckverbandes; ständige Verbindung zu den Themen „Wunden und Wundversorgung“ sowie „Lebensbedrohliche Zustände“ herstellen;
Sie beherrschen die Fertigkeiten zur Blutstillung und zum Anlegen von Verbänden.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
		Formen der Krankenbeobachtung wie Beurteilung der Pulsqualität, Veränderung der Hautfarbe, Temperatur etc. wiederholen und festigen; Merkmale der inneren unsichtbaren Blutungen und die besondere Bedeutung herausarbeiten; besondere Bedeutung der Methoden der Krankenbeobachtung (z. B. Stadien der Benommenheit, Bauchdeckenspannung) hervorheben; Arbeit mit Fallbeispielen; Einsatz von Anschauungsmitteln; Demonstration und Übungen
6.3.7.4 Maßnahmen der Erste Hilfe bei Wunden (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler verfügen über reaktivierte und erweiterte Kenntnisse über Wunden.	Wunden und Wundversorgung	Einbeziehen von Wissen aus 6.3.6
Sie sind fähig zur Einschätzung von Wunden.	- Wesen und Arten der Wunden • Einteilung der Wunden nach dem Schweregrad der Verletzung • Unterteilung der Wunden nach der Entstehungsart • Beurteilung des Wundzustandes - Wundkomplikationen • Wundinfektion • Verletzung anderer Gewebe und Organe • Intoxikation	Anschauungsmaterial zur realistischen Wunddarstellung
Sie haben einen Überblick über mögliche Wundkomplikationen.	- Wundversorgung • Grundsätze der Wundversorgung • Schockprophylaxe und -bekämpfung • lokale Wundversorgung - Verbandsmaterialien und Verbände	Aufzeigen der Tetanusimmunisierung als wesentliche Form der Prophylaxe
Sie besitzen Kenntnisse und Fertigkeiten zur sachgemäßen Wundversorgung und wundgerechten Lagerung.		Erarbeiten der Grundsätze einschließlich der Beobachtung, Lagerung und psychischen Betreuung des Geschädigten; Gewährleistung der ärztlichen Versorgung; Demonstration und praktische Übungen: • richtige Nutzung • sachgemäße Polsterung • Anlegen einer Schiene • Einsatz provisorischer Materialien
6.3.7.5 Gelenk- und Knochenverletzungen (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler kennen Ursachen, Symptome und Arten von Gelenkverletzungen und Möglichkeiten einer schonenden Ruhigstellung.	Gelenkverletzungen	Einbeziehen evtl. persönlicher Erfahrungen der Lernenden;
Sie haben Kenntnisse über die Unzulässigkeit von Manipulationen des Ersthelfers und die Notwendigkeit einer ärztlichen Untersuchung.	- Ursachen - Arten der Gelenkverletzungen • Distorsion und ihre Symptome • Luxation und ihre Symptome - vorläufige Versorgung von Gelenkverletzungen, einschließlich der Ruhigstellung	vorbeugenden Unfallschutz hervorheben

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie beherrschen die Fähigkeit zum Erkennen sicherer und unsicherer Frakturssymptome.	Knochenverletzungen - Kontusionen - Frakturen • unvollständige Frakturen und ihre Symptome • vollständige Frakturen und deren Symptome	Vermittlung stark systematisierten Übersichtswissens
Sie sind mit der Reihenfolge der einzuleitenden Maßnahmen unter Berücksichtigung einer sachgemäßen Ruhigstellung vertraut.	- Maßnahmen der Ersten Hilfe • Grundsätze der Beobachtung, Schockprophylaxe und -bekämpfung bei Knochenverletzungen • vorläufige Versorgung von Frakturen	praktische Übungen: • zum Erkennen sicherer und unsicherer Frakturzeichen • zur sachgemäßen vorläufigen Versorgung der verschiedenen Frakturarten, einschließlich Ruhigstellung und
Sie beherrschen die der Verletzungsart entsprechenden erforderlichen Lagerungs- und Transportbesonderheiten.	• Grundsätze der Ruhigstellung • Lagerung und Transport bei Schädel- und Schädelbasisfraktur, Rippen-, Becken- und Wirbelsäulenfraktur	• zur Einleitung der Schockprophylaxe bzw. -bekämpfung
6.3.7.6 Vergiftungen und Verätzungen (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler kennen die Merkmale und Gefahren von Vergiftungen und Verätzungen.	Verätzungen - Ursachen und Symptome bei • äußeren Verätzungen (Haut, Auge) • inneren Verätzungen (Mundhöhle, Speiseröhre, Magen, Darm) - Maßnahmen der Ersten Hilfe	Arbeit mit Fallbeispielen; wichtige prophylaktische Grundsätze herausarbeiten (Aufbewahrung von Säuren oder Laugen in Flaschen, Gefahr der Verwechslung mit Getränkeflaschen, Sicherung des Zugriffs durch Kinder usw.)
Sie sind zur exakten Begründung von Hilfemaßnahmen fähig.	Vergiftungen - Gift und seine Wirkung im menschlichen Organismus - Vergiftungen über das Verdauungssystem • Vergiftungsarten (Ursachen, Wirkungen, Symptome) • Maßnahmen der Ersten Hilfe - Vergiftungen über das Atemsystem und die unverletzte Haut • Vergiftungsarten • Ursachen und Symptome • Maßnahmen der Ersten Hilfe	Bekannt machen mit Schutzbestimmungen zur Einschränkung der Gefahr chemischer Unfälle besonderer Hinweis auf die Aspirationsgefahr bei Erbrechen im Stadium der Bewusstlosigkeit, Ableitung des richtigen Vorgehens Prinzip der Ersten Hilfe bei äußeren und inneren Verletzungen mit Ätz- oder Giftstoffen vergleichen
6.3.7.7 Verletzungen durch thermische Einwirkungen (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über Schädigungen durch thermische Einwirkungen.	Verbrennungen - Ursachen - lokale und allgemeine Folgen - Maßnahmen der Ersten Hilfe	Arbeit mit Fallbeispielen; Einsatz von Anschauungsmitteln; Hinweise auf Komplikationen wie z. B. Verbrennungsschock, Intoxikation und Infektionen
Sie sind zum schnellen Erkennen von Gefahrensituationen befähigt.		
Sie besitzen die Fähigkeit zur Einschätzung des Wesens und der Folgen von thermischen Schädigungen sowie zum richtigen Handeln.	Hitzschlag - Ursachen - Symptome - Maßnahmen der Ersten Hilfe	Hinweis auf die Organisation des Brandschutzes sowie die relevanten Alarmpläne (Schule, Praktikumseinrichtungen etc); Einbeziehen evtl. eigener Erfahrungen der Lernenden

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	Sonnenstich - Ursachen - Symptome - Maßnahmen der Ersten Hilfe Erfrierungen - Ursachen - Symptome - Maßnahmen der Ersten Hilfe Unterkühlung - Ursachen und begünstigende Faktoren - Symptome - Maßnahmen der Ersten Hilfe	Bedeutung und Möglichkeiten der Prophylaxe erarbeiten
6.3.7.8	Maßnahmen bei weiteren Notfällen (ca. 2 Stunden)	
Die Schüler besitzen einen Überblick über Stromeinwirkungen und ihre Folgen. Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit des Selbstschutzes des Ersthelfers.	Elektrounfälle und Maßnahmen der Ersten Hilfe - Unfälle durch elektrischen Strom (Niederspannung, Hochspannung; Ursachen und Auswirkungen) - Maßnahmen der Ersten Hilfe	physikalische Kenntnisse der Lernenden einbeziehen; Einsatz von Anschauungsmaterial; Eingehen auf die Besonderheiten der Bergung (Selbstschutz); Erarbeiten der Reihenfolge der Erste-Hilfe-Maßnahmen in Abhängigkeit von der jeweiligen Situation
Sie sind befähigt zur schnellen und sicheren Einschätzung entstandener Unfallsituationen sowie zur sachkundigen Hilfeleistung. Sie kennen die Kompetenzen eines Ersthelfers und die Konsequenzen einer Befugnisüberschreitung bei der vorläufigen Versorgung.	Maßnahmen der Ersten Hilfe bei Verletzungen der Sinnesorgane und des Rachens durch Fremdkörper - Verletzungen des Auges • Ursachen • Fremdkörper unter den Lidern • Fremdkörper im Augapfel • Maßnahmen der Ersten Hilfe - Fremdkörper in der Nase und Maßnahmen der Ersten Hilfe - Fremdkörper im Ohr und Verhalten des Ersthelfers - Fremdkörper im Mund- und Rachenraum - Verhalten bei Fremdkörpern in der Luftröhre Maßnahmen bei Insektenstichen	besondere Bedeutung der Verletzung von Sinnesorganen erarbeiten Notwendigkeit von Unfallschutzmaßnahmen im Kindesalter sowie die Einhaltung von Arbeitsschutzanordnungen diskutieren Grundsätze des Verhaltens bei eingedrungenen Fremdkörpern erarbeiten Demonstration und praktische Übungen zur Durchführung einer Augenspülung sowie zum Anlegen eines Augenschutzverbandes Möglichkeiten der Schmerzlinderung darstellen; besonders Eingehen auf das Verhalten des Ersthelfers bei Ersticken Gefahr durch Stiche in die Mund- und Rachenschleimhaut

6.4 Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde (60 Stunden)

Lernabschnitte

1	Erkrankung des Hörorgans	ca. 10 Stunden
2	Erkrankungen der Nase und Nasennebenhöhlen	ca. 10 Stunden
3	Erkrankungen des Rachens	ca. 5 Stunden
4	Erkrankungen der Mundhöhle und der Speicheldrüsen	ca. 10 Stunden
5	Erkrankungen des Kehlkopfes und der unteren Luftwege	ca. 12 Stunden
6	Erkrankungen des Halsbereiches	ca. 5 Stunden
7	Störungen des Schluckvorganges	ca. 8 Stunden

Zeitrichtwerte

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.4.1 Erkrankungen des Hörorgans (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Erkrankungen	Erkrankungen des äußeren Ohres	Vermittlung des gesamten Themenkomplexes in enger Verbindung mit den Lerngebieten Anatomie und Physiologie sowie Pathologie
- des äußeren Ohres, ihre Folgen und Therapiemöglichkeiten;	- Missbildungen - Zerumen - Fremdkörper - Entzündungen - Verletzungen - Tumoren	
- des Mittel- und Innenohres, mögliche Komplikationen und Therapiemöglichkeiten.	Erkrankungen des Mittel- und Innenohres	Hervorheben der Besonderheiten der Otitis media im Kindesalter, Hinweis auf die Gefahr der passageren Schwerhörigkeit; Begründung der Prophylaxe von Ohrenentzündungen, z. B. Mumps-schutzimpfung; Aufzeigen der Möglichkeiten zur Vermeidung chronischer Entzündungen
Sie erkennen komplexe Zusammenhänge mit Erkrankungen der Nase, der Nasennebenhöhlen und des Nasenrachens.	- Missbildungen - Ventilations- und Drainagestörungen der Mittelohrräume - akute und chronische Entzündungen einschließlich Komplikationen - Otosklerose	
Sie besitzen die Fähigkeit zur Ableitung von möglichen Auswirkungen auf die Sprache und das Sprechen.	- Hörsturz - Morbus Meniere - ototoxische Medikamente - Traumafolgen	Erläutern lebensgefährlicher Komplikationen in ihrem Entstehungsmechanismus; Hinweise auf Operationen zur Heilung und Funktionswiederherstellung
Sie erfassen die Notwendigkeit und Bedeutung prophylaktischer Maßnahmen.	- Tumoren einschließlich der Tumoren des inneren Gehörganges und Kleinhirnbrückenwinkels - angeborene und erworbene Hörstörungen	
Sie besitzen Grundkenntnisse über Ursachen, Arten und Folgen von Hörstörungen.	- mit Hörstörungen einhergehende Syndrome - Vestibulariserkrankungen	Abstimmung mit den Lerngebieten Audiologie und Pädaudiologie, Pädiatrie und Neuropädiatrie
Sie haben einen Überblick über die Ursachen, Symptome und diagnostischen Möglichkeiten von Gleichgewichtsstörungen.	• Ursachen und Symptome (Morbus Meniere, Entzündungen, traumatische und toxische Schädigungen, Tumoren, zentrale Gleichgewichtsstörungen)	Darstellung der Physiologie des Vestibularapparates, darauf aufbauend informative Vermittlung verschiedener Methoden zur Untersuchung der Vestibularfunktion
Sie kennen die Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie und Folgen von Fazialispareesen.	• Diagnostik - Fazialispareesen (durch bakterielle, virale, toxische und traumatische Erkrankungen sowie Tumoren)	Darstellung der ein- und doppel-seitigen Funktionsausfälle des Gesichtsnerven im Hinblick auf das Sprechen und den Schluckvorgang
6.4.2 Erkrankungen der Nase und Nasennebenhöhlen (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler können die oberen Luftwege als einheitliches Funktionssystem erfassen und kennen Ursachen, Symptome sowie therapeutische Möglichkeiten von Nasen- und Nasennebenhöhlenerkrankungen.	- Missbildungen - akute und chronische Entzündungen - Schleimhautallergien - Nasenbluten - Fremdkörper	nähere Erläuterung der Tubenfunktion Bedeutung der Infektprophylaxe hervorheben;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie können die Auswirkungen dieser Erkrankungen auf die Artikulation, den Stimmklang und das Gehör erkennen.	- Choanalatresien - Tumoren - Verletzungen - Frakturen	Hinweis auf die Verhütung von Komplikationen „banaler Infekte“
6.4.3 Erkrankungen des Rachens (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler kennen Ätiologie, Symptomatologie und Therapie von Erkrankungen des Rachenraumes.	- Missbildungen - Entzündungen - Rachen- und Gaumenmandelhyperplasien - Verletzungen - Tumoren und deren operative Folgezustände	Ableitung von Folgen anhand einfacher Fallbeispiele
Sie sind fähig zur Ableitung von Auswirkungen auf den Atem-, Schluck- und Sprechvorgang sowie den Stimmklang.		
6.4.4 Erkrankungen der Mundhöhle und der Speicheldrüsen (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler kennen Ätiologie, Symptomatologie und Therapiemöglichkeiten.	Erkrankungen der Mundhöhle	Reaktivieren von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie sowie Abstimmung mit den Inhalten des Lerngebietes Kieferorthopädie, Kieferchirurgie;
Sie sind fähig zur Beurteilung dieser Erkrankungen im Zusammenhang mit Artikulations- und Schluckstörungen.	- Entzündungen - Verletzungen - Gaumenmissbildungen - Lähmungen und Tumoren der Zunge und deren operative Folgezustände - angeborene und erworbene Lähmungen des Gaumensegels - Zahnerkrankungen - Zahnstellungs- und Bissanomalien	Bedeutung der Mundhygiene und regelmäßigen Gebisskontrolle erörtern
Sie sind für prophylaktische Maßnahmen sensibilisiert.		
Sie haben Kenntnisse über Neubildungen und deren Therapie	Erkrankungen der Speicheldrüsen	Vermittlung informativ
Sie erfassen mögliche Auswirkungen auf die Artikulation und den Schluckakt.	Tumoren der Kopfspeicheldrüsen und ihre Therapie	
6.4.5 Erkrankungen des Kehlkopfes und der unteren Luftwege (ca. 12 Stunden)		
Die Schüler verfügen über reaktivierte, erweiterte und gefestigte Kenntnisse.	Erkrankungen des Kehlkopfes	Die Kehlkopfbewegungen beim Schluckakt und bei der Atmung sowie die normalen Phonationsbewegungen sollten unter funktionellen Aspekten und praktischen Bezügen wiederholt und mögliche Ursachen für Abweichungen, deren Folgen und therapeutische Möglichkeiten erarbeitet werden.
Sie besitzen Kenntnisse über Larynxerkrankungen und sind fähig zur Ableitung und Beurteilung von Folgen für die Atem- und Stimmfunktion sowie den Schluckakt.	- Missbildungen - Entzündungen (akute, chronische, spezifische, unspezifische) - organische Stimm lippenveränderungen - Lähmungen - Traumen - Tumoren und deren operative Folgezustände	
Sie kennen die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten.	- Paresen des N. vagus bzw. seiner Äste - Diagnostik - konservative und operative Therapie	Untersuchungsmethoden darstellen und demonstrieren
Sie besitzen Kenntnisse über	Erkrankungen der unteren Luftwege	individuelle und gesellschaftliche Bedeutung der Infektionen der unteren Luftwege und negative Folgen des Nikotinmissbrauchs diskutieren
- ausgewählte Erkrankungen im Bereich der unteren Luftwege; - die Indikation zur Tracheotomie; - Kanülenprobleme.	- Entzündungen - Verletzungen - Fremdkörper - Geschwülste - Stenosen	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.4.6 Erkrankungen des Halsbereiches (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler kennen die wichtigsten Krankheitsbilder zur Ableitung möglicher funktioneller Beeinträchtigungen.	Erkrankungen des Halses und der Speicheldrüsen - Fisteln - Zysten - Erkrankungen der großen Kopfspeicheldrüsen - Halslymphknotenveränderungen - Strumen - Tumoren - Ösophaguserkrankungen (Entzündungen, Fremdkörper, Verletzungen, Stenosen, Divertikel, Tumoren)	Herausstellen der funktionellen Gesichtspunkte
Sie verfügen über Kenntnisse der Therapiemöglichkeiten und Prognose.		
6.4.7 Störungen des Schluckvorganges (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler besitzen ein umfassendes Wissen über den normalen und pathologischen Schluckakt sowie die Diagnostik und Therapiemöglichkeiten bei Schluckstörungen aus HNO-ärztlicher Sicht.	physiologischer Schluckvorgang gestörter Schluckvorgang (Erkrankungen der Mundhöhle, der Zähne, des Rachens und Larynx mit Auswirkungen auf den Schluckvorgang)	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie und Kieferorthopädie, Kieferchirurgie; Darstellung der Auswirkungen von Schluckstörungen auf den Organismus; Arbeit mit Fallbeispielen; Einsatz von Anschauungsmaterial (Dias, Videos usw.); Einbeziehung eigener Erfahrungen von Schülern
6.5 Pädiatrie und Neuropädiatrie (80 Stunden)		
Lernabschnitte		Zeitrichtwerte
1 Vererbung und Evolution		ca. 8 Stunden
2 Normale und pathologische Entwicklung in der prä-, peri- und postnatalen Phase		ca. 23 Stunden
3 Stoffwechselerkrankungen und endokrine Störungen		ca. 6 Stunden
4 Erkrankungen der Atmungs- und Kreislauforgane		ca. 8 Stunden
5 Infektionskrankheiten einschließlich Hygiene im klinischen und außerklinischen Bereich		ca. 6 Stunden
6 Impfung und Impfschäden		ca. 3 Stunden
7 Erkrankungen und Schädigungen des Zentralnervensystems		ca. 20 Stunden
8 Gesundheitserziehung, Gesundheitsvorsorge und Früherkennung		ca. 7 Stunden
6.5.1 Vererbung und Evolution (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler haben vertiefte Kenntnisse über die Gesetzmäßigkeiten der Vererbung.	Genetik - Einführung - Keimzelle und Befruchtung - Chromosomen des Menschen (Eusomie, eusomer Karyotyp, Mitose, Meiose) - Gene - Formen der Vererbung (homozygot, heterozygot; autosomal, gonosomal; dominant, rezessiv; Mendelsche Gesetze; multifaktorielle Vererbung)	Abstimmung mit dem Lerngebiet Anatomie und Physiologie Arbeit mit Medien Fallbeispiele für verschiedene Erbgänge

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Einblick in genetisch bedingte Erkrankungen und kennen Ursachen, Symptome und Therapie des Down-Syndroms. Sie sind für logopädische Aufgaben sensibilisiert.	- Mutation (Gen-, Chromosomen-, Genommutation; strukturelle und numerische; Spontanmutation, induzierte Mutation) - genetisch bedingte Erkrankungen (ausgewählte klinische Krankheitsbilder mit autosomalen Chromosomenaberrationen: Down-Syndrom, Cri-du-chat-Syndrom, usw.); ausgewählte klinische Krankheitsbilder mit gonosomalen Chromosomenaberrationen (Turner-Syndrom, Klinefelter Syndrom, X-chromosomaler Schwachsinn; weitere Syndrome: z. B. Cornelia de Lange-Syndrom, EMG-Syndrom, Alport-Syndrom, fetales Alkohol-Syndrom)	ausführliche Darstellung des Down-Syndroms, sonst Auswahl im Ermessen der Lehrkraft
Sie besitzen einen Überblick über die Aufgaben und Bedeutung der genetischen Beratung.	genetische Beratung (Diagnose, Beratung über die Erkrankung und deren Verlauf, Wiederholungsrisiko, pränatale Diagnostik, Therapiemöglichkeiten, Belastungen)	Vermittlung von Wissen über Vorsorgeuntersuchungen, Risikofaktoren und mögliche Beratungsinhalte
Sie verfügen über reaktiviertes Wissen zur Entwicklungsgeschichte.	die Entwicklung zum Menschen - Evolutionstheorien - Zusammenspiel der Evolutionsfaktoren - Ontogenese (biogenetische Grundregel, Rekapitulationsentwicklung, Rudimente, Atavismen)	Darstellung der Evolutionsfaktoren und ihrer Wirkung Darstellung der ontogenetischen Entwicklung ausgewählter Organe
6.5.2 Normale und pathologische Entwicklung in der prä-, peri- und postnatalen Phase (ca. 23 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die normale intrauterine Entwicklung.	Embryologie (Organogenese, intrauterines Wachstum und Reifung)	Darstellung der Embryonal- und Fetalperiode unter Einbeziehung der Kenntnisse aus dem Lerngebiet Anatomie und Physiologie;
Sie haben einen Überblick über die wichtigsten Embryo- und Fetopathien.	Störungen der pränatalen Entwicklung	Vorstellung der Störungsmöglichkeiten der Keimesentwicklung, typischer Symptome, der Therapie und möglicher
Sie kennen die prophylaktischen Maßnahmen.	- Embryo- und Fetopathien (Pränatalinfektion, Stoffwechselerkrankungen, chronischer Sauerstoffmangel, chemische und physikalische Noxen, Blutgruppen-unverträglichkeiten)	Prophylaxemaßnahmen ausgewählter, für den Logopäden relevanter, pränataler Entwicklungsstörungen
Sie haben Kenntnisse über Risiken in der perinatalen Phase und ihrer möglichen Auswirkungen.	perinatale Schädigungen (Geburtsgeschwulst, Cephalhämatom, Schädelfrakturen, Fazialisparese, Plexusparese, Asphyxie)	Aufzeigen wesentlicher Risikofaktoren der perinatalen Phase sowie der Ursachen, Symptome und Folgen von Sauerstoffmangel und geburtstraumatischen Schäden

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über die normale und gestörte Entwicklung des Neugeborenen.	- das Neugeborene - Klassifizierung der Neugeborenen (Geburtsgewicht, Gestationsalter, Standardgewichtskurven) - Anpassung an das extrauterine Leben (Kreislauf, Verdauung, Temperaturregulation)	Darstellen von Möglichkeiten der postnatalen Reifebestimmung und klinischer Kriterien
Sie haben Einblick in medizinische Sofortmaßnahmen nach der Geburt.	- Sofortmaßnahmen im Kreissaal (Apgar-Schema, prophylaktische Maßnahmen, Neugeborenen-Screening)	Arbeit mit Fallbeispielen
Sie kennen die Charakteristika des Neugeborenen mit niedrigem Geburtsgewicht.	- das Frühgeborene - Ursachen der Frühgeburt • Unreife der Lunge, Leber, des Verdauungstraktes, der Nieren • Unreife des Zentralnervensystems • intrakranielle Blutungen - Prognose beim unreif geborenen Kind	Vorstellen der besonderen Disposition des frühgeborenen Kindes; Aufzeigen wesentlicher Folgen der Frühgeburtlichkeit anhand einfacher Fallbeispiele, Ableiten relevanter Situationen für die logopädische Praxis
Sie haben Einblick in das therapeutische Vorgehen.	- Therapiemöglichkeiten	Erarbeiten grundsätzlicher Möglichkeiten
Sie besitzen Einblick in die häufigsten angeborenen Erkrankungen.	- angeborene Fehlbildungen • Herzfehler • Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten (Formen, Ursachen) • weitere Fehlbildungen (Ösophagusatresie, Hydro-, Mikrozephalus, Skelettsystem)	angeborene Herzerkrankungen werden unter 6.5.4 ausführlich behandelt Abstimmung mit den Lerngebieten Kieferorthopädie, Kieferchirurgie und Phoniatrie
Sie verfügen über anwendungsbereite, erweiterte und konsolidierte Kenntnisse.	Erkrankungen der Neugeborenenperiode (Ikterus, Neugeborenenkrämpfe, Neugeboreneninfektionen)	Vorstellen des Krankheitsbildes: Ursachen, Symptome, Komplikationen und Therapiemöglichkeiten; mögliche Auswirkungen auf Stimme, Sprache und Gehör aufzeigen
Sie haben Kenntnisse über die normale kindliche Entwicklung.	physiologische Entwicklung des Kindes - normales Wachstum - Entwicklung des Kindes (Wahrnehmung, Motorik, kognitive Entwicklung, Sprache, Sozialverhalten, Kriterien für die normale Entwicklung) - Vorsorgeuntersuchungen (U 1 – U 9) - aktueller Impfkalender - Vitamin D-, Fluoridprophylaxe - Ernährung	Wiederholen von Kenntnissen über die Neugeborenenperiode; Weiterführung der normalen Entwicklung des Kindes; Hinweis auf Entwicklungstests, -normen, -gitter, -skalen; Abstimmung mit den Lerngebieten Logopädie, Psychologie und klinische Psychologie sowie Soziologie siehe auch unter 6.5.6

6.5.3 Stoffwechselerkrankungen und endokrine Störungen (ca. 6 Stunden)

Die Schüler besitzen einen Überblick über ausgewählte Stoffwechselstörungen.	Stoffwechselerkrankungen - angeborene Störungen des Kohlehydratstoffwechsels • Galaktosämie	Darstellen der Grundprinzipien und wichtigsten Formen metabolischer Störungen, ihrer Auswirkungen und Therapiemöglichkeiten;
--	---	--

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie verfügen über Kenntnisse hinsichtlich ihrer Ursachen, Symptome, Diagnostik und Therapie.	• jugendlicher Diabetes mellitus • Malabsorption - angeborene Störungen des Aminosäurenstoffwechsels • Phenylketonurie - angeborene Störungen des Lipidstoffwechsels • Lipoidosen - Mukoviszidose	Einbeziehen von Kenntnissen über das Neugeborenen-Screening
Sie besitzen erweiterte und vertiefte Kenntnisse über die Physiologie des endokrinen Systems.	Endokrinologie	Vermittlung notwendiger Kenntnisse über das endokrine System, die physiologische Wirkung der Hormone und den Reglermechanismus endokriner Organe;
Sie erfassen die Zusammenhänge.	- Hypophyse	Herausarbeiten von Ursachen und Auswirkungen der Unter- und Überfunktion endokriner Drüsen
Sie haben einen Überblick über die Klinik, Diagnostik und Therapie der wichtigsten endokrinen Störungen.	• hypophysäre Hormone • Endokrinopathien (Minderwuchs, Großwuchs, ADH-Mangel) - Nebenniere • Nebennierenrinden- und -markhormone • Endokrinopathien (Adrenogenitales Syndrom, M. Addison, M. Cushing)	
Sie haben erweiterte und vertiefte Kenntnisse über die normale und gestörte Sexualentwicklung.	- Testikel • Testishormone, Pubertät • Hypo- und Hypergonadismus - Ovar • Ovarhormone, Pubertät • Hypo- und Hypergonadismus - Schilddrüse • Schilddrüsenhormone, Jodstoffwechsel • Hypo- und Hyperthyreose • Struma - Nebenschilddrüsen • Parathormon • Hypo- und Hyperparathyreoidismus	Aufzeigen wesentlicher, besonders für die logopädische Praxis relevanter Folgen; Einblick vermitteln in diagnostische und therapeutische Möglichkeiten

6.5.4 Erkrankungen der Atmungs- und Kreislauforgane (ca. 8 Stunden)

Sie verfügen über reaktivierte und gefestigte Kenntnisse.	Erkrankungen der Atemwege	Berücksichtigung von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie sowie Pathologie
	- anatomisch-physiologische Grundlagen - allgemeine Ursachen (infektiöse, allergische, angeborene Missbildungen, Neubildungen, Traumata) - allgemeine Symptome bei Atemwegserkrankungen (Brustschmerzen, Husten, Stridor, Hyperpnoe, Tachypnoe, Dyspnoe) - ausgewählte Störungsbilder (Pseudokrupp, Bronchitis, Pneumonien, Fremdkörperaspiration, Thoraxdeformitäten, Asthma bronchiale, Tuberkulose)	Zuordnung charakteristischer Symptome zu entsprechenden Krankheitsbildern, Ableiten von Folgen
Sie besitzen Kenntnisse über die häufigsten Atemwegserkrankungen bezüglich ihrer Ursachen, des klinischen Verlaufs, möglicher Komplikationen sowie diagnostischer und therapeutischer Maßnahmen.		Arbeit mit Fallbeispielen aus der ärztlichen Praxis, Darstellung unterschiedlicher Verlaufsformen; wenn möglich, Einbeziehung von Selbsterfahrungen der Schüler; Hinweise zur Prophylaxe

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die wesentlichen Missbildungen und Erkrankungen sowie ihre Auswirkungen.	Herz-Kreislauf-Erkrankungen - angeborene Herzerkrankungen - erworbene Herzerkrankungen	Erklärung angeborener Missbildungen aus der Herzentwicklung; Erarbeiten der Ursachen und Pathogenese; Informationen über diagnostische und therapeutische Maßnahmen

6.5.5 Infektionskrankheiten einschließlich Hygiene im klinischen und außerklinischen Bereich (ca. 6 Stunden)

Die Schüler besitzen einen Überblick über die wichtigsten Infektionskrankheiten, über ihre Ausbreitung und Bekämpfungsmöglichkeiten.	virale Erkrankungen (Herpes simplex, Mononukleose, Varizellen, Masern, Mumps, Röteln, Polyomyelitis, FSME, Virusgrippe, Virushepatitis, Tollwut, AIDS)	Vermittlung von Wissen über Erreger, Virulenz, Übertragungswege, Inkubationszeit, Symptome, Krankheitsverlauf, Komplikations-, Therapiemöglichkeiten sowie prophylaktische Maßnahmen
Sie kennen die Pflichten und das Verhalten sowie Kriterien für den Abbruch einer logopädischen Therapie bei Verdacht auf oder Vorliegen von Infektionskrankheiten.	bakterielle Erkrankungen (Bakteriämie und Sepsis, Meningitiden, Enzephalitiden, Pertussis, Diphtherie, Scharlach, Tetanus, Tbc, Salmonellose)	Erarbeiten der Bedeutung von Desinfektion bzw. Sterilisation (Vorschriften) sowie der Beachtung der Meldepflicht lt. IfSG) unter Einbeziehung von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde
Sie haben einen Überblick über Vorschriften für die Desinfektion bzw. Sterilisation diagnostischer und therapeutischer Instrumente in der logopädischen Praxis.	Mykosen Darmparasiten	

6.5.6 Impfungen und Impfschäden (ca. 3 Stunden)

Die Schüler besitzen einen Überblick über den Wirkungsmechanismus verschiedener Impfungen.	Impfungen - Prinzip der Schutzimpfungen und der Heilserumbehandlung • aktive Immunisierung • passive Schutzimpfungen	Unterschiede zwischen Immunisierungsarten herausarbeiten; Antigenverabreichung; Impfschema für die wichtigsten kindlichen Infektionskrankheiten vorstellen; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit der Durchführung und Kenntnis prophylaktischer Maßnahmen.	- aktueller Impfkalender - Kontraindikationen	
Sie besitzen einen Überblick über Gegenindikationen.		Aufzeigen, besonders für die Fachrichtung relevanter Impffolgen
Sie kennen mögliche Impfschäden.	Impfschäden	

6.5.7 Erkrankungen und Schädigungen des Zentralnervensystems (ca. 20 Stunden)

Die Schüler verfügen über reaktivierte und vertiefte Vorkenntnisse.	anatomisch-physiologische Grundlagen - Bau des ZNS - funktionelle Systeme - Hirnentwicklung	Einbeziehung von Wissen aus dem Lerngebiet Anatomie und Physiologie
Sie haben einen Überblick über die wichtigsten Untersuchungsmethoden in der Neuropädiatrie.	neurologische Untersuchung beim Kind - Inhalte - Methodik - mögliche Störungen (Sensorik, Motorik, Sensibilität, Hirnleistungsstörungen, psychologische Funktionsstörungen)	Demonstration ausgewählter Dokumentationsbögen; Erläutern diagnostischer Methoden

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- neurologische Zusatzuntersuchungen (Labor, EEG, CT, MRT, PET, Sonographie usw.)	
Sie besitzen Einblick in anatomische Fehlbildungen des ZNS.	Entwicklungsstörungen des ZNS (Ursachen, Störungsbilder) - Fehlbildungen des Gehirns	Darstellen ausgewählter Anomalien
Sie haben einen Überblick über Ursachen, Pathogenese, Symptome, Diagnostik, Therapie und mögliche Komplikationen.	- Fehlbildungen des Rückenmarks entzündliche Erkrankungen des ZNS - Meningitis - Enzephalitis - Myelitis	Aufzeigen wesentlicher Folgen entzündlicher zentralnervöser Erkrankungen; prophylaktische Maßnahmen
Sie besitze Kenntnisse über Schädel-Hirn-Traumen im Kindesalter und Erste-Hilfe-Maßnahmen.	Verletzungen des kindlichen Gehirns - Schädelfrakturen - gedeckte Hirnverletzungen - offene Schädel-Hirn-Verletzungen	Arbeit mit Fallbeispielen; Aufzeigen wesentlicher Folgen
Sie haben einen Überblick über die wichtigsten Hirngeschwülste bei Kindern.	Tumoren (Arten, Symptomatik, Auswirkungen und Prognose)	Einbeziehen von Wissen aus dem Lerngebiet Pathologie
Sie kennen die verschiedenen Formen der Zerebralparese und die minimalen zerebralen Bewegungsstörungen.	Zustandsbilder nach frühkindlichen Hirnschäden	Abstimmung mit den Lerngebieten Kinder- und Jugendpsychiatrie, Phoniatrie und Logopädie
Sie besitzen einen Überblick über Risikofaktoren für zerebral bedingte Störungen.	- zerebrale Bewegungsstörungen und Dysfunktionen (Ursachen, klinisches Bild, Formen der Zerebralparesen, Risikofaktoren, Diagnostik und Therapie)	Verdeutlichen des Stellenwerts der Frühdiagnostik; Verdachtszeichen
Sie kennen die Grundzüge der Behandlungsmöglichkeiten bei zerebralen Bewegungsstörungen, Dysfunktionen und Teilleistungsstörungen.	- Hydrozephalus (Pathogenese, Symptome, Therapie und Prognose) - geistige Behinderung (Ätiologie, Symptomatik, Grade der geistigen Behinderung, Therapiemöglichkeiten)	
Sie verfügen über Kenntnis der wichtigsten neuromuskulären und neurodegenerativen Erkrankungen.	- hereditäre degenerative Erkrankungen (Ätiologie, Verlauf, Therapie, Prognose) • neurokutane Syndrome • Speichererkrankungen	Darstellung ausgewählter Störungsbilder unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die Respiration, das Schlucken, die Phonation, Artikulation und Sprache
Sie haben einen Überblick über die Arten epileptischer Anfälle und deren Unterscheidung zu nichtepileptischen Anfällen.	- zerebrale Anfallsleiden • generalisierte Anfälle • fokale Anfälle • nichtepileptische Anfälle (Synkopen, Narkolepsie, Migräne)	Klassifikation epileptischer Anfälle; Vermittlung der Besonderheiten im Umgang mit Anfallskranken
Sie kennen Ursachen, Verlaufsformen, Prognose und Therapie der wichtigsten und häufigsten zerebralen Anfallsleiden im Kindesalter.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.5.8	Gesundheitserziehung, Gesundheitsvorsorge und Früherkennung (ca. 7 Stunden)	
Die Schüler erfassen den Gesundheitsschutz als komplexe Funktion der Gesamtgesellschaft.	Gesundheitsschutz (Ziele, Inhalt, Aufgaben)	Einführung
Sie erkennen die Wechselbeziehung von Entwicklung und Erziehung, die Einheit von Biologischem, Psychischem und Sozialem.	Kinder- und Jugendgesundheitschutz (Spezifik)	Darstellung und Begründung des Kinder- und Jugendgesundheits-schutzes als besonderen Teilbereich des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung;
Sie können den Stellenwert von Vorsorge- und Früherkennungsmaßnahmen, insbesondere im Kindesalter einschätzen.	- Gesundheitsvorsorge (Zielstellung, Inhalte, Aufgaben, Zielgruppen) - Früherkennung und Früherfassung (Zielstellung, Inhalte, Aufgaben, Zielgruppen)	Berücksichtigung demographischer, soziologischer, epidemiologischer, hygienischer und pädagogischer Aspekte Aufzeigen von Vorsorgemaßnahmen; Hinweis auch auf pränatale Vorsorge und Schutzimpfungen, (siehe unter 6.5.6)
Sie erkennen die Einheit von Kenntnisvermittlung und Herausbildung eines „Gesundheitsbewusstseins“.	- Gesundheitserziehung (Voraussetzungen für die Entwicklung von Gesundheitsverhalten und -bewusstsein)	Vorstellen der Früherkennungsuntersuchungen U 1 – U 9, Inhalte, Zeitplan, Entwicklungsskalen; besondere Akzentuierung der Maßnahmen bei berufsrelevanten Risikogruppen; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie erfassen die Bedeutung umfassender Prophylaxemaßnahmen.		
Sie sind fähig zur kontinuierlichen Nutzung gesundheitserzieherischer Potenzen in der täglichen therapeutischen Arbeit.		Diskussion über die Bedeutung des Gesundheitsverhaltens in Familie, Bildungseinrichtungen, Massenmedien; Darstellung von Diskrepanzen zwischen Kenntnissen und Gesundheitsverhalten, z. B. Tabak-, Alkoholkonsum, Schlaf-, Essgewohnheiten bei Jugendlichen

6.6 Kinder- und Jugendpsychiatrie (40 Stunden)

Lernabschnitte

1	Einführung in das Lerngebiet	ca. 1 Stunde
2	Pathogenese psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter	ca. 2 Stunden
3	Diagnostik und Therapie	ca. 3 Stunden
4	Umfassende Entwicklungsbeeinträchtigungen	ca. 8 Stunden
5	Umschriebene Entwicklungsbeeinträchtigungen	ca. 4 Stunden
6	Störungen körperlicher Funktionen im Entwicklungsalter	ca. 2 Stunden
7	Psychoreaktive, Persönlichkeits- und Grenzstörungen	ca. 3 Stunden
8	Angst- und affektive Störungen	ca. 3 Stunden
9	Weitere psychiatrische Störungen	ca. 4 Stunden
10	Suchtstörungen	ca. 2 Stunden
11	Psychosomatische Störungen	ca. 2 Stunden
12	Suizidalität	ca. 2 Stunden
13	Spezielle Aspekte	ca. 2 Stunden
14	Krisen- und Notfallsituationen	ca. 2 Stunden

Zeitrichtwerte

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.6.1 Einführung in das Lerngebiet (ca. 1 Stunde)		
Die Schüler besitzen einen Überblick über das Aufgabengebiet der Kinder- und Jugendpsychiatrie.	- Gegenstand der Kinder- und Jugendpsychiatrie - Aufgaben - Nachbardisziplinen	Einführung in die Thematik, Motivation
6.6.2 Pathogenese psychischer Störungen im Kindes- und Jugendalter (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Grundkenntnisse.	- Entstehung psychischer Störungen - Vorkommen - Krankheitsverlauf	allgemeinen Überblick geben
6.6.3 Diagnostik und Therapie (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler haben die Einsicht in die Notwendigkeit einer mehrdimensionalen Diagnostik.	- kinderpsychiatrische Untersuchung - Symptome und ihre Bedeutung - Klassifikation	Beschreiben des Ganges einer kinderpsychiatrischen Untersuchung sowie möglicher Therapiewege;
Sie besitzen einen Überblick über die wichtigsten Interventions- und Behandlungsmethoden in der Kinder- und Jugendpsychiatrie.	- Entstehungsbedingungen und Beeinträchtigungsgrad von Störungen - Therapieplanung - Interventionen	Wirkung und wesentliche Nebenwirkungen von Psychopharmaka aufzeigen unter besonderer Berücksichtigung ihrer Auswirkungen auf die Stimme, die Sprache und das Sprechen
6.6.4 Umfassende Entwicklungsbeeinträchtigungen (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler verfügen über reaktivierte und anwendungsbereite Kenntnisse.	Grundzüge der kognitiven Entwicklung im Kindesalter	Abstimmung mit dem Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie;
Sie erkennen den Zusammenhang zwischen der Entwicklung des Funktionsbereiches und der Sprache.		Einbeziehung und Festigung von Kenntnissen zur menschlichen Entwicklung; evtl. Einbeziehung weiterer Entwicklungsbereiche

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie verfügen über Kenntnisse der häufigsten Formen geistiger Behinderung sowie der Auswirkung von Entwicklungsrückständen auf die Sprache. Sie besitzen einen Überblick über die wichtigsten Untersuchungs- methoden und Therapie- bzw. Fördermöglichkeiten.	Intelligenzminderungen und grenzwertige Intelligenz - Ursachen - Schweregrad und Häufigkeit - Formen der Intelligenzminderung - Intelligenzminderung und Demenzzustände - Diagnostik bei Störungen der geistigen Entwicklung - Therapie (individuelle Förderung, Soziotherapie, Psychotherapie, Mototherapie, Sprachtherapie; schulische und berufliche Förderung)	Darstellen der häufigsten Formen gestörter Intelligenz und ihrer Grade sowie Möglichkeiten ihrer Erfassung; Abgrenzung von der leichten Lernbehinderung; Aufzeigen wesentlicher Folgen für die Gesamtentwicklung unter besonderer Berücksichtigung der Sprachentwicklung; Vorstellen diagnostischer Verfahren und Behandlungs- bzw. Fördermethoden (Normalisierungsprinzip); Arbeit mit Fallbeispielen; Abstimmung mit den Lerngebieten Neurologie und Psychiatrie, Phoniatrie, Logopädie, Psychologie, Pädagogik, Sonderpädagogik und Soziologie
Sie kennen die wichtigsten autistischen Syndrome im Kindes- und Jugendalter und die Grundzüge der Therapie.	autistische Syndrome - Ursachen - Symptome - Einteilung - Psychodiagnostik des kindlichen Autismus - Differentialdiagnose - Therapie und Prognose	Darstellung der Ursachen autistischer Syndrome, der Schweregrade und Einteilung sowie Gegenüberstellung der jeweils charakteristischen Symptomatik; Einblick in die Psychodiagnostik; Vorstellung verschiedener Therapieformen mit besonderem Augenmerk auf die Therapie der Sprachentwicklungsstörungen; Vorstellen der Störungsbilder; besondere Berücksichtigung der MCD und des ADHS bezüglich Symptomatik, Diagnostik, Therapie und Prognose; Aktivieren von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Pädiatrie und Neuropädiatrie
Sie besitzen Kenntnisse über psychische Störungen im Zusammenhang mit organischen Hirnschädigungen.	hirnorganische Psychosyndrome - organische Psychosyndrome bei Schädel-Hirn-Traumen, Hirntumoren, entzündlichen Erkrankungen usw. - organische Psychosyndrome nach frühkindlicher Hirn- schädigung - minimale zerebrale Dysfunktion hyperkinetische Syndrome	

6.6.5 Umschriebene Entwicklungsbeeinträchtigungen (ca. 4 Stunden)

Die Schüler kennen Ursachen und Möglichkeiten der Einteilung von Entwicklungsbeeinträchtigungen sowie die für die logopädische Praxis wichtigsten Störungsbilder und ihre Erscheinungsformen.	- Kriterien einer umschriebenen Entwicklungsbeeinträchtigung - umschriebene Entwicklungs- beeinträchtigungen • des Sprechens und der Sprache • der schulischen Fertigkeiten • der motorischen Funktionen (einschließlich senso- motorischer Funktionen) • chronische Krankheiten (z. B. Epilepsie)	Definition, Normalitäts- und Diskrepanzannahme; Ursachen; Klassifikation der Störungen nach ICD-10; besondere Berücksichtigung auditiver, visueller und taktilkinästhetischer Beeinträchtigungen, ihrer Auswirkungen und möglichen Folgen;
--	---	--

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.6.6	Störungen körperlicher Funktionen im Entwicklungsalter (ca. 2 Stunden)	
	• Folgezustände von Vernachlässigung, Misshandlung und Missbrauch	Arbeit mit Fallbeispielen; Reaktivieren von Kenntnissen aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie, Phoniatrie, Logopädie sowie Pädiatrie und Neuropädiatrie
Sie haben Einblick in kindliche Regulationsstörungen.	- Schlaf- und Fütterstörungen - Essstörungen (Anorexie, Bulimie) - Enuresis und Enkopresis - Bewegungstereotypien - Ticstörungen	Informationen über Arten, Leitsymptome, Schweregrade, Entstehungstheorien, Therapie-, Interventions- und Rehamöglichkeiten
6.6.7	Psychoreaktive, Persönlichkeits- und Grenzstörungen (ca. 3 Stunden)	
Die Schüler besitzen Kenntnisse über ausgewählte Störungsbilder.	- somatogene Störungen - dissoziative Störungen - Borderline-Syndrom - Persönlichkeitsstörungen - spezielle Sprech- und Sprachstörungen	Einbeziehung von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Neurologie und Psychiatrie; Klassifikation von Persönlichkeitsstörungen; Darstellung der Ursachen, Formen und Symptome der Störungen sowie ihrer Folgen, der Diagnostik, der wichtigsten Behandlungs- und Interventionsmethoden sowie der Prognose
6.6.8	Angst- und affektive Störungen (ca. 3 Stunden)	
Die Schüler haben Kenntnisse über ausgewählte Erkrankungen hinsichtlich ihrer Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie und möglicher Komplikationen.	- Trennungsangst, generalisierte Angststörungen, einfache und spezielle Phobien (soziale Phobien) - Schulangstproblematik - Zwangsstörungen - Depressionen, Manien, bipolare Erkrankungen	wichtigste Behandlungsmethoden vorstellen; Erwähnen von Organneurosen, die die Stimme und Sprache betreffen
6.6.9	Weitere psychiatrische Störungen (ca. 4 Stunden)	
Die Schüler besitzen reaktiviertes und vertieftes Wissen.	- Schizophrenien - Störungen des Kontaktverhaltens	Einbeziehen vorhandenen Wissens aus den Lerngebieten Neurologie und Psychiatrie sowie Psychologie und klinische Psychologie;
Sie kennen die Besonderheiten bei ausgewählten psychiatrischen Störungen im Kindes- und Jugendalter.	- Störungen des Sozialverhaltens - Störungen der Geschlechtsidentität	Symptome, Verlaufsformen und Prognose aufzeigen; Eingehen auf die schizophrene Sprache und Sprechweise bei Kindern

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.6.10	Suchtstörungen (ca. 2 Stunden)	
Die Schüler haben einen Überblick über die wichtigsten Formen der Sucht und die therapeutischen Vorgehensweisen.	- Alkohol-, Nikotinsucht - Drogensucht (klassische Drogen, Designer- und Jugenddrogen, pflanzliche Drogen, Schnüffelfstoffe) - Spielsüchte (Videospiele, Automaten, usw.) - Handy- und Internetsucht - Kaufzwang - Suchtäquivalente im Jugendalter (Risiko- und Extremsport)	Vermittlung von Grundkenntnissen; Arbeit mit Fallbeispielen; Einbeziehen möglicher persönlicher Erfahrungen der Schüler
6.6.11	Psychosomatische Störungen (ca. 2 Stunden)	
Die Schüler besitzen einen Überblick über die wichtigsten psychosomatischen Krankheitsbilder im Säuglings-, Kindes- und Jugendalter und ihre Therapiemöglichkeiten.	- Asthma bronchiale - Neurodermitis - Kopfschmerzen - Migräne - Therapie psychosomatischer Erkrankungen	Darstellen ausgewählter Störungsbilder und der wichtigsten Behandlungsmethoden
6.6.12	Suizidalität (ca. 2 Stunden)	
Die Schüler haben einen Einblick in die Problematik von Selbstmordgefährdung und Selbsttötung im Kindes- und Jugendalter.	- Ursachen - Häufigkeit - präsuizidales Syndrom - Suizidversuch (Formen) - Interventions- und Behandlungsmethoden - Suizidprophylaxe	Begriffsklärung: Suizidalität, Suizid, erweiterter Suizid, gesteigertes Suizidrisiko usw.; Interventions- und Therapiemethoden in den Grundzügen beschreiben; Formen der Suizidprophylaxe
6.6.13	Spezielle Aspekte (ca. 2 Stunden)	
Sie haben einen Überblick über die Phänomene Jugenddissozialität, Delinquenz und Verwahrlosung.	- spezielle Therapien - rechtliche Aspekte (Schulgesetz, Betreuung usw.) - Delinquenz - Verwahrlosung	Erläutern der Problematik und Informieren über Behandlungs- und Interventionsmethoden; Arbeit mit Fallbeispielen
6.6.14	Krisen- und Notfallsituationen (ca. 2 Stunden)	
Sie haben Einblick in das Verhalten in akuten und chronischen Krisen.	- Krisendefinition - Krisenintervention - Krisenprophylaxe	Darstellen von Situationen anhand von Beispielen

6.7 Neurologie und Psychiatrie (60 Stunden)

Lernabschnitte

1	Einführung in das Fachgebiet Neurologie	ca. 1 Stunde
2	Funktionen des Nervensystems	ca. 3 Stunden
3	Neurologische Untersuchungsverfahren	ca. 6 Stunden
4	Neurologische Erkrankungen	ca. 26 Stunden
5	Einführung in das Fachgebiet Psychiatrie	ca. 1 Stunde
6	Allgemeine Psychopathologie	ca. 5 Stunden
7	Psychiatrische Untersuchungsverfahren	ca. 2 Stunden
8	Therapie und Rehabilitation bei psychiatrischen Störungen	ca. 12 Stunden
9	Gerontopsychiatrie	ca. 3 Stunden
10	Forensische Psychiatrie	ca. 1 Stunde

Zeitrichtwerte

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.7.1 Einführung in das Fachgebiet Neurologie (ca. 1 Stunde)		
Die Schüler besitzen einen Überblick über das Aufgabengebiet der Neurologie.	- Gegenstand der Neurologie - Grenzgebiete	Darstellung des fließenden Übergangs zu anderen Lerngebieten sowie der besonders engen Beziehung zum Fachgebiet Psychiatrie
6.7.2 Funktionen des Nervensystems (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler verfügen über reaktivierte und vertiefte Kenntnisse.	- Entwicklung und Repräsentation höherer Hirnleistungen - Organisation sensomotorischer Funktionen - Heilung und Kompensation von Schädigungsfolgen	Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Anatomie und Physiologie; besondere Berücksichtigung der Sprache, Stimmfunktion, Sprech- und Schluckmotorik
6.7.3 Neurologische Untersuchungsverfahren (ca. 6 Stunden)		
Die Schüler besitzen einen Überblick über die Anamneseinhalte und den Gang einer neurologischen Untersuchung.	diagnostische Maßnahmen	Aufgreifen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie; Einarbeitung fachspezifischer Aspekte
Sie haben Einblick in die wichtigsten neurologischen Untersuchungsmethoden .	- Anamnese • Formen • Inhalte - die neurologische Untersuchung • äußeres Erscheinungsbild • körperliche Gesamtverfassung • internistischer Befund - klinisch-neurologischer Status (Bewusstsein, Motorik, Sensibilität, Tonus, Reflexe, Bewegungskoordination, Hirnnervendiagnostik, vegetatives Nervensystem, psychischer Befund der neuropsychologischen Untersuchung - apparative Untersuchungsmethoden (Perimetrie, Liquorpunktion und Liquoruntersuchung, Röntgen-Nativaufnahmen, EEG, CT, EMG, ENG, Myelographie, ECT, MRT, Angiographie, Sonographie, Elektroneurographie usw.) - histologische Diagnostik	Informationen über ausgewählte diagnostische Möglichkeiten

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.7.4	Neurologische Erkrankungen (ca. 26 Stunden)	
Die Schüler kennen Ursachen, Verlauf und Therapie akuter zerebraler Zirkulationsstörungen.	zerebrovaskuläre Erkrankungen - intrazerebrale Blutungen - Subarachnoidalblutung - Stenosen intra- und extrakranieller Gefäße - Vaskulitis - Arteriosklerose hirnversorgender Gefäße - rheologische Störungen des Blutes usw.	Aufzeigen der Risikofaktoren; Darstellung der wichtigsten Krankheitsbilder, der diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten sowie von Rehabilitations- und prophylaktischen Maßnahmen; Herausarbeiten der Auswirkungen auf höhere Hirnleistungen, besonders Sprache, Sprechmotorik und Schluckfunktion; Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie; Abstimmung mit dem Lerngebiet Aphasieologie
Sie kennen verschiedene Formen traumatischer Hirnschädigungen.	Schädel-Hirn-Traumen - Commotio cerebri - Contusio cerebri - intrakranielle Hämatome - offene Hirnverletzungen	Darstellung der Symptomatik, Diagnostik, Therapie sowie von Komplikationen und Rehabilitationsmöglichkeiten; Beschreiben möglicher Defektsyndrome und ihrer Auswirkungen auf höhere Hirnleistungen, die Kommunikation und Schluckfunktion; Wissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie sowie Pathologie wiederholen und vertiefen
Kenntnisse über entzündliche Erkrankungen des Gehirns bezüglich ihrer Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie, möglicher Komplikationen und Spätfolgen	entzündliche Erkrankungen - Meningitis - Enzephalitis - Hirnabszess	Kenntnisse aus dem Lerngebiet Pathologie reaktivieren, anwenden und erweitern; mögliche neuropsychologische Störungen bei Befall der Großhirnhemisphäre einbeziehen
Die Schüler verfügen über reaktivierte Kenntnisse. Sie haben Einblick in die Problematik der wichtigsten intrakraniellen Tumoren.	Hirntumoren - Astrozytome - Meningeome - Gliosarkom	Darstellen der Allgemein- und Lokalsymptome neoplastischer zerebraler Erkrankungen und des Krankheitsverlaufs; Informieren über die medizinischen Behandlungsmöglichkeiten sowie die Prognose benigner und maligner raumfordernder intrazerebraler Prozesse
Sie besitzen einen Überblick über Entwicklungsstörungen, die durch prä-, perinatale oder frühkindliche Hirnschäden hervorgerufen werden können.	Entwicklungsstörungen und Schädigungen des kindlichen Gehirns - Missbildungen - Hydrozephalus - frühkindlicher Hirnschaden	Reaktivieren und Vertiefen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Pädiatrie und Neuropädiatrie; besondere Berücksichtigung des klinischen Bildes der minimalen zerebralen Dysfunktion sowie der infantilen Zerebralparese

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die Arten epileptischer Anfälle, ihre Ursachen, die diagnostischen und therapeutischen Möglichkeiten, besonders die Indikation für eine logopädische Therapie. Sie können gegenüber nicht epileptischen Anfällen abgrenzen.	zerebrale Anfallsleiden im Kindes- und Erwachsenenalter - generalisierte Anfälle - fokale Anfälle - nicht epileptische Anfälle (Synkopen, Narkolepsie, Migräne)	Anfallstypen und Verlaufsformen der Epilepsie im Kindes- und Erwachsenenalter sowie medikamentöse und operative Therapiemöglichkeiten darstellen; Aufzeigen wesentlicher Folgen, besonders der psychischen Veränderungen und sprachlichen Symptome bei transitorischer und chronischer Verlaufsform; Eingehen auf Folgen der medikamentösen Therapie; Wissen aus dem Lerngebiet Pädiatrie und Neuropädiatrie einbeziehen
Sie haben einen Überblick über die Einteilung der einzelnen Krankheitsbilder. Sie kennen die Folgen von Störungen des motorischen Systems.	Erkrankungen des motorischen Systems - Muskelerkrankungen • Myasthenie • Muskelatrophie • Myositis • Dystrophie • Polyneuropathie	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie und Phoniatrie; Darstellung der Erkrankungen soweit sie Atem-, Sprech-, Stimm- oder Schluckstörungen bzw. Funktionsstörungen der peripheren Muskulatur hervorrufen
Sie besitzen Kenntnisse über neurologische Störungen und Erkrankungen hinsichtlich ihrer Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie und typischen Komplikationen. Sie können logopädische Aufgaben im therapeutischen Team erkennen.	- Hirnnervenaaffektionen Schädigung des: • N. trigeminus • N. facialis • N. glossopharyngeus • N. vagus • N. hypoglossus	Erarbeiten der Folgen ein- und beidseitiger, peripherer und zentraler Lähmungen allgemein und besonders im Hinblick auf die Phonation, Sprechmotorik und den Schluckvorgang
Sie erkennen eine mögliche Indikation zur logopädischen Therapie bei Rückenmarksverletzungen und -erkrankungen.	- radikuläre Läsionen • hohe Querschnittssyndrome • Bandscheibenprolaps	Kenntnisse aus dem Lerngebiet Pathologie einbeziehen und erweitern
Sie besitzen einen Überblick über die Ursachen, Pathophysiologie und Symptomatik, besonders hinsichtlich der Motorik sowie Sprechmotorik, der Stimme und des Schluckens.	- Schädigungen der Pyramidenbahn • Pathophysiologie der Spastik • Charakteristik der Pyramidenbahnschädigung	Hinweise auf die pyramidale Dysarthrie und Pseudobulbärparalyse bei Erwachsenen und Kindern; Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Phoniatrie, Aphasieologie
Sie kennen Ursachen, Symptome, Krankheitsverlauf und therapeutische Möglichkeiten bei Erkrankungen der Stammganglien.	- Störungen des extrapyramidalen Systems • Parkinsonsyndrom • choreatisches Syndrom • Choreoathetose • Dystonien	Herausarbeiten der motorischen Behinderung sowie der zentral sprechmotorischen Störungen, einschließlich spasmodischer Dysphonie; Hinweise auf Creutzfeldt-Jacob-Krankheit
Sie haben einen Überblick über weitere neurologische Störungen, die zu Stimm- und Sprachstörungen führen können.	weitere neurologische Störungen - Amyotrophesche Lateralsklerose - Multiple Sklerose (MS) usw.	Information über weitere ausgewählte Krankheitsbilder; MS ausführlicher behandeln (spezielle klinische Symptomatik, Pathogenese sowie Therapiemöglichkeiten und Prognose)

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie können Sprechstörungen als mögliches Symptom toxischer Schädigungen erfassen.	toxische Schädigungen des Gehirns - Alkohol-Folgekrankheiten - akute und chronische Arzneimittelvergiftungen - Drogensucht	Erarbeiten der Symptomatik des akuten sowie chronischen Substanzmissbrauchs; Aufzeigen von Therapie- und Rehabilitationsmaßnahmen; Diskussion über präventive Möglichkeiten
6.7.5 Einführung in das Fachgebiet Psychiatrie (ca. 1 Stunde)		
Die Schüler besitzen einen Überblick über das Aufgabengebiet der Psychiatrie.	- Gegenstand der Psychiatrie - Teilgebiete - Grenzgebiete	Darstellung der psychologisch-medizinischen Doppelstellung der Psychiatrie sowie der sich daraus ergebenden Beziehungen zu anderen Wissenschaften
6.7.6 Allgemeine Psychopathologie (ca. 5 Stunden)		
Die Schüler haben Überblick über die psychische Entwicklung sowie psychopathologische Störungen.	Grundzüge der psychischen Entwicklung quantitative und qualitative psychopathologische Veränderungen bezüglich - Bewusstsein und Orientierung - Aufmerksamkeit und Gedächtnis - Affektivität - Psychomotorik - Denken - Wahrnehmung - Ich-Erleben Selbst- und Fremdgefährdung	besonders die Phasen der psychosexuellen Reifung, Entwicklung der Objektbeziehung, Kenntnis des Angstniveaus, der Abwehrmechanismen des Ichs, Wahrnehmung, Sprache usw.; Phasen der Identitätsbildung; Darstellung der Veränderungen unter Berücksichtigung des somatischen Befundes und kulturellen Kontextes; Einbeziehung vorhandenen Wissens aus den Lerngebieten Pädiatrie und Neuropädiatrie, Psychologie und klinische Psychologie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie
6.7.7 Psychiatrische Untersuchungsverfahren (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler haben Einblick in den Ablauf der psychiatrischen Diagnostik.	Diagnostik psychiatrischer Störungen - Zielstellung - Anamnese - Exploration - Erhebung des psychiatrischen Befundes - körperlich-neurologische Untersuchung - testpsychologische Untersuchung	Hervorheben des Stellenwertes der Persönlichkeitsentwicklung; Darstellung des Zusammenhangs zwischen den aktuellen Problemen und der Lebens- und Entwicklungsgeschichte sowie der sozialen Umwelt; Informieren über die Untersuchung von Einzelfunktionen; genauere Behandlung von Methoden der Psychodiagnostik erfolgt im Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie
6.7.8 Therapie und Rehabilitation bei psychiatrischen Störungen (ca. 12 Stunden)		
Die Schüler kennen die Säulen der psychiatrischen Therapie.	Therapiemethoden sowie Rehabilitations- und Präventionsmaßnahmen	Erläutern des ganzheitlichen Ansatzes von Therapie und Rehabilitation;
Sie haben Überblick über die wichtigsten Behandlungsformen und Rehabilitationsmaßnahmen.	- somatische Behandlungsmethoden - Psychotherapie • stützende Verfahren • aufdeckende Verfahren • klientenzentrierte Gesprächstherapie • Übungsverfahren	Aufzeigen der Behandlungsformen sowie Institutionen für die Therapie und Rehabilitation; Erläutern des Grundkonzeptes der klientenzentrierten Gesprächstherapie, des autogenen Trainings und der Lerntheorien als Basis der Verhaltenstherapie;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen Einblick in mögliche Wege, Aufgaben und Methoden der Prävention.	- Verhaltenstherapie • Grundlagen • Indikationsgebiete - Soziotherapie • Aufgaben • Formen - fachübergreifende Rehabilitation Einrichtungen für die Therapie und Rehabilitation psychisch Kranker	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie, Pädagogik und Logopädie
Sie haben einen Überblick über - ausgewählte berufsrelevante Krankheitsbilder, die mit Sprachstörungen einhergehen können;	psychiatrische Krankheitsbilder - Psychosen • akute organische Psychosen (z. B. Intoxikationspsychosen, posttraumatische Psychosen und Psychosen bei entzündlichen Erkrankungen) • chronische organische Psychosen (z. B. frühkindlich exogenes, hirndiffuses und hirnlokales Psychosyndrom) • schizophrene Psychose (Formen der Schizophrenie) • affektive Psychose (Phasen der manisch-depressiven Erkrankung) • schizoaffective Psychose	Darstellung ausgewählter Erkrankungen hinsichtlich ihrer Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapiemöglichkeiten sowie evtl. Komplikationen; Alkohol- und Drogenmissbrauch gesondert behandeln; Aufzeigen sprachlicher Fehlleistungen sowie der phasenspezifischen Symptomatik; Einbeziehen von Kenntnissen über Dysphasien aus den Lerngebieten Phoniatrie und Logopädie; Hinweis auf kindliche Schizophrenie ausreichend, da im Lerngebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie ausführlicher behandelt; Arbeit mit Fallbeispielen sowie Patientenvorstellungen
- ausgewählte neurotische Störungen.	neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen - phobische Störungen - Reaktionen auf schwere Belastungs- und Anpassungsstörungen - dissoziative Störungen - somatoforme Störungen	Darstellen des Zusammenhangs zwischen Erlebnis und Krankheit
Sie besitzen Einblick in die wichtigsten psychosomatischen Störungen.	psychosomatische Störungen - der Haut - der Atmung - der Nahrungsaufnahme - des Herz-Kreislaufsystems usw.	Informationen über ausgewählte Krankheitsbilder; Abgrenzung von Organneurosen und psychosomatischen Erkrankungen
Sie haben einen Überblick über Persönlichkeitsstörungen sowie Kenntnis ausgewählter Störungsbilder.	Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen - Einteilung - klinisches Bild - Ätiologie und Genese - ausgewählte Krankheitsbilder - Therapiemöglichkeiten	Darstellung der Ursachen, Symptome, Diagnostik, Therapie und möglicher Komplikationen; Hinweise auf mögliche Verhaltensweisen gegenüber Patienten mit Persönlichkeits- bzw. Verhaltensstörungen in der logopädischen Praxis

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen reaktivierte und vertiefte Kenntnisse über die verschiedenen Formen der geistigen Behinderung, ihre möglichen Auswirkungen sowie Therapie- und spezielle Fördermaßnahmen.	Intelligenzminderungen - Ursachen, Schweregrade und allgemeine Zeichen - Einteilung der Oligophrenien - Intelligenzfunktionen und Persönlichkeit bei Oligophrenen - spezielle Krankheitsbilder (Ursachen, Symptome, Therapie- und Fördermöglichkeiten) - Prüfung der Intelligenz	Reaktivieren von Wissen aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Pädiatrie und Neuropädiatrie, Phoniatrie, Logopädie sowie Sonderpädagogik; Darstellung der wichtigsten Formen und Grade der Intelligenzminderungen; Einteilung der Oligophrenien nach ICD-10; Sprachentwicklung, Störungen der Sprache sowie Intelligenztests nur aufzeigen; Hinweise auf diagnostische Möglichkeiten, Betreuungs- und Fördermaßnahmen geben
Sie haben einen Überblick über die Faktoren einer Suchtentwicklung, den möglichen Verlauf einer Erkrankung sowie die wichtigsten Möglichkeiten der Behandlung, Rehabilitation und Prävention.	Suchterkrankungen - Entstehung und Kennzeichen einer Sucht - Alkoholismus - Medikamentenabhängigkeit - Nikotinabhängigkeit - Drogenabhängigkeit - Essstörungen - Suchtprävention	Arbeit mit ausgewählten Beispielen; Bausteine der Rehabilitation Suchtkranker (medizinische, berufliche, soziale Rehabilitation) darstellen; Rolle der Selbsthilfegruppen; Betreuung im interdisziplinären Team; Hinweise für den Umgang mit Suchtkranken
Sie besitzen einen Einblick in akute neuropsychiatrische Störungen, ihre Therapiemöglichkeiten und in die wichtigsten juristischen Probleme, die im Kontakt mit dem Patienten auftreten können.	Neuropsychiatrischer Notfall - präsuizidales Syndrom - Suizid - rechtliche Gesichtspunkte (Fürsorgepflicht, Schweigepflicht, Dokumentation, Geschäftsfähigkeit und Einwilligung, Unterbringung, Maßnahmen zum Schutz des Patienten und Dritter, Haftung, Rechte des Patienten)	Informationen über die häufigsten Ursachen einer psychiatrischen Notfallsituation; Einbeziehen rechtlicher Gesichtspunkte; Reaktivieren von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde; Abstimmung mit 6.7.6
6.7.9 Gerontopsychiatrie (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler haben Verständnis für typische Lebenssituationen und Krisen des alten Menschen.	Eigenheiten des normalen Alterns (Persönlichkeitszuspitzung, Toleranzminderung, reduzierte geistige Flexibilität, verändertes Trinkverhalten usw.)	Darstellen ausgewählter Krankheitsbilder, ihrer Symptomatik, sowie der Auswirkungen auf die Kommunikation und höhere Hirnleistungen;
Sie besitzen Einblick in präsenile und senile Abbauprozesse des Gehirns und einen Überblick über die häufigsten seelischen Erkrankungen älterer Menschen.	Delir Demenzen - Formen - ausgewählte Demenztypen (Alzheimer-Typ, vaskulärer Typ, Pickerkrankung usw.) depressives Syndrom paranoide Syndrome	Informationen über Diagnostik, Differentialdiagnostik und Therapiewege; Kennzeichnen von Eigenheiten älterer Patienten und Hinweise für den richtigen Umgang mit ihnen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.7.10	Forensische Psychiatrie (ca. 1 Stunde)	
Die Schüler haben Einblick in die Aufgaben der gerichtlichen Psychiatrie.	- dissoziale Persönlichkeit - Paraphilien - Geschäfts- und Testierunfähigkeit - Schuldunfähigkeit und verminderte Schuldfähigkeit - Betreuung und Unterbringung	Einführung in die Problematik des Teilgebietes; Informationen über die Bestimmungen des Betreuungsgesetzes, die verschiedenen Formen der Unterbringung und wichtigsten Bestimmungen des Bundessozialhilfegesetzes (Maßnahmen der Eingliederungshilfe, Personenkreis); Arbeit mit Fallbeispielen

6.8 Kieferorthopädie, Kieferchirurgie (30 Stunden)

Lernabschnitte	Zeitrichtwerte
1 Entwicklung von Gesicht, Mund und Nase	ca. 2 Stunden
2 Fehlbildungen von Lippen, Kiefer und Gaumen	ca. 12 Stunden
3 Form und Funktion der Kauorgane	ca. 3 Stunden
4 Kieferorthopädische Maßnahmen	ca. 10 Stunden
5 Pathologie der Kauorgane	ca. 3 Stunden

6.8.1 Entwicklung von Gesicht, Mund und Nase (ca. 2 Stunden)

Die Schüler kennen die Entwicklung der Mundhöhle, des Kauorgans und des Gesichtes.	embryonale Entwicklung - Entwicklung der Gesichtsstrukturen, - Bildung der primären Mund- und Nasenhöhle - Entwicklung der Zunge - Entwicklung der Ohren - Entwicklung des harten und weichen Gaumens - Entwicklung des Unterkiefers	Einführung in das Lerngebiet; Darstellung der Wechselwirkungen von Knochenwachstum, Zahndurchbruch und Weichteilfunktion bei der Entwicklung des Gesichtsschädels
--	--	--

6.8.2 Fehlbildungen von Lippen, Kiefer und Gaumen (ca. 12 Stunden)

Die Schüler haben Einblicke in mögliche angeborene und erworbene Entwicklungsstörungen.	Lippen-Kiefer-Gaumen-Spalten	Erarbeitung spaltinduzierender Faktoren und von Klassifizierungsmöglichkeiten der Spalten
Sie besitzen die Fähigkeit zur Ableitung und Darstellung funktioneller Auswirkungen der verschiedenen Spaltformen in Bezug auf kommunikative Fähigkeiten.	- Epidemiologie - Ursachen - zeitliche Determination von Spaltbildungen - Einteilung der Spaltformen - funktionelle Auswirkungen der Spaltbildungen - Behandlungsschritte - Zeitplan des interdisziplinären komplexen Therapieprogramms (Primär-, Sekundäroperationen (primäre Segelplastik, AUOP, sekundäre Velopharyngoplastik, Kieferorthopädie, Gehör- und Sprachbehandlung, pädiatrische und psychologische Betreuung, Elterninitiativen))	Arbeit mit Fallbeispielen
Sie sind sensibilisiert für die Mitarbeit im interdisziplinären Team.		Darstellen des zeitlichen Ablaufs der interdisziplinären Rehabilitation von Spaltträgern; Vorstellen und Wertung möglicher OP-Ergebnisse hinsichtlich ihrer Prognose für eine logopädische Therapie;
Sie sind fähig zur Ableitung der zeitlichen und inhaltlichen Interventionsmöglichkeiten des Logopäden		Abstimmung mit den Lerngebieten Logopädie, Phoniatrie und Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie verfügen über Kenntnisse seltener angeborener Fehlbildungen.	seltene angeborene Fehlbildungen (Apert Syndrom, Crouzon-Syndrom, Pierre-Robin-Syndrom, Franceschetti-Syndrom, Oto-mandibulo-faziales-Syndrom)	Hauptdiagnosen, grundsätzliche Therapie
Sie besitzen die Fähigkeit zur Erläuterung von Therapieprinzipien.	- orofaziale Entwicklung bei Kindern mit Down-Syndrom - Prinzipien der myofunktionellen Therapie bei Down-Syndrom (Massagen, Stimulationsplatten, Logopädie, Krankengymnastik)	Grundzüge der orofazialen Entwicklung vermitteln; Darstellen der Notwendigkeit einer MFT beim Down-Syndrom, besonderer Schwerpunkt: logopädische Aufgaben
Sie haben Einblicke in Möglichkeiten und Grenzen der Prävention.	Prophylaxe von Spaltbildungen	Übersicht über prophylaktische Maßnahmen

6.8.3 Form und Funktion der Kauorgane (ca. 3 Stunden)

Die Schüler besitzen gefestigte und vertiefte anatomisch-physiologische Kenntnisse.	anatomische Grundlagen	Abstimmung mit dem Lerngebiet Anatomie und Physiologie
Sie verfügen über Kenntnisse der Einflussfaktoren der Gebissentwicklung sowie der Bezeichnung der Zähne und der Durchbruchzeiten im Milch- und Wechselgebiss.	- Mundhöhle • Mundspalte • Vestibulum oris • Kauapparat (Zahnanatomie, Halteapparat; Gebiss: Zahnentwicklung, Milch-, Wechselgebiss, bleibendes Gebiss, Zahnklassen, Regelverzahnung, Gebissklassifikation; Kiefergelenk) • Gaumen • Muskeln des äußeren Funktionskreises und ihre Innervation • Muskeln des inneren Funktionskreises und ihre Innervation • Mundspeicheldrüsen	Vermittlung besonders von Kenntnissen, die zum Verständnis der Erkrankungen und Behandlung von Sprech- und Sprachstörungen notwendig sind
Sie erfassen das stomatognathe System als funktionelle Einheit.	Funktionen des stomatognathen Systems - Primärfunktionen - Sekundärfunktionen	Darstellung der Wechselbeziehungen von Form und Funktion im stomatognathen System

6.8.4 Kieferorthopädische Maßnahmen (ca. 10 Stunden)

Die Schüler besitzen Kenntnisse über Störungen der Gebissentwicklung, deren Ursachen sowie mögliche Auswirkungen auf die Sprech- und Schluckfunktion.	Störungen der Gebissentwicklung - Ursachen • genetische • umweltbedingte (prä-, postnatale) - Zahn- und Bissanomalien • Formen • Erscheinungsbild • Folgen	Ableitung des funktionellen Zusammenhangs zwischen falscher Zungenlage, Schlaffheit der Zungenmuskulatur, falscher Zungenbewegung und der Entstehung von Zahn- und Kieferanomalien sowie dentalen Dysglossien; Abstimmung mit den Lerngebieten Phoniatrie und Logopädie
---	--	--

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Kenntnisse über Möglichkeiten, Wirkungsweise und Zeitpunkt von präventiven Maßnahmen.	- präventive Maßnahmen (klassische Präventionstriade)	informative Vermittlung
Sie sind sensibilisiert für gesundheitserzieherische Aspekte.	- Dysgnathien bei ausgewählten Syndromen	Herausarbeiten des Einflusses der Art der Nahrungsaufnahme, des Schluckens und der Atmung auf die normale Entwicklung des stomatognathen Systems und der orofazialen Funktionsabläufe sowie Ableiten von Folgen pathologischer Abläufe und Habits
Sie besitzen Kenntnisse über kieferorthopädische Möglichkeiten der Vorbeugung von Dysgnathien sowie der Beseitigung erster Symptome.	kieferorthopädische Prophylaxe und Frühbehandlung - Stillen, Flaschenernährung - Sondenernährung - Schlucken - Nasenatmung, Mundatmung - Parafunktionen • Bruxismus - Folgen des vorzeitigen Milchzahnverlustes • Lutschgewohnheiten • Dyskinesien	Darstellung kieferorthopädischer Interventionsmöglichkeiten sowie zu integrierende Fachbereiche
Sie sind fähig zur Ableitung von Handlungsmöglichkeiten der Logopäden.		
Sie sind motiviert zur interdisziplinären Zusammenarbeit.		
Sie kennen die Normabweichungen und die häufigsten Störungsbilder.	kieferorthopädische Diagnostik - Anamnese - Befunderhebung - Befunddokumentation (Modell, Röntgendokumentation, Fotodokumentation) - Auswertung und Diagnose - Klassifikation der Anomalien (Klassifikationsmöglichkeiten) - Ursachen und Erscheinungsbild der wichtigsten Anomalien	Grobdarstellung der Anamneseinhalte und des Untersuchungsgangs; Andeutung moderner apparativer Möglichkeiten (z. B. elektronische Axiographie)
Sie besitzen Kenntnisse über diagnostischer Verfahren in der Kieferorthopädie.		
Sie beherrschen die Fähigkeiten im Umgang mit kieferorthopädischen Diagnosen.	kieferorthopädische Therapie (extraoral/intraoral, apparativ/nichtapparativ, Kombinationen, zeitlicher Ablauf der Therapie, Motivation)	Verdeutlichung des Stellenwertes logopädischer Maßnahmen für den Therapieerfolg bei ausgewählten kieferorthopädischen Maßnahmen; Einbeziehen von eigenen Erfahrungen der Schüler
Sie haben Kenntnisse über kieferorthopädische Behandlungsmethoden und erkennen gemeinsame Zielstellungen von Kieferorthopäden und Logopäden.		

6.8.5 Pathologie der Kauorgane (ca. 3 Stunden)

Die Schüler besitzen Grundkenntnisse über Entzündungen, Verletzungen und Tumoren bezüglich des Lerngebiets sowie ihre Auswirkungen auf die Sprechfunktion.	Entzündungen, Verletzungen und Tumoren im Bereich der Kauorgane - Entzündungen (Ursachen, Symptome, Verlauf, Komplikationen, Diagnostik, Therapie) - Verletzungen (Wunden, Frakturen, Luxationen, Kontusionen; Ursachen, Symptome, Verlauf, Komplikationen, Diagnostik, Therapie) Tumoren (benigne, maligne; Tumorstadien, TNM-Klassifikation, Therapiemöglichkeiten)	Wiederholung und störungsspezifische Anwendung von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie sowie Pathologie; Diskutieren einfacher Fälle hinsichtlich ihrer Relevanz für die logopädische Praxis
--	--	---

6.9 Phoniatrie (150 Stunden)

Lernabschnitte

1	Einführung in die Phoniatrie	ca. 1 Stunde
2	Die Sprachentwicklung und ihre Störungen	ca. 35 Stunden
3	Sprach- und Sprechstörungen durch Hörbehinderung	ca. 8 Stunden
4	Funktionelle und organische Störungen der Nasalität	ca. 8 Stunden
5	Organische und funktionelle Stimmstörungen	ca. 36 Stunden
6	Rehabilitation nach Kehlkopfoperationen	ca. 10 Stunden
7	Peripher bedingte Sprechstörungen	ca. 8 Stunden
8	Störungen des Redeflusses (Stottern, Poltern)	ca. 18 Stunden
9	Zentrale Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen bei Erwachsenen	ca. 6 Stunden
10	Sprach- und Sprechstörungen infolge zerebraler Bewegungsstörungen	ca. 8 Stunden
11	Schluckstörungen	ca. 12 Stunden

Zeitrichtwerte

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.9.1 Einführung in die Phoniatrie (ca. 1 Stunde)		
Die Schüler haben einen Überblick über die Entwicklung, Zielstellungen und Aufgaben des Lerngebiets Phoniatrie.	- Einführung in das Lerngebiet - Historie	Beziehungen der Phoniatrie zu anderen Lerngebieten herstellen; Klärung von Fachtermini
6.9.2 Die Sprachentwicklung und ihre Störungen (ca. 35 Stunden)		
Die Schüler kennen die wichtigsten vorsprachlichen und sprachlichen Entwicklungsschritte, ihre Voraussetzungen sowie fördernde und hemmende Faktoren der physiologischen Sprachenwicklung.	physiologischer Spracherwerb - Sprachentwicklung und allgemeine Entwicklung - Voraussetzungen des normalen Spracherwerbs - präverbale Phase - verbale Phase • Lauterwerb • Wortschatzerwerb • Grammatik- und Syntaxerwerb - Einflussfaktoren - Kriterien zur Einschätzung des Sprachentwicklungsstandes	Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Logopädie, Pädiatrie und Neuropädiatrie, Psychologie und klinische Psychologie, Phonetik/Linguistik; Besprechen verschiedener Sprachentwicklungstheorien; Verlauf der Sprachentwicklung zeitlich und inhaltlich darstellen; Einsatz von Übersichten und Hörbeispielen; Arbeit mit Fallbeispielen; Erarbeitung sprachentwicklungsfördernder bzw. -hemmender Faktoren und Verhaltensweisen
Sie besitzen Kenntnisse über Ursachen, Symptomatik und Einteilungsmöglichkeiten von Sprachentwicklungsstörungen.	die Sprachentwicklungsstörung (SES) - Definition - Ursachen (peripherorganische, zentralorganische, psychogene, psychosoziale usw.) - differentialdiagnostische Abgrenzung von Ursachen und Begleiterscheinungen bei Störungen der Motorik, Perzeption usw. - Symptome (Störungen der rezeptiven und expressiven Leistungen auf den verschiedenen Sprachebenen)	Reaktivieren von Kenntnissen aus den Lerngebieten Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Neurologie und Psychiatrie, Pädiatrie und Neuropädiatrie, Psychologie und klinische Psychologie sowie Soziologie; Abgrenzung Sprachentwicklungsstörung/sich anbahnende SES; ätiologische Faktoren bezüglich isolierter SES erarbeiten, SES bei weiteren Störungsbildern (peripheren Hör- und Sehstörungen, Störungen der Perzeption sowie integrativer Funktionen und im Rahmen globaler Entwicklungsstörungen); Vorstellen verschiedener Einteilungsmöglichkeiten
Sie sind mit den Störungen des phonologischen, semantischen und morphologisch-syntaktischen Systems sowie der Sprachentwicklung bei Mehrfachbehinderungen vertraut.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben einen Überblick über das diagnostische Spektrum bei Sprachentwicklungsstörungen sowie über ausgewählte Verfahren zur Einschätzung der rezeptiven und expressiven Sprachleistungen. Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer interdisziplinären Diagnostik und sind fähig zur differential-diagnostischen Abgrenzung.	- Einteilung der Sprachentwicklungsstörungen (nach klinisch-neurologischen, linguistischen und ätiologischen Aspekten bzw. Faktoren) Diagnostik - Anamneseerhebung phoniatriisch-pädaudiologische Diagnostik - logopädische Untersuchung - ergänzende Untersuchungen von diagnostischer Bedeutung (Wahrnehmung, Motorik, Entwicklung, mentaler Bereich, Visus, Verhalten usw.) - Differentialdiagnostik (Abgrenzung gegenüber erworbenen, zentral bedingten Sprech- und Sprachstörungen sowie Mutismus und Autismus)	Kenntnisse aus dem Lerngebiet Audiologie und Pädaudiologie einbeziehen; Erarbeitung störungsspezifischer Anamneseinhalte (vgl. Lerngebiet Logopädie); Vorstellen verschiedener Untersuchungsverfahren zur Einschätzung des Sprachentwicklungsstandes (Beobachtungs-, Screening- sowie standardisierte Testverfahren) vgl. Lerngebiete Psychologie und klinische Psychologie, Pädiatrie und Neuropädiatrie
Sie besitzen einen Überblick über interdisziplinäre Therapiemöglichkeiten. Sie kennen die allgemeinen Behandlungsgrundsätze sowie die Kriterien zur Therapiebedürftigkeit und Prognose. Sie beherrschen die Fähigkeit zur Therapieplanerstellung.	Therapie - allgemeine Therapieansätze - interdisziplinäre rehabilitative Maßnahmen - Therapieplanerarbeitung - Prognose (Kriterien, Problematik der Mehrfachbehinderung)	Abstimmung mit dem Lerngebiet Logopädie; Darstellung des therapeutischen Vorgehens in Abhängigkeit vom Lebens- bzw. Entwicklungsalter, den Ursachen und begleitenden Störungen; Aufzeigen nonverbaler und verbaler Förderbereiche sowie des Stellenwertes der Elternarbeit; Eingehen auf lernpsychologische Grundprinzipien (Sprechmotivation, Assoziation, Verstärkung usw.); Arbeit mit Fallbeispielen
Sie verfügen über Kenntnisse der Symptomatik und Diagnostik der Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS), der therapeutischen Möglichkeiten und ihrer Grenzen. Sie begreifen die Notwendigkeit einer rechtzeitigen Diagnostik und Therapie. Sie haben Kenntnisse über den Umgang mit der LRS während der Schulausbildung. Sie haben Einblick in mögliche Sondermaßnahmen sowie versicherungs- und sozialrechtliche Fragen.	Störungen der Schriftsprache - Voraussetzungen für den Schriftspracherwerb - Ursachen für Lese-Rechtschreib-Störungen - Formen und Manifestationszeitpunkt - Symptome • primäre • sekundäre - Anamnese - Diagnostik (Inhalte: z. B. Überprüfung von Visus, Gehör, auditive und visuelle Perzeptionsfähigkeit, Intelligenz, Lese-, Rechtschreibproben)	Erlernen der Schriftsprache darstellen; Diskussion möglicher Ursachen, besonders auch des Zusammenhangs von Sprachentwicklungsstörung und LRS; Erarbeiten notwendiger Untersuchungsschritte und Ableiten wesentlicher Folgen eines zu späten Erkennens der Störung (sekundäre Symptome); Abgrenzung gegenüber Störungen des Schriftspracherwerbs aufgrund von Seh- oder Hörbehinderungen, neurologischen Erkrankungen usw.

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- Differentialdiagnostik - Prophylaxe - Therapie der LRS - Prognose - versicherungs- und sozial-rechtliche Beurteilung der LRS	Erläuterung prophylaktischer Maßnahmen wie z. B. Differenzierungsproben und Trainingsprogramme zur Verbesserung des Differenzierungsniveaus vor Schulbeginn; Eingehen auf mögliche Therapiewege; Informationen zur Finanzierung einer Therapie, zu Möglichkeiten der Eingliederungshilfe (BSHG) und Sondermaßnahmen (z. B. LRS-Klassen, Fördergruppen)
6.9.3 Sprach- und Sprechstörungen durch Hörbehinderung (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler erfassen die Zusammenhänge zwischen Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen einerseits und Hörstörungen andererseits bei Kindern und Erwachsenen.	Auswirkungen von Hörbehinderungen auf die: - rezeptive und expressive Sprachleistung (Lautbildung, Wortschatz, Grammatik) - Atmung - Phonation - Prosodie - Nasalität - intellektuelle, emotionale und soziale Entwicklung	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Audiologie und Pädaudiologie, Logopädie, Abstimmung mit den Lerngebieten Pädagogik sowie Sonderpädagogik; Aufzeigen von Besonderheiten der Sprachentwicklung bei Hörbehinderten;
Sie besitzen Kenntnisse über Art und optimalen Zeitpunkt diagnostischer, therapeutischer und rehabilitativer Maßnahmen sowie Folgen einer unbehandelten Hörstörung und die Einsicht in die Notwendigkeit der Früherkennung.	Diagnostik - subjektive und objektive Untersuchungsverfahren in Abhängigkeit vom Alter	Auswirkungen von Hörbehinderungen in Abhängigkeit von Ursachen, Lokalisation, Art, Schweregrad und Zeitpunkt des Auftretens einer Hörstörung herausarbeiten; Berücksichtigung progredient verlaufender Hörstörungen
Sie verfügen über reaktivierte Kenntnisse.		
Sie haben Kenntnis von Faktoren, die die Art therapeutischer und rehabilitativer Maßnahmen bestimmen.	therapeutische und rehabilitative Möglichkeiten - Frühförderung - operative und prothetische Maßnahmen in Abhängigkeit von Typ und Schweregrad der Hörstörung - Besonderheiten bei der Rehabilitation von Cochlea Implantat-Trägern - sprachliche Rehabilitation - interdisziplinäre Maßnahmen - Problematik der Mehrfachbehinderung	Darstellung des rehabilitativen Spektrums mit besonderer Akzentuierung medizinischer Aspekte; weitere Maßnahmen (störungsspezifische logopädische Therapie, soziale Integration, Beschulungsmöglichkeiten nur aufzeigen, genauere Behandlung erfolgt in den Lerngebieten Logopädie und Sonderpädagogik; Hinweis auf Nachteile für den Betroffenen im Hinblick auf die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben
Sie besitzen die Einsicht in die Notwendigkeit einer interdisziplinären Rehabilitation.		
Sie kennen die Prognosekriterien.	Prognose - Prognosekriterien (Ätiologie, Art und Schweregrad der Hörstörung, Intelligenz, psychosoziale Situation, Zeitpunkt des Erkennens und des Beginns rehabilitativer Maßnahmen usw.)	Arbeit mit Fallbeispielen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.9.4	Funktionelle und organische Störungen der Nasalität (ca. 8 Stunden)	
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die organischen und funktionellen Ursachen des Näsels sowie Grund- und Begleiterkrankungen.	- Nasalität und Näseln - Rhinophonie und Rhinolalie Einteilung der Nasalitätsstörungen (Rhinophonia aperta, clausa, mixta) Ursachen	Abgrenzung der normalen Nasenresonanz gegenüber pathologischen Veränderungen des Sprachschalls und der Artikulation
Sie verfügen über Kenntnis der verschiedenen Formen und jeweiligen charakteristischen Symptome sowie über die Auswirkungen des Näsels auf das Gehör, die Stimme, die Sprach- und psychische Entwicklung.	- Rhinophonia aperta (Hyperrhinophonie) • funktionelle Ursachen: (nachlässige Artikulation, allgemeiner Hypotonus, Nachahmung, postoperative Schonhaltung, Innenohrschwerhörigkeit usw.) • organische Ursachen: (angeborene: Missbildungen des Gaumens, submuköse Gaumenspalten, kurzer Gaumen, Gaumensegellähmungen, frühkindlicher Hirnschaden usw., erworbene: OP-Folgen, Verletzungen, Tumoren, Meningitis usw.) - Rhinophonia clausa (Hyporhinophonie) • funktionelle Ursachen • organische Ursachen (Choanalatresien, Septumdeviation, Adenoide Vegetationen usw.) - Rhinophonia mixta • funktionelle Ursachen • organische Ursachen Symptome der verschiedenen Näselformen - Phonetik der Rhinophonien - mögliche Schluckstörungen	Darstellen der Funktionsabläufe bei der Relaxations- bzw. Konstriktionsnasalität; Einbeziehen von Kenntnissen über die Ursachen, Formen und Folgen von Spaltbildungen (Ernährungsschwierigkeiten, Nasalitäts-, Sprachentwicklungs- und Sprachstörungen, Störung der Mittelohrbelüftung, Okklusionsstörungen usw.); Arbeit mit Fallbeispielen; Abstimmung mit dem Lerngebiet Kieferorthopädie, Kieferchirurgie Herleiten der Veränderungen bei Vokalen und Konsonanten, siehe auch Lerngebiete Phonetik/ Linguistik sowie Logopädie
Sie besitzen Kenntnis der diagnostischen Möglichkeiten bei den verschiedenen Näselformen.	Diagnostik diagnostische Möglichkeiten bei den verschiedenen Näselformen wie: - endoskopische Untersuchungen - Beurteilung der Gaumensegelfunktion (reflektorisch, phonatorisch) - bildgebende Verfahren - spezielle Nasalitätsproben	Vorstellung und Demonstration ausgewählter diagnostischer Verfahren zur Abgrenzung der verschiedenen Näselformen (z. B. Inspektion und Endoskopie, A-I-Probe nach Gutzmann, Spirometrie, Auskultationsprobe, Spiegelprobe, Probe nach Schlesinger, RDVM-Einschätzung nach Mühler)

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen konservative und operative Behandlungsverfahren in Abhängigkeit von Ursachen und Lebensalter.	Therapie - Behandlung organischer Formen (korrigierende chirurgische Eingriffe, medikamentöse Therapie, prothetische Maßnahmen, ergänzende konservative Maßnahmen)	Primat der kausalen Therapie aufzeigen
Sie haben Verständnis für die interdisziplinäre Diagnostik und Therapie.	- Behandlung funktioneller Störungen (logopädische Übungstherapie)	Ableiten der Zielstellung und von Therapieschwerpunkten; Bezug zum Lerngebiet Logopädie
Sie verfügen über Kenntnisse der allgemeinen Prognose der einzelnen Therapiemöglichkeiten.	Prognose Prognosekriterien	

6.9.5 Organische und funktionelle Stimmstörungen (ca. 36 Stunden)

Die Schüler besitzen reaktivierte und vertiefte Kenntnisse.	Anatomie, Physiologie und Pathophysiologie der Funktionskreise: - Atmung (Aufbau und Funktion des Atemapparates, Atemformen, Lungenvolumina, Ruhe- und Phonationsatmung, Atemstütze)	Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Stimmbildung und Logopädie; Vorstellen des Hör-Sprach-Kreises; Einsatz von Anschauungsmaterial; Vorstellen der Stimmerzeugungstheorien;
Sie können Zusammenhänge erkennen und verstehen.	- Phonation (Aufbau und Funktionen des Kehlkopfes, Stimmerzeugung) - Artikulation (Aufbau und Funktionen des Ansatzrohres) - physikalische Grundlagen von Stimme und Sprachlauterzeugung (Schall, Frequenz und Tonhöhe, Amplitude und Lautstärke: Ton, Klang, Geräusch, Eigenfrequenz und Resonanz) - zentrale Steuerung	Gegenüberstellen der normalen und gestörten Stimmgebung; Primär- und Sekundärfunktionen des Vokaltraktes erarbeiten, dabei besonders auf die artikulatorische und phonatorische Funktion eingehen; Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Phonetik/Linguistik, gegenseitige Beeinflussung der verschiedenen Funktionskreise herausarbeiten; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie haben Kenntnisse über die normale Stimmentwicklung.	Entwicklung der Stimme (Kindes-, Jugend-, Erwachsenen- und Greisenalter)	Charakterisieren der verschiedenen Entwicklungsphasen
Sie kennen die Möglichkeiten der Stimmhygiene und besitzen Einsicht in die Notwendigkeit dieser.	Stimmhygiene - allgemeine stimmhygienische Maßnahmen - spezielle stimmhygienische Maßnahmen	Eingehen auf die stimmhygienischen Maßnahmen in den verschiedenen Lebensaltern in Abstimmung mit den Lerngebieten Stimmbildung, Sprecherziehung und Logopädie
Sie sind sicher im Umgang mit detailliertem Wissen über die physiologischen Stimmleistungen.	Merkmale und Leistungen der Stimme - Leistungen der Sprechstimme - Leistungen der Singstimme - Sängerstimme	Erarbeiten der Voraussetzungen für eine sichere Diagnostik und individuelle störungsspezifische Therapie von Stimmstörungen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie können Zusammenhänge erkennen und verstehen.	Einflussfaktoren auf die Stimme (Körperlichkeit, Persönlichkeit, Sprechsituation usw.)	wechselseitige Beziehung der Einzelaspekte herausarbeiten
Sie haben Einblick in besondere Stimmformen.	besondere Stimmformen (Flüsterstimme, Bauchrednerstimme, Jodelstimme, Pfeifen usw.)	Vorstellen ausgewählter Stimmformen; Arbeit mit Hörbeispielen
Sie kennen störungsspezifische Anamneseinhalte sowie wesentliche Aspekte einer organ- und funktionsbezogenen Diagnostik.	Untersuchungsmethoden der Stimme - Anamneseerhebung - phoniatische Untersuchung • Atmung (subjektive Beurteilung von Atemform, -frequenz und -tiefe, Auskultation, Perkussion, röntgenologische und endoskopische Untersuchungen, Funktionsdiagnostik usw.; • Kehlkopf (Laryngoskopie, Stroboskopie, bildgebende Verfahren, EMG, Elektrolottographie, Spektralanalyse, Hochgeschwindigkeitskinematographie usw.) • Ansatzrohr (Beurteilung des Aufbaus und der Funktion der Artikulationsorgane, wie z. B. Beweglichkeit der Zunge und des Gaumensegels, Endoskopie und bildgebende Verfahren)	Ableiten notwendiger Fragestellungen und Vorstellen von Fallbeispielen Vorstellen spezieller Untersuchungsmethoden zur Beurteilung von Atmung, Kehlkopf und Artikulationsorganen
Sie erfassen den Stellenwert der auditiven Stimmbeurteilung.	- Stimmstatus (subjektive und objektive Beurteilung und Dokumentation der Stimme und der Stimmleistungen)	Methoden und Verfahren zur Beurteilung des Stimmklanges (RBH-Schema), der Stimmeinsätze, Sprechstimmlage, des Stimmumfangs usw. unter Berücksichtigung von Kenntnissen aus den Lerngebieten Stimmbildung, Sprecherziehung und Logopädie besprechen;
Sie besitzen Kenntnisse über zu beurteilende Leistungen, Klassifizierungsschemata sowie instrumentelle und apparative Hilfen.	- ergänzende Diagnostik	Darstellen von Besonderheiten der Sing- und Sängerstimme; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit eventueller Zusatzuntersuchungen.		
Sie besitzen spezifische Kenntnisse über pathophysiologische Störungen der Stimme.	Ursachen, Symptome und Befunde bei Stimmerkrankungen - organische Dysphonien (Missbildungen, Entzündungen, Lähmungen, Tumoren und Verletzungen des Kehlkopfes) - funktionelle Dysphonien • ätiologische Faktoren (konstitutionelle, habituelle, psychogene, somatische)	Aufzeigen von Einteilungsmöglichkeiten; Eingehen auf Stimmstörungen bei Mehrfachschädigung; innere und äußere Wirkfaktoren bei der Entstehung einer Dysphonie diskutieren
Sie beherrschen die Fähigkeit zur differenzialdiagnostischen Abgrenzung in Abhängigkeit von der Ätiologie.		Hauptkomponenten der Entstehung funktioneller Dysphonien herausarbeiten;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	• Erscheinungsformen (hyperfunktionelle Dysphonie einschließlich Taschenfaltensstimme, hypofunktionelle Dysphonie, Dysphonia mixta, Aphonien)	ätiopathogenetische Wechselwirkung von organischen und funktionellen Dysphonien verdeutlichen Merkmale der gesunden Stimme denen der gestörten gegenüberstellen
Sie können den Zusammenhang von Stimmgebung und Psyche erfassen.	- spasmodische Dysphonie - hormonelle Stimmstörungen - Dysodien	Einsatz von Hörbeispielen; Bedeutung des Verhältnisses von konstitutionellen Voraussetzungen und Stimmbelastung bezüglich der Entstehung funktioneller Dysphonien diskutieren; Zusammenhang von Hör- und Stimmstörungen unter 6.9.3 behandeln
Sie kennen die organischen, funktionellen und psychosozialen Folgen von Stimmstörungen.	- sekundär organische Veränderungen (Hyperämie, Stimmlippenknötchen, -polypen, -ödeme usw.) - psychosoziale Auswirkungen von Stimmstörungen	
Sie erkennen die Bedeutung vorbeugender Maßnahmen.	prophylaktische Möglichkeiten	unter anderem Stellenwert einer Tauglichkeitsuntersuchung herausheben
Sie verfügen über Kenntnisse unterschiedlicher Behandlungsformen und der Prinzipien der Behandlungsführung.	Therapie von Stimmstörungen - medikamentöse Therapie - phonochirurgische Maßnahmen	Einblick in die medizinische Therapie geben, besonders auf stimmverbessernde und glottiserweiternde Operationen eingehen; Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde
Sie besitzen einen Überblick über stimmtherapeutische Methoden.	- logopädische Therapie	Prinzipien der Behandlungsführung (Einzel-, Gruppentherapie, stationäre Therapiemöglichkeiten, ihre Vor- und Nachteile sowie Indikation) darstellen; Therapiebereiche und -schwerpunkte in Abhängigkeit von der Genese und psychosozialen Situation aufzeigen; Indikation, Kontraindikationen sowie Durchführung der Reizstromtherapie erläutern; kompensatorische Möglichkeiten (z. B. erwünschte Taschenfaltensstimme) aufzeigen; Hinweis auf besondere Maßnahmen bei Berufssprechern; Abstimmung mit dem Lerngebiet Logopädie; Überblick über interdisziplinäre therapeutische Maßnahmen geben
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit der interdisziplinären Zusammenarbeit und sind dazu bereit und motiviert.	- ergänzende Therapiemaßnahmen (Psychotherapie, physikalische Therapie usw.)	

6.9.6 Rehabilitation nach Kehlkopfoperationen (ca. 10 Stunden)

Die Schüler verfügen über reaktivierte Kenntnisse.	operative Eingriffe am Kehlkopf bei benignen und malignen Tumoren - Indikationen	Berücksichtigung vorhandenen Wissens aus den Lerngebieten Pathologie und Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde;
--	---	---

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über mögliche operative Vorgehensweisen.	- Methoden (z. B. Dekordikation, Chordektomie, Thyreotomie, Teilresektionen, Laryngektomie)	Eingehen auf das methodische Vorgehen bei gut- und bösartigen Tumoren und Kehlkopfverletzungen; Darstellung stimmverbessernder und glottiserweiternder Operationen erfolgt unter 6.9.5
Sie erkennen die Notwendigkeit der Tracheotomie bei verschiedenen Kehlkopfoperationen. Sie haben Kenntnisse über die Kanülenversorgung und weitere Hilfsmittel. Sie kennen die anatomischen und physiologischen postoperativen Verhältnisse sowie die sich daraus ergebenden Konsequenzen. Sie erfassen den Stellenwert der Frühdiagnose bei bösartigen Tumoren. Sie haben einen Überblick über Wirkung und mögliche Auswirkungen. Sie besitzen reaktivierte und vertiefte Kenntnisse. Sie sind sensibilisiert für die psychosozialen Probleme Betroffener.	- Tracheotomie (Indikation, Kanülenversorgung, Komplikationen) - postoperative Komplikationen - organische und funktionelle Folgen (Mundhöhle, Pharynx, Larynx, Trachea, Ösophagus, Halsbereich) - Folgeerscheinungen nach Chemo- und Strahlentherapie bei malignen Tumoren - Auswirkungen auf die psychosoziale und sozioökonomische Situation der Patienten	besonders auf die Pflege und den Wechsel von Trachealkanülen eingehen und Möglichkeiten der Pflege vorstellen; Komplikationsmöglichkeiten aufzeigen; Übersicht über erhaltene und veränderte Funktionen geben; Herausarbeiten der Auswirkungen auf die Atmung und Stimme
Sie verfügen über reaktivierte, erweiterte und gefestigte Kenntnisse.	Rehabilitation nach Kehlkopfoperationen - Therapieansätze (unter Berücksichtigung der Grunderkrankung sowie der aktuellen postoperativen Situation)	Abstimmung mit dem Lerngebiet Logopädie Situation nach Laryngektomie detailliert behandeln;
Sie haben Kenntnisse über die postoperative Rehabilitation Laryngektomierter.	- Rehabilitation nach Laryngektomie	Inhalte der phasenspezifischen Beratung erarbeiten; Vorstellen von Verfahren zur Anbildung der Ösophagusersatzstimme und Möglichkeiten einer apparativen und chirurgischen Stimmrehabilitation sowie ihrer Vor- und Nachteile; Demonstration von Hilfsmitteln
Sie haben Verständnis für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit im Rehabilitationsteam.	• prä- und postoperative Beratung des Patienten und seiner Angehörigen • medizinische Betreuung • Stimmrehabilitation (Formen, Indikation, Einflussfaktoren)	Eingehen auf Arbeitsfähigkeit und mögliche Sozialleistungen (Schwerbehindertengesetz BSHG, Rehabilitations-Angleichungsgesetz);
Sie können den Auftrag des Logopäden erfassen.	• medizinisch-technische Hilfsmittel zur allgemeinen postoperativen Versorgung • rechtliche und soziale Fragen insbesondere bei Laryngektomie	Verbindung zum Lerngebiet Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde herstellen; Einbeziehen von Aufklärungsmaterial, Informationsblättern usw.;
Sie haben einen Überblick über die Hilfsmittel.	• Reintegration (psychologische Rehabilitation, Selbsthilfegruppen, Bundesverband der Kehlkopflosen e. V.)	Stellenwert der psychologischen Rehabilitation herausarbeiten; Zusammenhang von Sprechfähigkeit sowie beruflicher und sozialer Wiedereingliederung aufzeigen; Kenntnisse aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie sowie Soziologie einbeziehen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.9.7 Peripher bedingte Sprechstörungen (ca. 8 Stunden)		
Die Schüler verfügen über reaktiviertes, anwendungsbereites und vertieftes Wissen.	Dysglossien	Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Kieferorthopädie, Kieferchirurgie, Neurologie und Psychiatrie;
Sie kennen Artikulationsstörungen infolge organischer Erkrankungen im Bereich der peripheren Nerven und der Sprechorgane.	- Definitionen	Versorgungsgebiete der Hirnnerven V, VII, IX, X und XII wiederholen sowie die Ursachen und Folgen von Lähmungen dieser Nerven ableiten;
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Abgrenzung der Dysglossien gegenüber zentral bedingten Sprechstörungen.	- Einteilungsmöglichkeiten (nach Ätiologie, Lokalisation, usw.)	Abgrenzung von peripheren und zentralen Lähmungen vornehmen; Zusammenhänge zwischen Veränderungen des Kiefer- und Zahnsystems und Artikulationsstörungen sowie die enge Beziehung zu orofazialen Dysfunktionen aufzeigen; Eingehen auf Verletzungs- und Operationsfolgen; Dysglossien infolge Lippen-Kiefer-Gaumenspalten, siehe unter 6.9.4
	- Ursachen (kongenitale, traumatische, postoperative, paralytische)	
	- Symptomatik	
Sie haben einen Überblick über die Untersuchungsmethoden bei Dysglossien hinsichtlich ihrer Genese.	- Diagnostik (morphologischer und funktioneller Befund, phonetisch-phonologische Überprüfung)	Wissen aus dem Lerngebiet Logopädie einbeziehen; Aufgaben der Logopäden im interdisziplinären Team herausarbeiten;
Sie verfügen über Kenntnisse zur differentialdiagnostischen Abgrenzung.	- Differentialdiagnostik	saubere Abgrenzung gegenüber: Dyslalie, Dysarthrophonie, Sprechapraxie und Aphasie; Notwendigkeit ergänzender logopädischer Maßnahmen bei labialen, dentalen, lingualen und/oder palatalen Dysglossien unterstreichen; vgl. Lerngebiete Kieferorthopädie, Kieferchirurgie sowie Logopädie
Sie besitzen einen Überblick über das therapeutische Vorgehen.	- Kriterien zur Behandlungsbedürftigkeit und Prognose	
	- Therapie	
	• chirurgische Behandlung	
	• medikamentöse Therapie	
	• Artikulationstherapie	
	• prothetische Maßnahmen	
6.9.8 Störungen des Redeflusses (Stottern, Poltern) (ca. 18 Stunden)		
Die Schüler kennen die Ätiologie und Pathogenese des Stotterns.	Stottern	Auseinandersetzung mit den disponierenden, auslösenden und aufrechterhaltenden Faktoren des Stotterns sowie den verschiedenen Entstehungstheorien und Modellen zur Erklärung des Stotterns
	- Definition und Synonyme	
	- Ursachen, Theorien und Modelle der Entstehung des Stotterns (Diagnosogene Theorie, Kontinuitätshypothese, Anforderungs- und Kapazitätenmodell usw.)	
	- disponierende, auslösende und aufrechterhaltende Faktoren	
Sie sind fähig zur Unterscheidung von physiologischen Sprechungsflüssigkeiten und Störungen des Redeflusses.	- Beginn und Verlauf des Stotterns	Gegenüberstellung physiologischer und pathologischer Erscheinungen;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die Primär- und Sekundärsymptomatik.	• normale und entwicklungsbedingte Sprechunflüssigkeiten • beginnendes Stottern • chronisches Stottern (Schulkind-, Jugend-, Erwachsenenalter)	Übergang von Entwicklungsunflüssigkeiten zum Stottern herausarbeiten; Eingehen auf neurogenes, psychogenes Stottern und Stottern bei geistiger Behinderung; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Abgrenzung der verschiedenen Stotterformen.	- Formen des Stotterns - Symptomatik • Grundsymptomatik • Begleitsymptomatik • Sprachcharakteristika - Stottern und Gesellschaft (Familie, Kindergarten, Schule und Medien)	Kenntnisse aus dem Lerngebiet Sonderpädagogik einbeziehen; Einschränkungen für Stotterer aufzeigen, z. B. schulische und berufliche Nachteile
Sie besitzen einen Überblick über die Folgen des Stotterns.	- Diagnostik • Anamnese • Screening zur Unterscheidung zwischen Sprechunflüssigkeiten und Stottern • Spontansprachanalyse • Balbutiogramm • weiterführende Diagnostik	Inhalte der störungsspezifischen Anamnese erarbeiten; Früherkennungsverfahren (Johannsen/Schulze) vorstellen; Inhalte des Sprechstatus und Möglichkeiten der Datenermittlung aufzeigen; Einsatz von Fallbeispielen Arbeit mit Hörbeispielen
Sie haben Kenntnis des Untersuchungsganges und Einblick in die Methodik der Datenermittlung und Dokumentation.	- differentialdiagnostische Abgrenzung des Stotterns gegenüber: • Entwicklungsunflüssigkeiten • Poltern • Dysarthrie • spasmodischer Dysphonie usw.	Begründung der Existenz gegensätzlicher Therapieansätze (symptomatische, komplexe Therapieverfahren, verhaltens- und psychotherapeutische Ansätze) sowie Einblick in die Zielstellung und Wirkungsweise ausgewählter Verfahren
Sie haben die Einsicht in die Notwendigkeit einer altersabhängigen Therapie.	- Therapie • Therapieziele • Grundzüge der Therapie im Kindesalter (Prävention, frühzeitige Intervention, indirekte und direkte Therapie)	Einfluss der Therapeutenpersönlichkeit auf den Therapieerfolg unterstreichen
Sie kennen die Zielstellung, die Behandlungsformen sowie ihre Auswahlkriterien.	• Therapie Jugendlicher und Erwachsener (Hauptrichtungen der Stottertherapie: Fluency Shaping, Stuttering Modification und Kombination) ausgewählte Therapieansätze: Atemtherapie/ spannungsregulierende Methoden, Sprechhilfen und -techniken, VAR, Psychotherapie, computerunterstützte Stottertherapie usw. sowie kombinierte Ansätze nach van Riper, Wendlandt usw.	Einfluss der Therapeutenpersönlichkeit auf den Therapieerfolg unterstreichen
Sie haben einen Überblick über spezifische Anforderungen an eine Stottertherapie im Kindesalter und über Therapieverfahren für das Jugend- und Erwachsenenalter.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben einen Einblick in das Anliegen und die Arbeit der Selbsthilfegruppen.	- Stotterer-Selbsthilfegruppen	Vorstellen der Zielstellungen und Aufgaben; Stellenwert für die Rehabilitation des Stotterers herausarbeiten
Sie besitzen einen Überblick über spezifische Prognosekriterien.	- Prognose des Stotterns	Aufzeigen der Faktoren, die für eine günstige bzw. ungünstige Prognose sprechen
Sie kennen Ätiologie, Symptomatik und Erscheinungsformen des Polterns.	Poltern - Definition und Synonyme - Symptome (sprachliche, nichtsprachliche, obligatorische, fakultative) - Ursachen - Formen (z. B. Entwicklungspoltern, ideogenes, paraphrasisches und situationsbedingtes Poltern)	Herausarbeiten der Unterschiede und Überschneidungen zwischen Poltern und Stottern in Ätiologie und Symptomatik
Sie kennen die Untersuchungsinhalte und haben einen Überblick über mögliche Vorgehensweisen.	- Diagnostik	ausgewählte Vorgehensweisen (z. B. nach Weiss, Liebmann) vorstellen
Sie beherrschen die Fähigkeit zur differenzialdiagnostischen Abgrenzung des Polterns.	- Differentialdiagnostik (Tachylalie, Stottern, normale Redeunflüssigkeiten, Redeunflüssigkeiten bei extrapyramidalen Erkrankungen usw.)	Gegenüberstellen der physiologischen Varianten und Störungsbilder
Sie kennen die	- Therapie (Kindes- und Erwachsenenalter)	altersadäquates therapeutisches Vorgehen vorstellen
- Grundprinzipien der Poltertherapie;	- Prognose	(Zielstellungen, Therapieinhalte und -schwerpunkte); Verlauf des Polterns aufzeigen
- Besonderheiten im therapeutischen Vorgehen.	Kombinationsmöglichkeiten - Polter-Stottern - Stottern mit Polterkomponente	Arbeit mit Fallbeispielen

6.9.9 Zentrale Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen bei Erwachsenen (ca. 6 Stunden)

Die Schüler besitzen reaktivierte und fachspezifisch erweiterte Kenntnisse über psychiatrische Erkrankungen.	Sprach-, Sprech-, Stimmstörungen bei psychiatrischen Erkrankungen	Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Neurologie und Psychiatrie
Sie kennen interdisziplinäre Therapiemöglichkeiten und ihre Grenzen.	phoniatische Symptomatik, Diagnostik, differentialdiagnostische Abgrenzung, Therapiemöglichkeiten und Prognose bei: - Hirnerkrankungen z. B. • Alzheimerkrankheit • senile Demenz • apallisches Syndrom • psychoorganisches Syndrom	Behandlung der Grunderkrankung aufzeigen, besonders aber auf die Möglichkeiten der logopädischen Therapie eingehen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- Psychosen • endogene Psychosen (Schizophrenien, manisch-depressive Erkrankungen) • exogene Psychosen (Alkoholkrankheiten wie Alkoholrausch, -delir) - Autismus • frühkindlicher Autismus • autistische Psychopathie	schizophrene Sprechweise von Kindern und Erwachsenen gegenüberstellen; Symptome der manischen und depressiven Phase aufzeigen Kanner- und Asperger-Syndrom charakterisieren; Darstellen des möglichen Ablaufs einer Sprachtherapie sowie Aufzeigen anderer Therapieformen (Wahrnehmungstraining, tiefenpsychologische und heilpädagogische Programme usw.)
	- Mutismus - Oligophrenie - Epilepsie	Formen des Mutismus darstellen; Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Psychologie und klinische Psychologie; Aphasien, Dysarthrien und Sprechapraxie werden im Lerngebiet Aphasieologie behandelt

6.9.10 Sprach- und Sprechstörungen infolge zerebraler Bewegungsstörungen (ca. 8 Stunden)

Die Schüler besitzen einen Überblick über neurologische Erkrankungen und Störungsbilder, die mit zerebralen Bewegungsstörungen einhergehen können.	Zerebralparesen - Ursachen - Formen/Symptomatik (Spastik, Athetose, Ataxie, Hypotonie, Mischformen; Hemi-, Di-, Tetraplegie)	Aufzeigen wichtiger Verdachtszeichen für die Frühdiagnose; Charakteristik der verschiedenen Formen darstellen; Berücksichtigung von Wissen aus den Lerngebieten Pädiatrie und Neuropädiatrie sowie Neurologie und Psychiatrie
Sie verfügen über reaktivierte Kenntnisse.	- begleitende Störungen (Sprachentwicklungsstörungen, Dysarthrophonie, Rhinophonie, orofaziale Dysfunktionen, Hörstörungen)	Eingehen auf Besonderheiten im Entwicklungsverlauf; begleitende Störungen bei den jeweiligen Themen einbeziehen (6.9.2, 6.9.3, 6.9.4, 6.10);
Sie haben einen Überblick über die Inhalte einer störungsspezifischen Anamnese und die fachübergreifende Diagnostik.	- Diagnostik • Anamnese (Nahrungsaufnahme, Sprachentwicklung, Artikulation, Sozialverhalten) • Untersuchung (ärztliche, krankengymnastische, kieferorthopädische) - differentialdiagnostische Abgrenzung (z. B. Aphasie, Dysglossie sowie Form der CP)	besonders auf kindliche Dysarthrophonien eingehen; Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Logopädie Vergleich der normalen oralen Reflexe des Säuglings mit denen bei ICP
Sie kennen die Indikation, allgemeine Zielsetzung und Prognosekriterien der Therapie.	- Therapie • Therapieziel • Therapiebereiche • Frühbehandlung (Zielstellung, Schwerpunkte)	Fachbereiche im interdisziplinären Team und fachübergreifende Frühbehandlung bei CP vorstellen; Einblick in ausgewählte Therapieverfahren geben;
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer interdisziplinären Frühtherapie.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über die Inhalte der Basis- und logopädischen Therapie.	• Basistherapie (allgemeine Therapieansätze wie Physiotherapie, Ergotherapie, Bobath-Therapie, Vojta-Therapie, PNF, MFT usw.) • logopädische Therapie (Mund- und Esstherapie, Förderung der rezeptiven und expressiven Sprachleistungen, Behandlung dysarthrischer Störungen, unterstützende und alternative Kommunikationssysteme)	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Pädiatrie und Neuropädiatrie, Neurologie und Psychiatrie, Logopädie, Pädagogik, Sonderpädagogik und Soziologie
Sie erfassen die Bedeutung einer kontinuierlichen Eltern- bzw. Angehörigenberatung.	- Prognose - Beratung (Zielstellung, Inhalte)	Hervorheben der Bedeutung der Frühdiagnose zerebraler Bewegungsstörungen und des Therapiebeginns für die Prognose
6.9.11 Schluckstörungen (ca. 12 Stunden)		
Die Schüler verfügen über reaktivierte und vertiefte Kenntnisse der anatomisch-physiologischen Grundlagen des Schluckens.	der physiologische Schluckvorgang (orale, pharyngeale, ösophageale Phase; Schlucken in den verschiedenen Lebensaltern)	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie und Kieferorthopädie, Kieferchirurgie; Herausarbeiten altersbedingter Abweichungen in den einzelnen Schluckphasen sowie der Unterschiede von kindlichem und Schluckakt des Erwachsenen; Darstellung der normalen Schluckentwicklung vgl. auch Lerngebiete Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde sowie Neurologie und Psychiatrie; Klärung der Terminologie (z. B. Drooling, Leaking, Penetration); Einsatz von Anschauungsmaterial und Videofilmen; Klassifikationsvarianten aufzeigen
Sie kennen die Ursachen, Pathophysiologie und Einteilungsmöglichkeiten von Dysphagien.	der gestörte Schluckvorgang - Ursachen einer Dysphagie (organische, psychogene) - Symptome • direkte Symptome (Störungen in der oralen Vorbereitungsphase, der oralen, pharyngealen und ösophagealen Phase) • indirekte Symptome (Gewichtsabnahme, Hustenzwang, Exsikose, wet voice, rezidivierende Pneumonien usw.) - Einteilung der Dysphagien • nach dem Zeitpunkt der Aspiration (prä-, intra- und postdeglutitive Aspiration) • Klassifikation nach dem Schweregrad der Aspiration	
Sie kennen altersspezifische Besonderheiten und haben einen Überblick über Störungen des Schluckaktes bei ausgewählten Krankheitsbildern.	- kindliche Schluckstörungen (Risikofaktoren und Ursachen für die Entstehung, infantiles Schluckmuster) - Schluckstörungen im Alter - Dysphagien bei ausgewählten Erkrankungen	Eingehen auf das infantile Schluckmuster bei orofazialen Dysfunktionen sowie die Ursachen des gehäufteten Auftretens von Presbyphagien; die Auswahl der Störungsbilder liegt im Ermessen der Lehrkraft
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer interdisziplinären Diagnostik.	- Diagnostik • Anamnese	Herleiten gezielter Fragestellungen zur spezifischen Schluckanamnese; Übersicht über die Schritte der Dysphagiediagnostik geben;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die Bedeutung und die Inhalte der störungsspezifischen Anamnese.	• Basisdiagnostik (klinische Beurteilung, endoskopische Untersuchungsverfahren, radiologische Diagnostik) • weiterführende Diagnostik (in Abhängigkeit von der Genese)	kooperierende Fachdisziplinen aufzeigen, besonders auf die Aufgaben der Logopäden eingehen; Einsatz von Videoaufnahmen zu Befunddemonstrationen
Sie verfügen über Kenntnisse direkter und indirekter Hinweise auf eine Schluckstörung sowie möglicher Zeichen für eine stille Aspiration.	- Therapie • Sofortmaßnahmen • Behandlung der Grunderkrankung • funktionelle Therapie (Zielstellung, Prinzipien, kausale und kompensatorische Verfahren, Hilfsmittel, Essensregeln usw.) • chirurgische Interventionen	Vorstellen interdisziplinärer Therapieansätze sowie der Indikation verschiedener Vorgehensweisen; siehe auch Lerngebiet Logopädie
Sie besitzen einen Überblick über das Spektrum therapeutischer Maßnahmen bei Dysphagien.		
Sie kennen die Prognosekriterien und erkennen die Notwendigkeit und Bedeutung einer Patienten- und Angehörigenberatung.	- Prognose - Beratung	Einflüsse auf die Schlucktherapie aufzeigen Herausarbeiten des Stellenwertes einer kompetenten Führung der Patienten und ihrer Angehörigen; Aufzeigen von Beratungsinhalten

6.10 Aphasiologie (60 Stunden)

Lernabschnitte	Zeitrichtwerte
1 Zentral bedingte Störungen der Sprache	ca. 45 Stunden
2 Zentral bedingte Störungen des Sprechens und der Stimme	ca. 15 Stunden

6.10.1 Zentral bedingte Störungen der Sprache (ca. 45 Stunden)

Die Schüler erkennen den Zusammenhang von neuropsychologischen Leistungen des Gehirns und Störungen der Sprache, des Sprechens.	zentrale Störungen der Sprache, des Sprechens und der Stimme - Geschichte der Aphasiologie (Broca, Wernicke, Gall, Leischner usw.) - anatomisch-physiologische Grundlagen	allgemeine Einführung in die Problematik; Einbeziehen von Erlebnisberichten Betroffener; historischer Abriss
Sie haben einen Überblick über die geschichtliche Entwicklung des Fachgebiets.	• Aufbau des Gehirns (insbesondere der Großhirnrinde und spezielle Funktionen) • Lokalisationstheorie • zerebrale Dominanz und Lateralität • Blutversorgung des Gehirns	Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie sowie Neurologie und Psychiatrie
Sie verfügen über reaktivierte, gefestigte und erweiterte Kenntnisse.		
Sie kennen die Ursachen und Erscheinungsformen der Aphasien sowie die Auswirkungen auf den Patienten und das soziale Umfeld.	Aphasien - Ätiologie - Pathogenese - Symptome - Klassifikation (Standardsyndrome, Sonderformen, Leitsymptome)	Abstimmung mit dem Lerngebiet Neurologie und Psychiatrie; Arbeit mit Fallbeispielen; kritische Auseinandersetzung mit dem Syndromansatz; Eingehen auf die Besonderheiten der kindlichen Aphasien

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen einen Überblick über die gebräuchlichsten orientierenden und standardisierten Testverfahren.	- begleitende Störungen (Hemiparese, Gedächtnisstörungen, Akalkulie, Agnosie, Apraxie, Merk- und Gedächtnisstörungen, kognitive Störungen, zentrale Hörstörungen usw.) - Prognose (Prognosekriterien) - Auswirkungen auf die psychosoziale Situation - Diagnostik (Token-Test, Aachener Aphasie Bedside Test, Aachener Aphasie Test, Aphasie Checkliste, Basel Minnesota Test, Aphasie-Schnelltest nach Kroker usw.)	Auswahl liegt im Ermessen der Lehrkraft; Vermittlung von Grundkenntnissen, die im Lerngebiet Logopädie angewendet und praktisch vertieft werden
Sie verfügen über Kenntnisse - zur Abgrenzung zentraler Sprach- und Sprechstörungen sowie der Aphasieformen; - der Sprachverarbeitung im Gehirn. Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer interdisziplinären Rehabilitation. Sie besitzen Grundkenntnisse der Aphasietherapie.	- Differenzialdiagnostik der Aphasie - Sprachverarbeitungsmodelle - Besonderheiten der aphasischen Sprachverarbeitung in allen Modalitäten - Rehabilitation des Aphasikers • Zielstellungen der medizinischen, beruflichen und sozialen Rehabilitation • Bausteine der Aphasiebehandlung (Akutversorgung, Reha-Klinik, ambulante Therapie) • Phasen der sprachlichen Rehabilitation (Aktivierung, störungsspezifische Therapie, Konsolidierung, Beratung) • störungsspezifische Therapieansätze • Indikationen und Kontraindikationen für eine Aphasietherapie • Therapiefähigkeit (Kriterien) • Therapieziele • allgemeine Prinzipien der Aphasietherapie • Hierarchie in der Aphasietherapie	Einbeziehen von Wissen aus dem Lerngebiet Phonetik/Linguistik Abstimmung mit dem Lerngebiet Logopädie
Sie besitzen Kenntnisse über Ätiologie, Symptomatik, Diagnostik und Therapie von Störungen der Schriftsprache.	- Störungen der Schriftsprache • Agraphie • Alexie	Eingehen auf die verschiedenen Formen
6.10.2 Zentral bedingte Störungen des Sprechens und der Stimme (ca. 15 Stunden)		
Die Schüler kennen Ätiologie und Charakteristika der verschiedenen Dysarthrieformen.	Dysarthrien - allgemeine Symptome - Ursachen	Erläuterung der Termini Dysarthrie, Dysarthrophonie, Dysarthropneumophonie;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie verfügen über Kenntnisse zur differentialdiagnostischen Abgrenzung.	- Einteilung der Dysarthrien nach der Lokalisation und Erscheinungsform - begleitende Störungen - Differentialdiagnose (Aphasie, Sprechapraxie, nervale Dysglossie)	Aufzeigen häufiger neurologischer Grunderkrankungen wie Morbus Parkinson, Multiple Sklerose; Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Neurologie und Psychiatrie; Sitz der Schädigung und Folgen darstellen, spezifische Symptomatik; Hinweisen auf Fazialisparesen und Schluckstörungen sowie Auswirkungen von Hör- und kognitiven Störungen; Gegenüberstellen der jeweiligen Symptomatik und Herausarbeiten der Unterschiede Untersuchungsbereiche ableiten; auf standardisiertes Verfahren nur hinweisen, da genaue Behandlung im Lerngebiet Logopädie;
Sie haben Kenntnisse über das diagnostische Vorgehen bei Verdacht auf eine Dysarthrie.	- Diagnostik (Untersuchungsgang, Frenchay-Test usw.)	Grundsätze der Dysarthrietherapie vorstellen;
Sie besitzen Kenntnisse über störungsspezifische Therapieansätze, interdisziplinäre Therapiemaßnahmen sowie alternative Kommunikationsmöglichkeiten.	- Therapie (kausale, symptomatische Therapie; Kommunikationshilfen)	Therapieziel und -bereiche ableiten; Therapieansätze aufzeigen
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Ableitung logopädischer Aufgabenstellungen .	- Prognose	(Vorgehen nach Darley/Aronson/Brown/Robertson/Thomson usw.); Eingehen auf die Kriterien für den Einsatz von Kommunikationshilfen; Vorstellen von Prognosekriterien (neurologischer Status und Vorgeschichte, Alter, Persönlichkeit, psychosoziale Situation usw.)
Sie kennen die Ursachen und Leitsymptome der Sprechapraxie.	kindliche Dysarthrie Sprechapraxien - Ursachen - Störungsebenen (Lautbildung, Prosodie, Sprechverhalten) - begleitende Störungen (bukkofaziale Apraxie usw.)	kindliche Dysarthrien unter 6.9.10 behandeln Ursachen und Formen der Apraxie/ Dyspraxie vorstellen sowie Möglichkeiten der Überprüfung; näher eingehen auf die Sprechapraxie, dabei Kenntnisse aus dem Lerngebiet Logopädie einbeziehen
Sie besitzen Kenntnisse über diagnostische Möglichkeiten und differentialdiagnostische Kriterien.	- Diagnostik - Differentialdiagnostik	diagnostische Möglichkeiten aufzeigen; Problematik der sicheren Abgrenzung zu aphasischen Störungen verdeutlichen; Charakteristika der Dysarthrie und Sprechapraxie gegenüberstellen
Sie haben einen Überblick über störungsspezifische Therapieansätze.	- Therapie Tendenzen der modernen Hirnforschung	Vorstellen ausgewählter spezifischer Behandlungsansätze (MIT, ganzheitliche Stimulierungsansätze, segmentorientierte sowie geeignete Ansätze aus der Dyslalietherapie usw.); vgl. Lerngebiet Logopädie

6.11 Audiologie und Pädaudiologie (70 Stunden)

Lernabschnitte

1 Akustische Grundlagen	ca. 8 Stunden
2 Hörprüfmethoden bei Kindern und Erwachsenen	ca. 33 Stunden
3 Apparative Versorgung Hörbehinderter	ca. 15 Stunden
4 Audiologische Grundlagen der Hör-Sprachübungsbehandlung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubheit	ca. 8 Stunden
5 Schwerhörigkeit und soziale Behinderung	ca. 6 Stunden

Zeitrichtwerte

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
-----------	-------------	---------------------------------

6.11.1 Akustische Grundlagen (ca. 8 Stunden)

Die Schüler verfügen über reaktivierte und vertiefte Kenntnisse.	physiologische Akustik - Weber-Fechnersches-Gesetz - Größen zur Erfassung des menschlichen Hörfeldes - Schalldruck - Schallintensität - Schallwellenwiderstand	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie sowie Elektro- und Hörgeräteakustik
Sie erfassen das Hörorgan als kompliziertes Schallempfangs- und -verarbeitungssystem.		
Sie kennen die psychoakustischen Grundlagen und audiologischen Begriffe.	- Dezibel, Phon, Frequenz, Lautstärke, Klangfarbe, Dynamik	
Sie verfügen über reaktiviertes und anwendungsbereites Wissen.	Pathophysiologie des Hörens - Störungen in den verschiedenen Funktionsbereichen (angeboren, erworben; peripher, zentral; Formen und Grade der Schwerhörigkeiten; Risikofaktoren für Hörstörungen)	Einbeziehung vorhandener Kenntnisse aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie und Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde; Darstellung aus audiologischer Sicht
Sie erkennen die Bedeutung des Gehörs für die Spracherkennung.	- akustische Struktur der Stimme und Sprache	Überleitung zur Diagnostik von Hörstörungen

6.11.2 Hörprüfmethoden bei Kindern und Erwachsenen (ca. 33 Stunden)

Die Schüler sind auf das audiologisch-pädaudiologische Praktikum vorbereitet.	Möglichkeiten der Hörfunktionsprüfung	Einführung in die audiologisch-pädaudiologische Diagnostik; Übersicht: audiometrische Verfahren
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit der frühzeitigen Erfassung von Risikofällen.	Screeningverfahren - Anforderungen an Screeningverfahren (Organisation, Sensitivität, Spezifität)	Vorstellen ausgewählter siebaudiometrischer Verfahren unter besonderer Berücksichtigung des pädaudiologischen Bereiches; Ausführungen zur diagnostischen Wertigkeit und klinischen Einsatzfähigkeit; Bezug zum Lerngebiet Pädiatrie und Neuropädiatrie (Vorsorgeuntersuchungen), Audiologie und Pädaudiologie (subjektive und objektive Messverfahren)
Sie kennen die Screeningverfahren und können sie bewerten.	- ausgewählte Screeningverfahren (z. B. BERA, OAE-Messung)	
Sie verfügen über Kenntnisse der klinisch üblichen Methoden der subjektiven Gehörprüfung, ihrer Zielstellungen und der Indikationen.	Messverfahren der subjektiven Audiometrie - Indikationen für eine audiologische/pädaudiologische Untersuchung	Vorstellen der audiometrischen Verfahren

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie erfassen die Beziehung zwischen Hörvermögen und Hörfeld und können die diagnostischen Werte erkennen.	- Tonschwellenaudiometrie (Hören über Luft- und Knochenleitung, Audiometer, Methodik der Hörschwellenbestimmung)	
Sie kennen die Darstellungsmöglichkeiten von Messergebnissen und erkennen die Gesetzmäßigkeiten bei Reintonverlusten.	• Dokumentation audiometrischer Ergebnisse (Absolut-, Relativdarstellung, Messgrenzen für Luft- und Knochenleitung, Fühlkurve) • Vertäubung (Verdeckung, Mithörschwelle, Überhören, Schattenkurve, Methodik)	Herausarbeiten der Beziehung zwischen Hörvermögen und Hörfeld messtechnische Darstellung der Vertäubung
Sie haben Kenntnis von Fehlermöglichkeiten bei der Gehörprüfung, deren Vermeidung sowie Notwendigkeit und Methodik der Vertäubung. Sie beherrschen die Fähigkeiten zur Beurteilung und Verwertung audiometrischer Messergebnisse.	• Fehlerquellen der Tonschwellenaudiometrie und ihre Vermeidung • Einführung in die Audiogrammauswertung (Auswertung pathologischer Hörkurven hinsichtlich des Hörverlustes und betroffener Frequenzbereiche)	Übungen zur Beurteilung der Audiogramme unter besonderer Berücksichtigung der klinischen Entstehungsformen, Ursachen, Arten und Auswirkungen der Hörstörungen an Fallbeispielen
Sie haben Einblick in überschwellige Messverfahren und beherrschen die Fähigkeit zur Beurteilung der Ergebnisse.	- überschwellige Audiometrie (Recruitmentphänomen, Adaptationsvorgänge, Hörermüdung, Messverfahren)	Darstellung ausgewählter Messverfahren, Hervorheben der besonderen Bedeutung der Dynamikbreite für die Hörgeräteanpassung, Schlussfolgerungen für ein Hörtraining
Sie erfassen die Vor- und Nachteile von Stimmgabelprüfungen und erkennen den Stellenwert von Hörweitenprüfungen.	- Stimmgabelprüfungen - Hörweitenprüfung (Technik, Fehlerquellen, typische Ergebnisse bei Schallleitungs- und Innenohrschäden, Stellenwert)	Einführung, Demonstration; Darstellung der Beziehung zwischen den Ergebnissen des Tonschwellenaudiogramms und der Hörweitenprüfung
Sie besitzen Kenntnisse über Notwendigkeit, Einsatzmöglichkeiten, technische Voraussetzungen und phonetische Grundlagen.	- Sprachaudiometrie • Einsatzmöglichkeiten • technische Voraussetzungen • Methodik (Sprachaudiometrie über Kopfhörer bzw. im freien Schallfeld, Testmaterial, Raumakustik)	Aufzeigen des Aufbaus verschiedener Sprachtests, ihrer Durchführung sowie subjektiver und objektiver Fehlermöglichkeiten
Sie erkennen die diagnostischen Grenzen.	• Sprachtests (Freiburger Sprachverständlichkeitstest, Mainzer Kindersprachtest, Göttinger Kindersprachverständnistest)	kritische Auseinandersetzung mit den Tests
Sie besitzen Kenntnisse über Aufzeichnungsarten.	• Sprachaudiogramm (grafische Darstellung der Messergebnisse, Sprachhörverlust, Diskriminationsverlust)	Übungen zum Lesen und Interpretieren von Messergebnissen; Darstellung von Kurvenverläufen bei Schwellenaudiogrammen in Beziehung zum Ergebnis der sprachaudiometrischen Untersuchung
Sie können Zusammenhänge erkennen und verstehen.	• Beziehung zwischen Reinton- und Sprachaudiogramm	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben einen Überblick über Möglichkeiten zur Erfassung zentraler Wahrnehmungs- und Verarbeitungsstörungen und erkennen die Bedeutung der Untersuchungsergebnisse für logopädische Therapien.	- Prüfung der zentralen Hörfunktionen und auditiven Wahrnehmung • auditive Perzeptionssprüfung bei Kindern (ohne und mit Sprache)	Erläuterung der wichtigsten zentralen Hörprüftests unter Berücksichtigung des Alters und Differenzierung; Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Phoniatrie und Logopädie
Sie verfügen über reaktivierte und vertiefte Kenntnisse. Sie haben Verständnis für Entwicklungsvorgänge und sind sensibilisiert für die Problematik.	- Kinderaudiometrie • Entwicklung und Reifung des Hörorgans (Zeittafel, stimulierende und hemmende Einflüsse) • Häufigkeit kindlicher Hörstörungen und Schwerhörigkeitsformen	Wiederholen und Vertiefen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie sowie Pädiatrie und Neuropädiatrie
Sie erfassen die vielseitigen Auswirkungen einer Hörstörung und können Schlussfolgerungen ziehen für die logopädische Praxis. Sie kennen adäquate sonderpädagogische Maßnahmen und erkennen die große Bedeutung einer Frühdiagnostik, der Erfassung von Risikokindern und kontinuierlichen pädaudiologischen Betreuung. Sie kennen die Methoden der Reaktions-, Verhaltens- und Spielaudiometrie sowie ergebnisbeeinflussende Faktoren.	- Ursachen frühkindlicher Hörstörungen und ihre möglichen Auswirkungen • pädaudiologische Anamnese • Anforderungen an die Kinderaudiometrie - Neugeborenenaudiometrie - Säuglingsaudiometrie - Kleinkindaudiometrie - Hördiagnostik im Vorschul- und Schulalter - Fehlerquellen in der Kinderaudiometrie	pädaudiologische Ätiologie; Erarbeitung von Auswirkungen einer Hörstörung im Kindesalter in Abhängigkeit von Art und Schweregrad, Ursachen für Progredienz sowie Verdachtskriterien; Einbeziehung von Kenntnissen aus den Lerngebieten Phoniatrie, Logopädie und Sonderpädagogik; Ableitung von notwendigen Inhalten der pädaudiologischen Anamnese; Vorstellen der diagnostischen Möglichkeiten für die verschiedenen Altersstufen
Sie verfügen über reaktiviertes und vertieftes anatomisch-physiologisches Wissen.	objektive Verfahren der Audiometrie - neurophysiologische Voraussetzungen der objektiven Audiometrie	Schaffung der Voraussetzungen zum Verständnis der objektiven Audiometrie
Sie kennen objektive audiometrische Verfahren, mögliche Indikationen und Aussagen sowie Normwerte und pathologische Abweichungen.	- Einteilung objektiv-audiometrischer Verfahren - klinisch übliche Verfahren • Impedanzmessungen • Reflexmessungen • elektrische Reaktionsaudiometrie (Einführung in die Physiologie evozierter Potentiale, Messung evozierter Potentiale, Auswertung der Messung, Einsatzmöglichkeiten)	Darstellung ausgewählter Methoden (Zielstellung, Durchführung, Ergebnisse); Erläuterung von Messtechnik, Reiztechnik und ausgewählten Messverfahren zur Potentialableitung; Dokumentation der Ergebnisse; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie besitzen eine Übersicht über den pädaudiologisch-diagnostischen Arbeitsbereich.	- otoakustische Emissionen - Umfang der klinisch-pädaudiologischen Diagnostik beim Kind	Zusammenfassung, Überleitung zur audiologisch-pädaudiologischen Therapie; Einbeziehung erworbener Kenntnisse aus den Lerngebieten Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und Phoniatrie; Beschränkung auf die apparative Therapie

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.11.3	Apparative Versorgung Hörbehinderter (ca. 15 Stunden)	
Die Schüler erkennen die soziale Bedeutung von Hörschäden für den Einzelnen und die Gesellschaft.	- Indikationen zur Versorgung von Kindern und Erwachsenen mit Hörhilfen	Erarbeiten der Zielgruppen, Gegenanzeigen, Vorteile, Möglichkeiten und Grenzen einer hörprothetischen Versorgung
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer Früherfassung Hörgeschädigter.	- störungsspezifische apparative Rehabilitation	
Sie kennen die Folgen einer verzögerten apparativen Rehabilitation und inadäquaten Betreuung.	- Zeitpunkt der apparativen Versorgung	Diskussion einfacher Fälle
Sie können die Notwendigkeit einer interdisziplinären Betreuung erfassen.	- individuelle Voraussetzungen und Umweltbedingungen	Aufzeigen positiver und negativer Faktoren bezüglich einer erfolgreichen Rehabilitation
Sie verfügen über Grundkenntnisse.	- mon- und binaurale Hörgeräteversorgung (Indikation, Vor- und Nachteile)	
	- Hörgeräteauswahl	Vorstellung und Demonstration der Handhabung verschiedener Hörgerätetypen, Abstimmung mit den Lerngebieten Elektro- und Hörgeräteakustik sowie Phoniatrie; Herausarbeiten von Besonderheiten der Hörgeräteanpassung beim Kind
	- Anpassung (ambulant, stationär, Eltern-Kind-Therapie)	
	- Einstellung individueller Hörhilfen	
Sie besitzen Kenntnisse über die Bedienung individueller Hörhilfen und besitzen Fertigkeiten im Bedienen elektroakustischer Hörhilfen.	- Bedienung individueller Hörhilfen	Übungen zur Gerätebedienung
Sie haben einen Überblick über weitere Hilfen.	- weitere technische Hilfen (z. B. Lichtsysteme, Telefonverstärker, drahtlose Kommunikationshilfen, Medienangebote)	Vermittlung von Grundwissen
Sie beherrschen die Fähigkeiten für den adäquaten Umgang mit hör-gestörten Patienten und Angehörigen sowie zur Anleitung im Gebrauch und Umgang mit Hörhilfen und anderen Hilfsmitteln.	Patienten-, Eltern- und Angehörigenberatung	Erarbeitung der wichtigsten Fragestellungen; Verhaltenstraining in Partner- oder Kleingruppen-übungen; Vorbereitung auf das audiologisch-pädaudiologische Praktikum
Sie besitzen Grundkenntnisse über die cochleäre Implantation.	- Cochlea Implantate (CI) (Prinzip, Typen, Funktion; Indikationen, Kontraindikationen, Komplikationsmöglichkeiten)	Wissensvermittlung in Abstimmung mit dem Lerngebiet Elektro- und Hörgeräteakustik;
Sie kennen die theoretische Basis für die Therapie von CI-Patienten.	- Vor- und Nachteile der CI-Versorgung, Prognose	Darstellung der organisatorischen, diagnostischen und therapeutischen Aufgaben im interdisziplinären therapeutischen Team;
Sie sind fähig zur Ableitung logopädischer Aufgabenstellungen.	- prä- und postoperative Maßnahmen	Abstimmung mit den Lerngebieten Phoniatrie und Logopädie

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.11.4	Audiologische Grundlagen der Hör-Sprachübungsbehandlung bei hochgradiger Schwerhörigkeit und Taubheit (ca. 8 Stunden)	
Die Schüler besitzen ein Überblickswissen.	- behinderungsspezifische Mittel und Wege im Rahmen der Rehabilitation	Erarbeiten dem Mediziner nachgeordneter Maßnahmen; Aufzeigen sonderpädagogischer Arbeitsfelder, besonders Ableitung logopädischer Aufgabenstellungen; Arbeit mit Fallbeispielen; Hör-Sprachbehinderung
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Beurteilung akustischer Wahrnehmungs- und Differenzierungsleistungen ohne bzw. mit elektroakustischer Verstärkung anhand audiometrischer Befunde.	- primäre und sekundäre Faktoren, die das Aufgabenfeld des Logopäden bestimmen können	
Sie verfügen über Kenntnisse medizinisch-audiologischer Standpunkte.	- medizinisch-audiologische Gesichtspunkte für die Indikation, Planung und Durchführung logopädischer Behandlungen bei Hörbehinderungen	Schwerpunkt: Hör-Sprachbehandlung bei Kindern
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Ableitung und Begründung der unterschiedlichen Vorgehensweisen und haben Einblick in Möglichkeiten der Sprachvermittlung.	- Hör- und Sprachtraining - allgemeine Zielstellungen bei prä- und postlingualer Schwerhörig- und Gehörlosigkeit (Sprachaufbau, Spracherhaltung, Artikulationsverbesserung, Stimmführung)	Erarbeiten der Unterschiede unter Berücksichtigung des Schädigungszeitpunktes (prä-, peri-, postlingual) und Erscheinungsbildes der Hörbehinderung; Darstellung aus audiologisch-pädaudiologischer Sicht; Abstimmung mit den Lerngebieten Phoniatrie, Logopädie, Sonderpädagogik
Sie beherrschen die Grundkenntnisse.	- Hörerziehung und Hörtraining	
Sie besitzen Einblick in die Wirkungsweise unterschiedlicher Hörhilfen und sind fähig, diese richtig zu verwenden.	- Hörhilfen zur Hör-Sprachübungsbehandlung (individuelle, nicht individuelle)	Vorstellung ausgewählter Geräte; Einbeziehung von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Elektro- und Hörgeräteakustik
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Erhebung der logopädisch-pädaudiologischen Anamnese.	- logopädisch-pädaudiologische Anamnese	Anwendung von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Logopädie; Erarbeitung störungsspezifischer Anamneseinhalte
Sie kennen die Zielstellung, Prinzipien und das methodische Vorgehen.	- logopädische Nachbehandlung bei Cochlear-Implant-Versorgung (Inhalte und Einflussfaktoren für die Effektivität einer Hörerziehung beim Kind, Zielstellungen der Hör-Sprachtherapie bei Erwachsenen)	Darstellung der unterschiedlichen Situation prä- und postlingual Gehörloser
Sie haben Einblick in mögliche Therapieergebnisse.	- Erfolge nach Cochlear-Implant-Versorgung	Arbeit mit Fallbeispielen; Patientenvorstellungen
Sie besitzen einen Überblick über die wichtigsten Ziele und Aufgaben.	- Cochlea-Rehabilitationszentren - CI-Selbsthilfegruppen	Informationen; evtl. Besuch eines Cochlea-Rehabilitationszentrums; Einbeziehung Betroffener

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.11.5 Schwerhörigkeit und soziale Behinderung (ca. 6 Stunden)		
Die Schüler verfügen über ein Übersichtswissen.	Aufgaben und Möglichkeiten der Fürsorge für hörbehinderte Kinder und Erwachsene in sozialer, rechtlicher und rehabilitativer Hinsicht	Abstimmung mit den Lerngebieten Soziologie, Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde sowie Sonderpädagogik
Sie besitzen reaktivierte und vertiefte Kenntnisse.	- psychische Situation hörbehinderter Kinder und Erwachsener	Darstellung und Begründung möglicher Einschränkungen der seelischen Entwicklung, in Abstimmung mit dem Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie
Sie haben Kenntnisse zum Konzipieren von Beratungsgesprächen und beherrschen die Fähigkeit, diese zu führen.	- Beratung von Eltern hörsprachbehinderter Kinder (Auswirkungen der Hörstörung kind- und umweltbezogen, adäquates Elternverhalten, sonderpädagogische Fördermöglichkeiten)	Erarbeitung der Gesprächsinhalte; Einbeziehen von Informations-, Aufklärungsmaterial usw.; Kleingruppenarbeit; Partnerübungen
6.12 Elektro- und Hörgeräteakustik (30 Stunden)		
Lernabschnitte		Zeitrichtwerte
1 Grundlagen der Elektroakustik		ca. 15 Stunden
2 Hörgerätetechnik		ca. 15 Stunden
6.12.1 Grundlagen der Elektroakustik (ca. 15 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Grundkenntnisse der Akustik.	Grundgrößen und Grundbegriffe der Schwingungslehre, Akustik und Elektroakustik (z. B. Schall, Schallwellen, Welleneigenschaften)	Abstimmung mit dem Lerngebiet Audiologie und Pädaudiologie
Sie verfügen über Kenntnisse der physiologischen Akustik.	Kenngrößen des normalen Gehörs - Reiz, Empfindung, Wahrnehmung Hörfeld - räumliches Hören objektive Hörprüfverfahren und subjektive Hörprüfmethoden	Wiederholen und Vertiefen entsprechender Kenntnisse aus dem Lerngebiet Audiologie und Pädaudiologie in Abstimmung mit dem Lerngebiet Audiologie und Pädaudiologie
Sie kennen die gerätetechnischen Voraussetzungen und gebräuchlichsten Verfahren zur Bild- und Schallaufzeichnung sowie zur Sprach- und Stimmschallanalyse.	elektroakustische Methoden - Schallspeicherung und -wiedergabe • Beschallungs- und Aufnahmetechnik (Einstellmöglichkeiten, Leistung, Empfindlichkeit, Bauelemente) • Aufzeichnungsmedien (Soundkarten, CD, Band, DAT-Band) • Aufnahmebedingungen (Störschall, Raumakustik)	Vorstellen der in der Phoniatrie und Logopädie üblichen Aufzeichnungs- und Wiedergabegeräte für Bild- und Schallaufzeichnung sowie von Schallmessgeräten; Demonstration der Geräte und ihrer Handhabung
Sie haben Kenntnis von Einflussfaktoren auf das Ergebnis.		
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Anwendung gängiger Messgeräte und Beurteilung der Messergebnisse		Bedeutung der Aufnahmebedingungen herausarbeiten

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben einen Überblick über moderne Messverfahren.	- akustische Aufnahmetechnik und deren Handhabung für die Stimmdiagnostik • Messung der Stimmstärke • Messung der Tonhöhe • Stimmumfangsprofile • Klanganalysen (Regularitäts-, Spektralanalyse, Sonographie) • Elektrolottographie	Demonstration; Arbeit mit Fallbeispielen; Übungen
Sie kennen die technischen Möglichkeiten zur Unterstützung der therapeutischen Tätigkeit und besitzen die Fähigkeit zur praktischen Handhabung.	- Deutung und Aussagen der Ergebnisse - Aufbau und Wirkungsweise von Stimm-, und Sprechtrainings- sowie Reizstromgeräten	
6.12.2 Hörgerätetechnik (ca. 15 Stunden)		
Die Schüler besitzen Kenntnisse über die Hörgeräteversorgung.	Hörgeräteversorgung - Verordnung von und Versorgung mit Hörgeräten - Aufbau und Wirkungsweise eines Hörgerätes - Hörgerätetypen (Vor- und Nachteile) - Indikationen und Kontraindikationen für eine Hörgeräteversorgung Hörgerätemesstechnik - Hörgeräteanpassung (PC) - Überprüfung - Einflussfaktoren auf das Hörergebnis	Bezug zum Lerngebiet Audiologie und Pädaudiologie Demonstration verschiedener Hörgerätetypen und ihrer Handhabung
Sie haben Kenntnisse über Sonderhörhilfen. Sie sind fähig zum Ableiten der logopädischen Aufgaben bei der Rehabilitation von Hörbehinderten.	Sonderhörhilfen - Cochlea Implantat • Aufbau und Funktionsprinzip • Vor- und Nachteile • Anpassung des Sprachprozessors • Nachsorge • Indikation/Kontraindikationen	Einsatz von Anschauungsmaterial und Informationsbroschüren; Demonstration eines CI-Systems; Rehabilitationsteam, CI-Zentren und ihre Aufgaben vorstellen; möglichst Besuch eines CI-Zentrums

6.13 Logopädie (560 Stunden)

Lernabschnitte

Zeitrichtwerte

Spezielle logopädische Anamnese, Befunderhebung, Therapie und Beratung bei:

1	Stimmstörungen organischer und funktioneller Ursachen	ca. 100 Stunden
2	Zustand nach Kehlkopfoperationen	ca. 20 Stunden
3	Störungen der Sprachentwicklung, auch bei psychischer und psycho-sozialer Genese	ca. 125 Stunden
4	Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen durch Hörbehinderung	ca. 15 Stunden
5	Peripher bedingten Sprechstörungen	ca. 20 Stunden
6	Erworbenen, zentral bedingten Sprach- und Sprechstörungen	ca. 120 Stunden
7	Frühkindlichen zerebralen Bewegungsstörungen	ca. 15 Stunden
8	Funktionellen und organischen Störungen der Nasalität	ca. 15 Stunden
9	Störungen des Redeflusses wie Stottern und Poltern	ca. 90 Stunden
10	Entwicklungsdyslexien und Entwicklungsdysgraphien	ca. 15 Stunden
11	Dysphagien	ca. 25 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
-----------	-------------	---------------------------------

6.13.1 Stimmstörungen organischer und funktioneller Ursachen (ca. 100 Stunden)

Die Schüler besitzen ein gefestigtes und erweitertes Wissen über den Aufbau der an der Stimmgebung beteiligten Organsysteme und ihrer physiologischen Funktionsabläufe. Sie sind fähig, problembezogene Kenntnisse selbstständig zu reaktivieren.	anatomisch-physiologische Grundlagen der Stimmgebung - Funktionsebene Atmung - Funktionsebene Stimmgebung - Funktionsebene Lautbildung - phonatorisches Kontrollsystem	Reaktivierung und Erweiterung der Kenntnisse aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie, Phoniatrie, Psychologie und klinische Psychologie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Phonetik/ Linguistik, Stimmbildung und Sprecherziehung
Sie erkennen den Zusammenhang von Stimme und Gesamtpersönlichkeit des Menschen.	Zusammenwirken von Umwelt, Psyche, Intention, Tonus/Haltung, Atmung, Phonation und Artikulation	situationsbezogene Fremd- und Selbstbeobachtung, Vergleiche
Sie besitzen ein gefestigtes und erweitertes Wissen über die normale Stimmentwicklung und ihre altersspezifischen Veränderungen.	Stimme in den verschiedenen Lebensaltern	auf die Stimme bezogene geschlechts- und altersspezifische Beobachtungsaufgaben in Alltagssituationen; Einbeziehung eigener Erfahrungen
Sie haben Kenntnisse über disponierende, ursächliche, auslösende und die Stimmstörung aufrechterhaltende Faktoren.	Störungsquellen - endogene Faktoren - exogene Faktoren	Beachtung des multifaktoriellen Geschehens bei der Entstehung von Stimmstörungen
Sie besitzen die Fähigkeit, die verschiedenen Störungsbilder aus logopädischer Sicht zu differenzieren und zu beschreiben.	Stimmstörungen - Ätiologie - Pathogenese - Symptomatik - Charakteristika der normalen und gestörten Stimme	Gegenüberstellung von Physiologischem und krankhaft Verändertem in Struktur und Funktion; Erarbeitung der einzelnen Störungsbilder und Zuordnung zu den verschiedenen Störungsklassen
Sie sind zur ganzheitlichen Betrachtungsweise fähig und können die vielseitigen, sich wechselseitig beeinflussenden Beziehungen innerhalb der Ganzheitlichkeit erfassen (bio-psycho-soziales Krankheitsmodell).	Diagnostik - Inhalte der speziellen logopädischen Anamnese • Vorstellungsgrund • soziale Situation • phoniatische und weitere Befunde	Erhebung der Vorgeschichte nach logopädischen Kriterien (allgemein: Rahmenbedingungen, Inhalte, Formen); Strukturierung eines störungsspezifischen Anamneseschemas;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie verstehen die Zusammenhänge. Sie verfügen über Kenntnisse zur richtigen Deutung und Einordnung von Patientenangaben.	• erfolgte Behandlungen • aktuelle Stimmbeschwerden (Beginn, Dauer, Verlauf, subjektive Beschwerden, Situations-, Personen-abhängigkeit, Leidensdruck usw.)	Vorstellen ausgewählter Anamnesebögen usw.; kritische Auseinandersetzung mit den anamnestischen Angaben bezüglich der Zielsetzung; Konzentration auf verwertbare Aussagen
Sie sind zur korrekten Auswertung der anamnestischen Daten fähig.	• Stimmentwicklung (Stimmbildung, berufliche/außerberufliche Stimmbelastung, Rahmenbedingungen, beruflicher Werdegang) • psychische Belastungen • Medikamente/Reizstoffe • Anspruchsniveau • Erwartungen • Familienanamnese (Stimm-, Sprech-, Sprach-, Hörstörungen, usw.)	Quantität und Qualität als Kriterien
Sie besitzen die Fähigkeit zur Auswahl und Darstellung der Kriterien für die logopädische Befunderhebung sowie zur adäquaten Dokumentation der Untersuchungsergebnisse. Sie erfassen den Prozesscharakter der Diagnostik. Sie sind zur intensiven kritischen Fremdbeobachtung und korrekten Einschätzung stimmlicher Leistungen fähig.	- logopädische Befunderhebung • Erhebungsmethoden • Beurteilung und Dokumentation visuell und auditiv wahrnehmbarer Leistungen (z. B. Tonus/Haltung, partielle Fehlspannungen, Atmung, Stimm- und -absätze, Stimmklang, -dynamik, -umfang, Sprechstimmlage, Belastbarkeit, Modulation, Schwelltöne usw.) • objektive Untersuchungsmöglichkeiten (z. B. Grundtonanalyse, Stimmfeldmessung, Klanganalyse)	kritische Auswahl der notwendigen Kriterien zur Einschätzung der stimmlichen Leistungen einschließlich der Leistungen, der bei der Phonation korrespondierenden Organsysteme in Verbindung mit ständigen Rückkopplungseffekten; Demonstration, Beobachtungsaufträge, problematisierender Unterricht, Gruppenarbeit
Sie beherrschen die Fähigkeit zur - Diskussion sinnvoller, ergänzender, effektiver objektiver Untersuchungsverfahren; - Arbeit mit bereits bekannten Fakten und Tatsachen sowie eigenen Erfahrungen; - sachlichen, taktvollen und überzeugenden Argumentation als wesentliche Voraussetzung für erfolgreiches therapeutisches Wirken.	- Kriterien zur Prognose und Einschätzung der Behandlungsbedürftigkeit	Anwendung von Kenntnissen aus den Lerngebieten Phoniatrie und Elektro- und Hörgeräteakustik Ableitung der Prognose und der Behandlungsbedürftigkeit aus der Vorgeschichte und dem individuellen logopädischen Befund unter Zuhilfenahme spezifischer Kriterien und weiterer Untersuchungsergebnisse; Beachtung des Kompetenzbereiches; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie kennen die Anforderungen an einen Stimmtherapeuten und die notwendigen Voraussetzungen eines Stimmtherapeuten. Sie besitzen gefestigte und erweiterte Kenntnisse über die Führung des therapeutischen Gesprächs. Sie sind zur Patientenaufklärung und zum Führen von Problemgesprächen fähig.	Stimmtherapie - Therapiebereiche - theoretische Grundlagen, Therapieziele und Methoden für: • den Bereich Persönlichkeit • die auditive und die Körperwahrnehmung • den Spannungsausgleich • die Erarbeitung einer physiologischen Atmung	Einführung Überblick über die Bereiche der logopädischen Arbeit in der Stimmtherapie, einschließlich therapieexterner Einflussfaktoren (familiäre und soziale Situation usw.); Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Phoniatrie, Phonetik, Stimmbildung, Sprech-erziehung sowie Psychologie und klinische Psychologie;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen Möglichkeiten zur Patientenmotivation, zur Standortbestimmung und Formulierung realistischer Therapieziele. Sie besitzen erweiterte und gefestigte Kenntnisse über die Methoden zur Wiederherstellung der physiologischen Stimmfunktion und Möglichkeiten der Stimmhygiene.	• die Erarbeitung einer ökonomischen Stimmgebung und Steigerung der stimmlichen Leistungsfähigkeit • die Erarbeitung einer lockeren, elastischen und regelrechten Artikulation	Ableitung und Begründung möglicher Therapieziele; Berücksichtigung von Besonderheiten bei der Behandlung kindlicher Dysphonien (z. B. Motivierbarkeit, Konzentrationsfähigkeit, altersgerechte Therapiegestaltung, Elternberatung und -anleitung)
Sie besitzen die Fähigkeit, persönliche und fachliche Grenzen zu erkennen. Sie sind bereit zur interdisziplinären Zusammenarbeit.		stimmliches und sprachliches Vorbild des Therapeuten; Stimm- und Sprechhygiene (allgemeine Hinweise und Stimmhygiene in den verschiedenen Lebensaltern)
Sie haben Kenntnisse über mögliche Hilfsmittel und ihren Einsatz in der Stimmtherapie.	- manuelle, instrumentelle und apparative Hilfen in der Stimmtherapie - Therapieplanerarbeitung • allgemeine störungsspezifische Planung (Behandlungsziel, Therapiebereiche,	Berücksichtigung von Kenntnissen aus den Lerngebieten Phoniatrie, Elektro- und Hörgeräteakustik; Demonstration;
Sie beherrschen Fähigkeiten und Fertigkeiten zur individuellen, altersadäquaten, störungsspezifischen Therapieplanung.	- Schwerpunkte, Methoden, zeitliche Gliederung der Therapie) • Erarbeitung eines individuellen Therapieplanes	Beobachtungsaufträge; Einhaltung rechtlicher Bestimmungen (ASA); Einsatz von Videos, Hör- und Fallbeispielen und Arbeitsblättern; Übungen zur Therapieplanung

6.13.2 Zustand nach Kehlkopfoperationen (ca. 20 Stunden)

Die Schüler verfügen über aktivierte, erweiterte und gefestigte Kenntnisse.	postoperativ veränderte anatomische Situation und Funktionsbeeinträchtigung nach Laryngektomie (Atemweg, Phonation, Riechen, Niesen usw.)	Einführung in die Thematik; Berücksichtigen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und Phoniatrie;
Sie erfassen die veränderten anatomischen Voraussetzungen und physiologischen Bedingungen nach einer Kehlkopftotalexstirpation bzw. Laryngektomie mit stimmverbessernder Operation.		Was ist nach der Operation anders? (erhaltene/veränderte Funktionen); Abgrenzung der aktuellen physiologischen Bedingungen nach Laryngektomie und Laryngektomie mit stimmverbessernder Operation; Einsatz von Anschauungsmaterial
Sie kennen	postoperative Komplikationen (Wundheilung, Fistelbildung) und Nebenerscheinungen (Schwellungen, Sensibilitätsstörungen, Geschmacks-, Geruchsbeeinträchtigungen, Bewegungseinschränkungen nach Neck dissection)	siehe Lerngebiet Phoniatrie: Rehabilitation nach Kehlkopfoperationen; Ableitung des therapeutischen Vorgehens unter Berücksichtigung der Einschränkungen
- die postoperativen Komplikationen und Nebenerscheinungen sowie ihre möglichen Auswirkungen auf die logopädische Therapie;		
- die Konsequenzen einer Strahlen- und Chemotherapie, die bei der logopädischen Behandlung zu berücksichtigen sind.	- Wirkung von Strahlen- und Chemotherapie sowie deren Begleit- und Folgeerscheinungen	Beschreibung der Folgeerscheinungen einer Chemo- und Strahlentherapie, Aufzeigen des therapeutischen Vorgehens unter diesen Bedingungen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie können psychische Probleme erkennen, die im Zusammenhang mit dem Organverlust und der Einbuße der Sprech- und Kommunikationsfähigkeit stehen.	- psychische Traumatisierung durch Kehlkopfentfernung (Rezidivängste, Disposition zu Depressionen, Minderwertigkeitsgefühl, Angst vor Isolation, Auswirkungen auf die sozio-ökonomische Situation usw.)	Diskussion möglicher Probleme und Haltungen sowie Ableitung geeigneter Formen der Gesprächsführung unter Einbeziehung von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie (Gesprächsführung); Arbeit mit Fallbeispielen; Rollenspiele
Sie beherrschen die Fähigkeiten zur ganzheitlichen Betrachtungsweise. Sie besitzen Kenntnisse zur Strukturierung eines störungsspezifischen Anamneseschemas. Sie sind zur Formulierung situationsadäquater Fragestellungen und sicheren Gesprächsführung fähig. Sie erfassen kritische Situationen und besitzen die Fähigkeit zur angemessenen Reaktion.	logopädische Anamnese - Eigenanamnese spezifische Krankheitsgeschichte unter Einbeziehung der sozio-ökonomischen und psychosozialen Situation - Familienanamnese (Inhalte, Bedeutung)	Wiederholen von Kenntnissen zur Erhebung der Vorgeschichte nach logopädischen Kriterien und Herausarbeiten der Besonderheiten nach Kehlkopfoperationen; Einfluss der psychischen Führung des Patienten auf die Datengewinnung; Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie; Vorstellung und Diskussion möglicher Anamneseschemata; Rollenspiele
Sie verfügen über Kenntnisse zum Umfang der logopädischen Untersuchung bei Patienten nach Laryngektomie.	logopädischer Befund bei Zustand nach Laryngektomie - Beurteilen von: - Tonus - Atemtypus - Mundmotorik - Mimik, Gestik - Blickverhalten - Art der Kommunikation (Schriftsprache, Pseudoflüstern, Ösophagusersatzstimme, Stimmprothese, elektronische Sprechhilfe), Artikulation, Verständlichkeit, Prosodie, Sprechtempo, postoperative Kompensationsstrategien usw.	Darstellung geeigneter Verfahren zur Erhebung des umfassenden logopädischen Befundes; Übungen zur Einschätzung der Stimme mit Hilfe von Bewertungskriterien; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie besitzen die Fähigkeit zur Ableitung der Prognose aus den anamnestischen Daten und den Untersuchungsergebnissen.	Prognose	Informationen zur körperlichen Belastbarkeit, psychischen Situation und Motivation für die logopädische Therapie als Basis für Aussagen zur Prognose der stimmlichen Rehabilitation
Sie besitzen Kenntnisse über die Zielstellung und verschiedene Möglichkeiten der Stimmrehabilitation nach Laryngektomie.	Stimmrehabilitation nach Laryngektomie (konservative und apparative Methoden) - Zielstellung	Methodenüberblick
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit im Rehabilitationsteam und erkennen die besondere Stellung des Logopäden.	- Rehabilitationswege - interdisziplinäres Behandlungssystem - phasenspezifische Inhalte der Therapie	Begleitung des Patienten in allen Phasen der Rehabilitation
Sie sind fähig zur Ableitung phasenspezifischer Therapieschwerpunkte.	(medizinische, psychische Betreuung, Angehörigenberatung, prä- und postoperative Rehabilitation, Stimmanbildung)	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen weiterentwickelte Fähigkeiten zur Gesprächsführung.	- konservative Methode Therapiebereiche: Beratung und Gespräch, Tonus, Wahrnehmung, Atmung, Ösophagusersatzstimme, Nachsorge	
Sie erkennen den Stellenwert der Aufklärung und Einbeziehung von Angehörigen.	• Beratung und Gespräch (Inhalte präoperativ: Anamneseerhebung prä- und postoperative anatomisch-physiologische Gegebenheiten, logopädische Therapie, Grundprinzip der neuen Stimmfunktion, Angehörigengespräch usw.; Inhalte postoperativ: logopädische Befunderhebung, medizinisch-technische Hilfsmittel, postoperative Nebenerscheinungen und Funktionsminderungen, Einbeziehung der Angehörigen, Bundesverband der Kehlkopfloren e. V., usw.)	verschiedene Ratgeber für Kehlkopfloren vorstellen Übungen zur Gesprächsführung, Anwendung von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie
Sie verfügen über weiterentwickelte Fähigkeiten zur Gesprächsführung.		Struktur, Ziele und Aufgaben des Bundesverbandes für Kehlkopfloren e. V.
Sie haben einen Einblick in die Arbeit des Bundesverbandes der Kehlkopfloren e. V.	• Basistherapie (Schaffung funktioneller Voraussetzungen für die Stimmabahnung) Tonusregulierung, Wahrnehmungssensibilisierung (akustisch, visuell, kinästhetisch), Atemtherapie, Bewegungstherapie	Anwendung von Kenntnissen aus dem Lernabschnitt 6.13.1 und aus dem Lerngebiet Stimmabildung
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Erörterung des gezielten Einsatzes von Übungen zur aktiven Lockerung, Methoden zur Körperwahrnehmung und Entspannung sowie Maßnahmen zum Abbau von Atemfunktionsstörungen.		
Sie besitzen Kenntnisse über die Voraussetzungen und möglichen Wege der Ersatzstimmabildung, das methodische Vorgehen sowie Vor- und Nachteile der verschiedenen Methoden.	• spezielle Stimmtherapie (Anbahnung der Ösophagusersatzstimme) günstige/ungünstige Voraussetzungen, Luftaufnahme zum Sprechen, synchrone und asynchrone Sprechatmung, Methoden (Prinzip, Vor-, Nachteile), therapeutisches Vorgehen zum Erlernen der Ösophagusersatzstimme (Anbahnungs-/Experimentierphase, Stabilisierungsphase, Nachsorge)	Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Phoniatrie Vorstellung und Demonstration der Inhalations-, Injektions-, Verschlusslaut- und Schluckmethode; Übungen zur Produktion evtl. einzelner Ösophagustöne zur besseren Stimulation der Patienten;
Sie besitzen die Fähigkeit zur Anleitung laryngektomierter Patienten beim Erlernen der Ersatzstimme.	• Einflussfaktoren auf die Qualität der Ösophagusersatzstimme (lokale, allgemeine)	Einsatz von Hörbeispielen
Sie kennen die Kriterien für das flüssige Sprechen mit der Ösophagusersatzstimme und besitzen die Fähigkeit, auftretende Fehler zu erkennen, einzuschätzen und zu bewerten.	• Hilfen zur Reduzierung von Problemen (Tonus, Ösophagusluftaufnahme und -abgabe, Atemrhythmus, -geräusche, Ruktusverlängerung und -beschleunigung, Artikulation, Lautstärke, Modulation) • Therapiekonzepte zur systematischen Erarbeitung der Ösophagusersatzstimme	problemorientiertes Handbuch für die therapeutische Arbeit mit Kehlkopfloren, Praxis LE empfehlen bzw. einsetzen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über apparative Stimmrehabilitationsmöglichkeiten sowie über den Aufbau, die Funktionsweise und Handhabung elektronischer Sprechhilfen.	- apparative Methoden elektronische Sprechhilfen (Arbeitsweise des Elektrolarynx, Indikationen für den Einsatz des Elektrolarynx, Vor- und Nachteile einer elektronischen Sprechhilfe, mögliches Vorgehen beim Erlernen der Ersatzstimme mittels elektronischer Sprechhilfe: Handhabung, Positionierung des Gerätes, Koordinierung von Atmung und Gerätebetrieb, Artikulationsübungen, Tonusregulierung, spezielle Übungen: Hör- und Sprechübungen)	Demonstration elektronischer Sprechhilfen
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Anleitung bei der Erarbeitung einer flüssigen Sprechweise.		Übungen zur sicheren Handhabung und Planung spezieller Übungsschritte
Sie verfügen über gefestigte Kenntnisse.	- operative Verfahren zur Stimmrehabilitation nach Laryngektomie - OP mit körpereigenem Material - Stimmprothesen (Funktionsprinzip, Primär- und Sekundärversorgung, Prothesensysteme, Indikationen und Kontraindikationen zur prothetischen Stimmrehabilitation)	Wissen aus dem Lerngebiet Phoniatrie reaktivieren Demonstration von Stimmprothesen und verschiedenen Tracheostomaklappenventilen
Sie kennen die grundsätzlichen Unterschiede in der logopädischen Behandlung laryngektomierter Patienten mit und ohne stimmverbessernden Operationen.	logopädische Therapie (Beratung/Gespräch, Tracheostomaverschluss, Regulierung des Anblasedrucks, Koordination von Atem und Stimme, Artikulation, Modulation, Dynamik usw.)	Entscheidungsfreiheit des Patienten bezüglich des endgültigen Stimmersatzmechanismus hervorheben
Sie erkennen die Notwendigkeit einer guten Tracheostomapflege und Kenntnis der Folgen vernachlässigter Hygiene und besitzen einen Überblick über Hilfsmittel für Laryngektomierte zur teilweisen Kompensation von Funktionseinschränkungen im Bereich Kommunikation/Sprechen, Atmung, Hygiene.	- Tracheostomapflege - Hilfsmittel für laryngektomierte Patienten (Hygienezubehör, Erstausrüstungs-Set, Sprachverstärker und Zubehör, apparative Sprechhilfen, Larynxschnorchel usw.)	Demonstration der Hilfsmittel und ihrer Handhabung; Reha-Kataloge
Sie verfügen über Kenntnisse und Fertigkeiten bezüglich Erster-Hilfe-Maßnahmen bei Halsatmern.	- Notfallmaßnahmen für Kehlkopflose Symptome und Hilfemaßnahmen bei Atemnot, Atemstillstand, Herz-Kreislauf-Stillstand und Schock	Aktivierung und Erweiterung von Kenntnissen, Fähigkeiten und Fertigkeiten aus der Erste-Hilfe-Ausbildung; Einsatz von Anschauungsmaterial; Einbeziehung und Erweiterung von Wissen aus dem Lerngebiet Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde
Sie kennen die Möglichkeiten der beruflichen Rehabilitation und Voraussetzungen für die Gewährung von Unterstützung nach dem BSHG, SchwbG und Reha-Angleichungsgesetz.	- Berufs- und Erwerbsunfähigkeit nach Laryngektomie - Sozialleistungen nach Laryngektomie (Bundessozialhilfegesetz, Schwerbehinderten- und Rehabilitations-Angleichungsgesetz)	auf postoperative Zustände nach weiteren Kehlkopfoperationen wird unter 6.13.1 eingegangen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.13.3	Störungen der Sprachentwicklung, auch bei psychischer und psychosozialer Genese (ca. 125 Stunden)	
Die Schüler besitzen erweiterte und vertiefte Kenntnisse über die physiologische kindliche Entwicklung.	physiologische kindliche Entwicklung - Entwicklungsbereiche (motorische Entwicklung, Wahrnehmungsentwicklung, kognitive und sozial-emotionale Entwicklung)	Reaktivieren von Wissen aus den Lerngebieten Pädiatrie und Neuropädiatrie sowie Psychologie und klinische Psychologie; Vorstellen ausgewählter Entwicklungsskalen
Sie verfügen über Grundlagen.	Entwicklung der Sprache und des Sprechens - biologische Grundlagen (Lateralität, Dominanz, Phylogenese-Ontogenese-Sprachentwicklung) - linguistische Grundlagen (strukturelle Ebenen)	Abstimmung mit den Lerngebieten Phonetik/Linguistik, Pädiatrie und Neuropädiatrie, Phoniatrie, Psychologie und klinische Psychologie
Sie haben einen Überblick über die verschiedenen Modelle der Sprachentwicklung.	- Spracherwerbstheorien (Nativismus, Interaktionismus, Kognitivismus, Behaviorismus)	Diskutieren der verschiedenen Ansätze
Sie kennen die Voraussetzungen und Bedingungen für eine normale Sprachentwicklung und beherrschen die Fähigkeit zur Einordnung der sprachlichen Entwicklung in den allgemeinen kindlichen Entwicklungsverlauf.	- Voraussetzungen für eine physiologische Sprachentwicklung	Wiederholung der nonverbalen Entwicklungsbereiche; Hervorheben der Bedeutung der sensomotorischen Integration; Sprachbaum nach Wendlandt; physiologische kindliche Entwicklung (Stufenmodell nach Piaget); Zeittafel der Sprachentwicklung; Theorien des Lauterwerbs; Spracherwerbsphasen nach Clahsen; Erwerb der Wortkategorien usw.; Berichte von Schülern über den Verlauf der eigenen Sprachentwicklung; Erarbeitung eines Informationsblattes für Eltern; Vermittlung von Kenntnissen zur Früherkennung eines abweichenden Sprachentwicklungsverlaufs (z. B. ELFRA 1/2)
Sie besitzen Kenntnisse über die Charakteristik der prälingualen Periode sowie über die Entwicklung rezeptiver und expressiver Fähigkeiten auf den verschiedenen Sprachebenen.	- Verlauf der physiologischen Sprach- und Sprechentwicklung: präverbale Phase, verbale Phase (Entwicklung von Sprachverständnis und Sprachproduktion)	
Sie haben eine Übersicht über prophylaktische Maßnahmen.	- Pflege der kindlichen Sprache während ihrer Entwicklung	
Sie verstehen abweichende Entwicklungsverläufe und sind fähig zum Erkennen der ursächlichen und begleitenden Störungen oder Faktoren sowie zur Beurteilung ihres Einflusses.	Störungen der Sprach- und Sprechentwicklung - Sprachentwicklungsstörungen (Definition, Einteilung, Ursachen, Leitsymptome und fakultative Symptome, aufrechterhaltende Faktoren, Erscheinungsformen)	Berücksichtigung vorhandenen Wissens besonders aus dem Lerngebiet Phoniatrie; Darstellung der Normabweichungen und Störungsmöglichkeiten; Diskussion der psychischen und sozialen Auswirkungen; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie kennen die Ursachen von Lauterwerbsstörungen.	Störungen rezeptiver und expressiver Sprachleistungen auf der: - phonetisch-phonologischen Ebene • Ursachen • Formen • Einteilung	Kriterien zur Abgrenzung phonetischer und phonologischer Störungen erarbeiten; Ableitung der Störungscharakteristik der verschiedenen Laute, ausgehend von den physiologischen Bildungsnormen unter Berücksichtigung von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Phonetik/Linguistik;
Sie besitzen die Fähigkeit zur Darstellung der Symptomatik und Einteilung des Stammels nach verschiedenen Gesichtspunkten sowie zur Einschätzung von Lautfehlern sowie zur Differenzierung phonetischer und phonologischer Störungen.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die Erscheinungsformen semantisch-lexikalischer Störungen.	- semantisch-lexikalische Ebene • Ursachen • Formen • Symptome • Einteilung • Auswirkungen	Demonstration der häufigsten fehlerhaften Lautbildungen; Einsatz von Video- und Hörkassetten; Auseinandersetzung mit und Übungen zu verschiedenen Einteilungsmöglichkeiten; Arbeit mit Fallbeispielen; Reaktivieren von Wissen zur Sprachphysiologie; Abgrenzung von Störungen des Lexikonerwerbs und von Störungen des Abrufs lexikalischer Einträge; Aufzeigen möglicher Folgen; Darstellung des Störungsbildes unter Einbeziehung von Wissen über die morphologisch-syntaktische Entwicklung
Sie sind fähig zur Ableitung möglicher Auswirkungen auf die anderen Sprachebenen.		
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Beschreibung der Leitsymptome und fakultativen Symptome morphologisch-syntaktischer Störungen.	- morphologisch-syntaktischen Ebene • Ursachen • Formen • Symptome • Einteilung (z. B. Liebmann, Remmler)	Eingehen auf das Problem der Subjektivität der Einstufung grammatisch-syntaktischer Fehlleistungen; Voraussetzungen für eine situationsadäquate Kommunikation ableiten;
Sie kennen verschiedene Einteilungsmöglichkeiten.	- pragmatisch-kommunikativen Ebene • Ursachen • Erscheinungsbild	spezielle Störungsbilder darstellen
Sie erkennen und erfassen den Zusammenhang mit den anderen Sprachebenen.		
Sie besitzen einen Überblick über spezielle Störungsbilder.	logopädische Untersuchung rezeptiver und expressiver Sprachleistungen - Anamnesegespräch Rahmenbedingungen, Aufbau, Inhalte (Anlass der Anmeldung, Familien-, Eigenanamnese, Spiel-, Sozialverhalten, sozio-ökonomische Situation, soziale Wahrnehmung der Störung, bisherig Befunde/Therapien), - Auswertung	Ablaufschema für die logopädische Befunderhebung bei Sprach- und Sprechstörungen; Berücksichtigung vorhandenen Wissens aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie sowie Sprecherziehung zur Gesprächsgestaltung und zum Therapeutenverhalten; Erarbeitung adäquater Fragestellungen; Diskussion und kritische Auseinandersetzung mit weiteren Anamneseformen und ausgewählten Anamneseformata; Bedeutung der gewonnenen Daten für die Diagnostik und Therapie herausarbeiten;
Sie erfassen die Bedeutung des Therapeutenverhaltens und die Fähigkeit, sachbetont zu kommunizieren.		
Sie besitzen die Fähigkeit zur Strukturierung eines störungs-spezifischen Anamnese-schemas sowie zur Auswertung der Ergebnisse.		
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit dieses obligatorischen Untersuchungsschrittes und besitzen die Fähigkeit zur Ableitung weiterer Untersuchungsgänge, zur Auswahl adäquater Diagnoseverfahren sowie zum Erkennen eigener Grenzen und der Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit.	- freie Spiel- oder Gesprächssituation zwischen Untersucher und Kind (Inhalte, Gestaltung, Bedeutung, Auswertung)	Erarbeiten von Gestaltungsmöglichkeiten und Beobachtungsschwerpunkten Aufzeigen besonderer Anforderungen an das Therapeutenverhalten in der Kindertherapie; kritische Auseinandersetzung in Bezug auf die eigenen Kompetenzen; Frage der interdisziplinären Zusammenarbeit anhand von Fallbeispielen ableiten

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen reaktiviertes Wissen über die allgemeine physiologische Entwicklung des Kindes.	- Untersuchung nonverbaler Entwicklungsbereiche • motorisches Verhalten • Wahrnehmungsverhalten • kognitives Verhalten • soziales Verhalten • Eltern-Kind-Interaktion • diagnostische Verfahren zur Einschätzung des allgemeinen Entwicklungsstandes	Vorstellen und Demonstrieren gängiger Untersuchungsverfahren (Verhaltensbeobachtung, Interaktionsanalyse, nonverbale auditive und visuelle Merk- und Gedächtnisleistungen, grob-, fein-, mund-motorische Leistungen usw.)
Sie kennen relevante informelle und standardisierte Diagnoseverfahren.		
Sie können Kenntnisse über Störungen der rezeptiven und expressiven verbalen Leistungen auf den verschiedenen Sprachebenen anwenden.	- Diagnostik phonetisch-phonologischer Störungen • Diagnoseverfahren zur Lautüberprüfung und -differenzierung (Anforderungen, Zielgruppen, Aufbau, Material, Durchführung, Auswertung) • Einsatz instrumenteller Hilfen	Darstellung, Demonstration und Diskussion der gängigsten, spezifischen, informellen und standardisierten Diagnoseverfahren (Sprachverständnisprüfungen, Spontansprachanalyse, Nachsprechproben, Aufgaben zur phonematischen Differenzierung, Wortschatztests, Sprachentwicklungstests, z. B. LSV, HSET, PET, SETK);
Sie sind vertraut im Umgang mit den wichtigsten Diagnoseverfahren zur Einschätzung verbaler Leistungen.	- Diagnostik semantisch-lexikalischer Störungen • informelle und standardisierte Diagnoseverfahren zur Einschätzung des aktiven und passiven Wortschatzes	Aufzeigen von Einflussfaktoren auf das Untersuchungsergebnis; Möglichkeit der therapiebegleitenden Diagnostik diskutieren
	- Diagnostik morphologisch-syntaktischer Störungen • spezifische Beobachtungs-, Screening- und Testverfahren zur Einschätzung grammatischer Leistungen	
	- Diagnostik pragmatisch-kommunikativer Störungen • Beobachtungsschwerpunkte und -kriterien	Schwerpunkte der Interaktionsanalyse (Feedbackverhalten der Bezugsperson, kindliche Gesprächsfähigkeit) darstellen
Sie beherrschen die Fähigkeit zur kritischen Einschätzung ermittelter rezeptiver und expressiver sprachlich-kommunikativer Leistungen im Zusammenhang mit der allgemeinen Entwicklung.	- logopädischer Befund • Untersuchungsergebnisse • Störungsschwerpunkte • Hypothesen zur Verursachung und Aufrechterhaltung der Störung • Einschätzung der Prognose und Therapiebedürftigkeit • zusätzliche Fördermaßnahmen • ergänzende Untersuchungen • Therapieschwerpunkte	Arbeit mit Fallbeispielen; Übungen zur korrekten Auswertung und Zusammenfassung von Untersuchungsergebnissen; Kriterien für die Beurteilung einer Behandlungsbedürftigkeit und der Prognose diskutieren; Anforderungen, Inhalte und Gestaltungsmöglichkeiten von Patienten- bzw. Angehörigenberatungen erarbeiten
Sie besitzen Kenntnisse für eine kompetente Betroffenen- und/oder Angehörigenberatung.		
Nach einer Einführung in die Kindertherapie können sie die Bedeutung einer interdisziplinären Zusammenarbeit erfassen.	Therapie von Störungen der Sprach- und Sprechentwicklung - involvierte Fachdisziplinen - mögliche Therapiewege (Elternberatung, ambulante Therapie, stationäre Intensivtherapie, Sprachheileinrichtungen usw.)	Vorstellen verschiedener Betreuungs- bzw. Therapiemöglichkeiten unter Berücksichtigung der vorliegenden Beeinträchtigungen
Sie kennen die Prognosekriterien.	- interdisziplinäre Zusammenarbeit	
Sie erkennen die Elternberatung als wesentlichen Bestandteil der Kindertherapie.	- grundsätzliche Therapieformen	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie verfügen über Kenntnisse zur Planung von Beratungsgesprächen, zur Anleitung der Eltern als Co-Therapeuten und von Möglichkeiten des Elterntrainings.	- Elternberatung (allgemeine Zielsetzung, Formen, Grundlagen, Methoden, Phasen, Beratungsziele)	Stellenwert der Elternberatung herausarbeiten und begründen; Ableitung von Beratungszielen; Berücksichtigen des vorhandenen Wissens aus den Lerngebieten Sprecherziehung, Psychologie und klinische Psychologie, Pädagogik, Sonderpädagogik
Sie besitzen Kenntnisse über Inhalt und Gestaltung von Therapieabläufen und Therapiesitzungen.	- allgemeine Therapieprinzipien - Therapieplanung (Grundlagen, Inhalte, Form)	Erarbeiten von Musterplänen; Hinweis auf Berücksichtigung von Beurteilungen mitbehandelnder Therapeuten; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie besitzen die Fähigkeit, auf den Patienten und das Therapieziel abgestimmte Therapieschwerpunkte, geeignete Methoden und ggf. Materialien auszuwählen und zu begründen.	- Nachbereitung einer Therapiesitzung	Übungen zur Therapienachbereitung (5 W-Fragen)
Sie sind fähig zur - kritischen Reflexion einer Behandlungseinheit und Ableitung entsprechender Konsequenzen; - Protokollierung von Therapieverläufen und zum Verfassen von Behandlungsberichten.	- Erstellen von Behandlungsprotokollen und Berichten (Form, Inhalte)	Anforderungen an eine sachgemäße Dokumentation; Anfertigen von Muster-Protokollen und Berichten; korrekter Umgang mit Patientenunterlagen, Bezug zum Lerngebiet Berufs-, Geseteskunde
Sie haben Verständnis für die enge Verknüpfung und Wechselwirkung nonverbaler und verbaler Leistungen und Kenntnisse über nonverbale Therapieansätze.	- Förderbereiche (nonverbale, verbale) - Methoden zur Förderung nonverbaler Leistungen	Darstellung ausgewählter nonverbaler Therapiekonzepte als Vorbereitung oder Unterstützung einer sprachspezifischen Therapie (sprachlautunspezifisches Hörtraining, Förderung der visuellen und taktil-kinästhetischen Wahrnehmung, Verbesserung motorischer Fähigkeiten (grob-, fein-, mund-motorischer) und von Gedächtnis- und Konzentrationsleistungen sowie gezielter Imitation); Vorstellen verschiedener Verhaltensmodelle, Diskussion; Arbeit mit Fallbeispielen; Partner- oder Kleingruppenübungen
Sie sind vertraut mit sprachfördernden Verhaltensweisen und besitzen die Fähigkeit zur Beratung von Bezugspersonen im Hinblick auf positives Interaktionsverhalten.	- Konzepte für sprachentwicklungsförderndes Interaktionsverhalten (aktives Zuhören (Gordon), sprechförderndes Verhalten (Innerhofer), corrective-feedback nach Wyatt) Erweiterung nach Cazden usw.	
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer frühzeitigen Förderung und erfassen die Sprachanbahnung als Teil einer allgemeinen Entwicklungsförderung.	- Therapie im präverbalen Stadium (Zielgruppen, Inhalte und methodisches Vorgehen bei der Sprachanbahnung)	Therapieansätze zur Anregung bzw. Förderung von Lallproduktionen (Irwin, Goda), Förderung des Sprachverständnisses (Weigl) usw. diskutieren
Sie beherrschen die Fähigkeit zur sicheren Therapiezielformulierung und Methodenauswahl für den jeweiligen Therapiebereich entsprechend des Störungsschwerpunktes sowie zum effektiven Einsatz von Therapiematerialien.	- Therapie phonetisch-phonologischer Störungen • Therapiebereiche (auditive Wahrnehmung, Mundmotorik, Aneignung des Lautsystems, Elternarbeit) • Zielstellungen • Methoden und Material • Kriterien zur Ableitung von Therapieschwerpunkten	Vorstellung und Diskussion ausgewählter Therapiekonzepte (van Riper/Irwin, Wulf, Seeman, Ingram, McGinnis, Wängler, usw.) sowie Übungsgruppen für die einzelnen Therapiebereiche; Demonstration ausgewählter Therapiematerials (Anforderungen und Einsatzmöglichkeiten)

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen - methodische Varianten, ihre Vor- und Nachteile sowie verschiedene Stimulierungstechniken;	- Therapie semantisch-lexikalischer Störungen • Prinzipien, Therapie-schwerpunkte, Methoden und Material zur gezielten Erweiterung des passiven und aktiven Wortschatzes sowie der Behandlung kindlicher Wortabrufstörungen	Darstellung und Diskussion direkter, indirekter sowie kombinierter Methoden; Modellierungstechniken erarbeiten und üben; Vorstellen ausgewählter Vorgehensweisen (z. B. nach Wurst, Holtz, Grohnfeldt, Katz-Bernstein, Zollinger, Affolter) und geeigneter Therapiematerialien
- direkte und indirekte Methoden zum gezielten Aufbau von Satzverständnis und -produktion;	- Therapie morphologisch-syntaktischer Störungen (Prinzipien, Therapie-schwerpunkte, Methoden und Material)	Vergleich verschiedener Therapieansätze (z. B. linguistischer, entwicklungsproximaler, handlungsorientierter); Überblick über unterstützendes Material geben
- verschiedene therapeutischer Konzepte. Sie erkennen den Stellenwert einer konsequenten Elternarbeit.	- Therapie pragmatisch-kommunikativer Störungen (Therapieschwerpunkte, Therapieansätze)	Vorstellen von Möglichkeiten zum Erwerb bzw. zur Förderung pragmatisch-kommunikativer Fähigkeiten (z. B. nach Affolter, Zollinger, Katz-Bernstein)
Sie besitzen Verständnis für abweichende Entwicklungsverläufe und mögliche Störungsbilder.	besondere Diagnostik- und Therapieformen bei zentral sprach- und hörgestörten sowie geistig behinderten Kindern	Eingehen auf Besonderheiten in der Entwicklung; Problematik der Mehrfachbehinderung; Grenzen der logopädischen Diagnostik und Therapie darstellen; Abstimmung mit dem Themenbereich logopädische Befunderhebung und Therapie
Sie besitzen die Fähigkeit zur Ableitung und Darstellung des eigenen Aufgabenbereiches.		bei frühkindlichen zerebralen Bewegungsstörungen sowie den Lerngebieten Pädagogik, Sonderpädagogik sowie Psychologie und klinische Psychologie
Sie kennen sonderpädagogische Möglichkeiten.		
Sie haben Einsicht in die interdisziplinäre Zusammenarbeit und sind bereit zu dieser.		

6.13.4 Sprach-, Sprech- und Stimmstörungen durch Hörbehinderung (ca. 15 Stunden)

Sie sind sensibilisiert für die Problematik.	Bedeutung einer Hörbehinderung für die Gesamtentwicklung des Kindes	Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Phoniatrie, Audiologie und Pädaudiologie, Phonetik/Linguistik, Psychologie und klinische Psychologie, Sonderpädagogik;
Sie besitzen reaktivierte, erweiterte und gefestigte Kenntnisse und die Fähigkeit zur Beurteilung der Auswirkungen von Hörbehinderungen.	- Auswirkungen einer Hörbehinderung auf: • Sprechatmung • Phonation • Sprachentwicklung • Artikulation • Morphologie und Syntax • Wortschatz • suprasegmentale Sprachakzente • geistige Entwicklung • Psyche • soziale Auswirkungen	Besonderheiten der Sprachentwicklung Hörgeschädigter herausarbeiten; Darstellung und Diskussion von Fallbeispielen mit verschiedenen Arten und Graden von Hörstörungen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Verständnis für die Notwendigkeit einer Früherfassung.	Faktoren, die die Auswirkungen einer Hörbehinderung bestimmen - allgemeine (Zeitpunkt, Art und Ausmaß der Schädigung) - positive und negative Wirkfaktoren (Erfassung, Rehabilitation, Progredienz, soziales Umfeld usw.)	Einbeziehen und Wiederholen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Audiologie und Pädaudiologie; Übungen zur prognostischen Einschätzung, Arbeit mit Fallbeispielen
Sie haben Kenntnis und Verständnis für Probleme der Interaktion.		abweichendes Verhalten aufzeigen und begründen
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Beurteilung des Verhaltens und möglicher Reaktionen Hörbehinderter.	- postlingual Hörgeschädigte - perilingual ertaubte Kinder und Erwachsene - prälingual ertaubte Kleinkinder und Kinder - prälingual ertaubte Jugendliche und Erwachsene	
Sie sind befähigt zum richtigen Umgang mit Hörbehinderten.	Umgang mit Hörbehinderten	Erarbeiten von Hinweisen zum Umgang mit Schwerhörigen und Gehörlosen; persönliche Erfahrungen der Schüler einbeziehen; Abstimmung mit dem Lerngebiet Sonderpädagogik;
Sie besitzen einen Überblick und erkennen die Notwendigkeit einer interdisziplinären Diagnostik.	Diagnostik - involvierte Fachbereiche - ärztlich audiologischer bzw. pädaudiologischer und psychologischer Aufgabenbereich - logopädische Untersuchung • spezielle Anamnese • logopädischer Befund	Wiederholung audiologisch-pädaudiologischer Möglichkeiten; Verfahren zur Einschätzung von Intelligenz und Lernfähigkeit (sprachgebundene, sprachfreie Verfahren) nur informativ; Erarbeitung der Anamnese- und Untersuchungsinhalte
Sie können eigene Aufgabenstellungen ableiten.		Vorstellen von Verfahren zur logopädischen Diagnostik
Sie beherrschen die Fähigkeiten und Fertigkeiten zur störungsspezifischen Datenermittlung und -auswertung sowie zur Ableitung notwendiger Informationen für das therapeutische Vorgehen.		
Sie besitzen einen Überblick über verschiedene Behandlungsansätze, deren Möglichkeiten und Grenzen.	Therapie - Fachdisziplinen, Therapieformen, Zeitpunkt - apparative Rehabilitationsmöglichkeiten	mögliche Therapieformen bezüglich der Ätiologie erläutern; Gebärdensprache, Total Communication, auditive Kommunikationsförderung, DGS/PMS;
Sie haben reaktivierte Kenntnisse über die Hörgeräteversorgung und das CI.		Indikationen und Kontraindikationen einer apparativen Versorgung unter Einbeziehung von Wissen aus den Lerngebieten Audiologie und Pädaudiologie sowie Elektro- und Hörgeräteakustik diskutieren
Sie kennen die verschiedenen Maßnahmen einer ganzheitlichen Förderung Hörgeschädigter und deren Organisationsformen.	- Hörerziehung • Frühfördererziehung • Hörtraining • sonderpädagogische Maßnahmen	Darstellung der unterschiedlichen Vorgehensweisen, die sich für den Frühförderbereich, für hörgeschädigte Vorschul- und Schulkinder, spät ertaubte Kinder und Erwachsene ergeben;
Sie haben einen Überblick über verschiedene Formen des Hörtrainings sowie sonderpädagogische Betreuungsangebote.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen die Fähigkeit zur Adaptation von Therapieansätzen aus der Behandlung von Sprachentwicklungsstörungen, Dyslalien und Dysphonien und können alternative Kommunikationsmöglichkeiten ausschöpfen.	logopädische Therapie - logopädisch-pädagogisches Arbeitsfeld bei Schwerhörigkeit - logopädisch-pädagogisches Arbeitsfeld bei Gehörlosigkeit - Hörtraining	Abstimmung mit dem Lerngebiet Sonderpädagogik; jeweilige Zielstellung differenzieren und herausarbeiten; ausgewählte Methoden (sprachspezifisches bzw. sprachspezifisches Hörtraining, z. B. nach Wirth, Loewe, Beckmann) erläutern, demonstrieren und diskutieren; Computerprogramme; Partnerübungen; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie besitzen theoretische und praktische Voraussetzungen für die logopädische Hör-, Sprach-, Sprech- und Stimmtherapie Hörbehinderter.	- Verbesserung des Sprachverständnisses - Wortschatzerweiterung - Lautanbildung bzw. -korrektur - Optimierung der Grammatik und Syntax	
Sie haben Verständnis und für eine Zusammenarbeit im interdisziplinären Team und besitzen die Bereitschaft dazu.	- Verbesserung von Phonation und Prosodie - auditive Kommunikationsförderung bei CI-Trägern (Therapieziel, Inhalte des hörgerichteten Verhaltens, Grundlagen der frühen Hör-Sprachtherapie, Altersspezifik, prä- und postoperative logopädische Betreuung usw.)	Überblick über mitbetreuende Berufsgruppen; Arbeit mit Fallbeispielen; Übungen zur Therapieplanung
Sie besitzen Einblick in die Struktur, Zielstellung und Aufgaben eines CI-Zentrums und in die Arbeit der Selbsthilfegruppen.	- CI-Zentren - Selbsthilfegruppen	Erläuterung der Notwendigkeit einer mehrjährigen Intensivrehabilitation
Sie haben Überblick über angebotene technische Hilfsmittel und können ihre Bedeutung erfassen.	technische Kommunikationshilfen für Hörgeschädigte (Lichtsysteme, Telefonverstärker, drahtlose Kommunikationshilfen, Schreibtelefone, Computer usw.)	Möglichkeiten zur Unterstützung der Autonomie des Patienten erläutern und ausgewählte demonstrieren
Sie besitzen die Fähigkeit zur Beschreibung besonderer Probleme von Angehörigen Hörgeschädigter.	Angehörigen-, Elternberatung und Elterntraining - Zielstellung - Inhalte	Planung und Durchführung eines Beratungsgesprächs; Gesprächstraining in Kleingruppen (häufigste Fragen zum CI, zum Therapieablauf usw.);
Sie haben Kenntnisse zum Führen von Beratungsgesprächen.	- methodische Gestaltung - Rahmenbedingungen usw.	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Sprecherziehung, Psychologie und klinische Psychologie (Gesprächsführung)

6.13.5 Peripher bedingte Sprechstörungen (ca. 20 Stunden)

Die Schüler sind befähigt zur Anwendung von bereits erworbenen Kenntnissen.	- Begriff Dysglossie - Abgrenzung der Dysglossien von zentral bedingten Sprech- und Sprachstörungen	Reaktivieren von Wissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Neurologie und Psychiatrie, Kieferorthopädie, Kieferchirurgie und Phonetik/Linguistik;
Sie beherrschen die Fähigkeit zur - Abgrenzung von peripher bedingten und erworbenen zentral bedingten Sprechstörungen sowie zentralen phonologischen und phonetischen Musterstörungen;	- Einteilung der Dysglossien nach: • Lokalisation • Ätiologie • Art • betroffenen Sprachlauten - myofunktionelle Störungen, sprechmotorische Lautfehlbildungen	Einbeziehung eigener Erfahrungen; nasale, palatale und velare Dysglossien sollten angerissen, jedoch erst im Lernabschnitt funktionelle und organische Störungen der Nasalität genauer behandelt werden

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
- Einteilung der Dysglossien und Ableitung der funktionellen Einschränkungen der nicht-sprachlichen Lippen- und Zungenmotorik sowie deren Auswirkungen auf die Sprachlautbildung; - Ableitung, Formulierung und Begründung von Anamneseinhalten bei Dysglossien.	Schwerpunkte der speziellen logopädischen Anamnese - Ernährung (Stillen, Sonden-, Flaschen-nahrung, Saugverhalten, Schluckprobleme) - Mundatmung - orale Habits - Zahnentwicklung - prämorbides Sprechverhalten - kieferorthopädische und/oder kieferchirurgische Maßnahmen - Sprachentwicklung usw. interdisziplinäre Diagnostik (HNO-Status, Zahnstatus, neurologische Untersuchung usw.)	Reaktivieren allgemeiner Kenntnisse zur Erhebung der Vorgeschichte nach logopädischen Kriterien; Integration von Wissen aus den Lerngebieten Pädiatrie und Neuropädiatrie, Phoniatrie, Kieferorthopädie, Kieferchirurgie; Übungen zur Strukturierung eines störungsspezifischen Anamneseschemas
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit.		
Sie kennen spezifische Beobachtungs- und Prüfverfahren zur Diagnostik peripher bedingter Sprechstörungen.	logopädische Diagnostik - Funktions- und Artikulationsprüfungen bei den verschiedenen peripher bedingten Sprechstörungen • Gesamtkörpertonus, Tonus der Gesichtsmuskulatur, Ruhestellung bzw. Funktion von Lippen, Zunge, Kiefer, Gaumensegel, Schluckvorgang, Gaumenform • artikulatorische Fehlleistungen - instrumentelle Hilfen (Lippenhalter, Sonden, Payne-Technik, Messung der Lippenkraft nach Garliner, usw.)	Kenntnisse aus den Lerngebieten Neurologie und Psychiatrie, Phoniatrie und den Abschnitten 6.13.1 und 6.13.3 einbeziehen
Sie sind befähigt zur kritischen Auswahl und Begründung sowie Zusammenstellung von geeigneten Untersuchungsverfahren.		Darstellung und Demonstration verschiedener Beobachtungs- und Prüfverfahren
Sie besitzen einen Überblick über moderne Verfahren zur objektiven Beurteilung der Schluck- und der Artikulationsmuster.	- Zungensonographie - Tonsillensonographie - Axiographie - Artikulographie usw.	Einsatz von Bildmaterial, möglichst Demonstration am Gerät
Sie verfügen über die Voraussetzungen für eine ordnungsgemäße Dokumentation von Untersuchungsergebnissen.	- Dokumentationsformen (z. B. schriftliche, Ton- und Fotodokumentation, Videoaufzeichnungen)	Vorstellen verschiedener Dokumentationsbögen
Sie besitzen die Fähigkeit zur Ableitung der Behandlungsbedürftigkeit und Prognose.	Kriterien zur Behandlungsbedürftigkeit (Art der Verursachung, Art und Grad der Funktionsbeeinträchtigung; Art, Ausmaß und Dauer der artikulatorischen Fehlleistungen usw.)	Arbeit mit Fallbeispielen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen Kenntnisse über die Inhalte der logopädischen Therapie bei Dysglossien und Methoden zum Abbau myofunktioneller und sprechmotorischer Störungen.	logopädische Therapie - Ziele und Methoden • Verbesserung der Tonuslage (Gesamtkörpertonus, Gesichtsmuskulatur: Übungen zur Wahrnehmungsförderung und Tonusregulierung) • Verbesserung der Sensibilität und Motorik im orofazialen Bereich (Übungen zur oralen Stereognose, Nasenatmung, Zungenruhelage, zum Mundschluss und physiologischen Schluckmuster) • Verbesserung der artikulatorischen Fähigkeiten (systematische Artikulationstherapie)	Reaktivieren von Kenntnissen; Möglichkeiten der Transformation bereits bekannter Therapiemethoden in die Behandlung von Dysglossien kritisch diskutieren
Sie besitzen die Fähigkeit, individuelle Therapieziele abzuleiten und zu formulieren, geeignete Methoden auszuwählen und einen Therapieplan zu erarbeiten.		Notwendigkeit und Möglichkeiten zusätzlicher therapeutischer Maßnahmen verdeutlichen; die Problematik der Schluckstörungen sollte hier nur grob (weitere Kenntnisvermittlung im Lernabschnitt Dysphagien), pathologische Schluckmuster jedoch ausführlich besprochen werden
Sie sind zur interdisziplinären Zusammenarbeit zur Absicherung eines Therapieerfolges bereit.		
Sie haben Kenntnisse über klassische und neuere Therapiekonzepte.	ausgewählte Therapiekonzepte (z. B. MFT nach Garliner, MFT nach Kittel, orofaziale Regulationstherapie nach Castillo-Morales, LOOFT, GRUMS, PNF, Maßnahmen zur Förderung der oralen Stereognose nach Hahn, Verbesserung sprechmotorischer Fähigkeiten nach van Riper)	Auswahl liegt im Ermessen des Lehrenden
	zusätzliche therapeutische Maßnahmen (medizinische, kieferorthopädische, -chirurgische, physiotherapeutische usw.)	
Sie besitzen Kenntnisse über die Gestaltung der Patienten- bzw. Elternberatung bei Kindern mit peripher bedingten Sprechstörungen.	Beratungsgespräche - Zielstellung - Inhalte (z. B. Habitabbau, Motivation zur Therapie) - Methodik - Rahmenbedingungen	Einbeziehung von Wissen und Fertigkeiten aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie sowie Sprecherziehung (Gesprächsführung, Beratungsgespräch); Erarbeitung eines Konzepts und Diskussion verschiedener Varianten
6.13.6	Erworbenen, zentral bedingten Sprach- und Sprechstörungen (ca. 120 Stunden)	
6.13.6.1	Aphasien	
Sie verfügen über die Fähigkeit, gestörte Sprache und die damit verbundenen Probleme der Patienten wahrzunehmen.	unterschiedliche Erscheinungsformen der Aphasie und Reflexion durch die Betroffenen	Aufnahmen unterschiedlicher Aphasieformen und Erlebnisberichte als Einstieg in diesen Themenkomplex
Sie besitzen grundlegende Kenntnisse über Aphasie und kritische Auseinandersetzung mit der Definition Aphasie.	Definition Aphasie und Abgrenzung zu anderen Sprachstörungen Ursachen für die Entstehung von Aphasie Symptome und psychosoziale Folgen	Kenntnisse aus dem Lerngebiet Aphasiologie werden aufgegriffen und vertieft

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	unterschiedliche Klassifikationen	
	Krankheitsverlauf - akute Phase - chronische Phase	
Sie besitzen Verständnis für die psychosozialen Auswirkungen und Befähigung zur Angehörigenberatung.	Aphasie und die Auswirkungen auf Berufs- und Familienleben - Möglichkeiten der Rehabilitation und der Selbsthilfe - Ziele und Inhalt der Zusammenarbeit mit den Angehörigen Planung von Beratungsgesprächen	Rollenspiele
Sie sind fähig zur - differenzierten linguistischen Analyse der verschiedenen Aphasieformen; - Anamneseerhebung.	aphasische Sprache auf den verschiedenen Ebenen - phonematische Ebene - morphologisch-syntaktische Ebene - lexikalisch-semantische Ebene - kommunikativ-pragmatische Ebene	Kenntnisse aus der Phonetik/Linguistik werden vorausgesetzt
Sie beherrschen die gebräuchlichsten Testverfahren und sind befähigt zur Diagnostik.	Diagnostik - Erhebung der anamnestischen Daten • Anamnesegespräch (Aufbau (persönliche, medizinisch-biologische Daten)) - Befundung in der Akutphase • Testverfahren (Aachener Aphasie Bedside Test, AABT; Aphasie-Schnelltest nach Kroker) - Befundung in der chronischen Phase • Testverfahren (Aachener Aphasie Test, AAT; Aphasie-Checkliste, ACL) - psycholinguistische/neurolinguistische Diagnostik - modellorientierte Diagnostik (Blanken, Palpa, dt. Lemo)	Anamnesegespräche im Rollenspiel trainieren dieser Lehrabschnitt sollte sehr übungssintensiv sein
Sie besitzen Grundkenntnisse über Möglichkeiten der logopädischen Intervention und sind befähigt zur Therapiezielbestimmung.	Therapie - grundlegende Therapieprinzipien - Therapieziele - Therapieplanung (Therapiebeginn, Frequenz, Form) • Besonderheiten der Aphasie-therapie in der Akutphase (Spontanremission), störungsspezifischen Phase, und Konsolidierungsphase • Therapiebausteine	Therapieziele aus den diagnostischen Ergebnissen und den Besonderheiten des Patienten ableiten Arbeit mit Fallbeispielen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die gängigsten Therapiematerialien, auch neue Medien (Computerprogramme), und Befähigung zur Gestaltung von Therapiematerialien.	- spezielle Therapiemethoden • modalitätsspezifische Methoden (Deblockierungsmethode, MODAK, REST, MIT) • kommunikative Methoden (PACE) • kompensatorische Verfahren (nonverbale Symbole; Visual Action Therapie, VAT) • modellorientierte linguistische Therapie (NAT)	die Teilnehmer sollen die verschiedenen Methoden kennen und kreativ anwenden können (praxisnahes Arbeiten)
	- Therapiematerialien • NAT-Material • EKN-Materialien • Ela-Bildkästen • alltagsrelevante Materialien (Zeitungen, Prospekte usw.) • Computerprogramme	Beschäftigung mit den Therapiematerialien; Partnerübungen
6.13.6.2 Dysarthrophonien		
Sie kennen Therapiemöglichkeiten bei Störungen der Schriftsprache und bei der Zahlenverarbeitung.	Dyslexie und Dysgraphie - Einteilung - Symptome - Therapiemöglichkeiten	Kenntnisse aus der Aphasieologie werden aufgegriffen
	Akalkulie - Formen - Therapiemöglichkeiten	
Sie sind fähig zur Evaluation der Therapiemethoden.	Programme zur Evaluierung Grenzen der Aphasietherapie	
Sie kennen die Besonderheiten der kindlichen Aphasie.	kindliche Aphasie	Besonderheiten in der Symptomatik herausarbeiten; Differentialdiagnostik Sprachentwicklungsstörung
Sie besitzen Kenntnisse über den Sprachabbau bei Demenz und über Interventionsmöglichkeiten.	sprachliche Auffälligkeiten bei Demenz im Vergleich zur Aphasie (Therapieziele und -methoden)	
Sie erkennen den Zusammenhang von neuropsychologischen Leistungen des Gehirns und Störungen der Sprache und des Sprechens.	zentrale Störungen der Sprache, des Sprechens und der Wahrnehmung	Einordnung der Dysarthrophonie als Sprechstörung; Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Neurologie und Psychiatrie und Aphasieologie; Aufzeigen terminologischer Probleme
Sie besitzen gefestigtes Wissen über die Charakteristika der verschiedenen Formen der Dysarthrophonie.	- Definition - Einteilungsmöglichkeiten der Dysarthrophonien	
	- Ursachen und Pathogenese (bei der kortikalen, pyramidalen, extrapyramidalen, zerebellaren und bulbären Dysarthrophonie)	Herausarbeiten der Zusammenhänge von neurologischer Grunderkrankung und Dysarthrophonie

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die Folgen der Erkrankung für den Patienten.	- Schädigungsebenen nach dem ICIDH-Modell - Funktionssysteme (gestörte Funktionskreise bzw. daraus resultierende Therapiebereiche)	Kenntnisse aus den Lerngebieten Phonetik/Linguistik und Phoniatrie einbeziehen; Auswirkung fakultativ begleitender Störungen diskutieren
Sie besitzen Kenntnisse über	Diagnostik - logopädische Anamnese	besonders auch auf die Bedeutung der Störung für die Angehörigen der Betroffenen eingehen
- die störungsspezifischen Besonderheiten der Eigensozialanamnese; - diagnostische Verfahren;	- Aufbau, Durchführung und Auswertung informeller und standardisierter Untersuchungsverfahren • Beurteilung der Sprechorgane • Verständlichkeitsskalen • Untersuchungsgang nach Wirth • Frenchay-Test (Enderby) • Dysarthrie-Profil (Robertson) usw.	Diskussion zu eigenen Überlegungen der Schüler bezüglich der Inhalte und des methodischen Vorgehens; Vorstellen ausgewählter diagnostischer Möglichkeiten; Demonstration und praktische Übungen
- differentialdiagnostische Kriterien. Sie besitzen die Fähigkeit zur Abgrenzung der Dysarthrophonie gegenüber peripheren Stimm- und Sprechstörungen, Aphasie, Sprechapraxie und Dyslalie.	- Differentialdiagnostik • Dysarthrophonie-Sprechapraxie • Dysarthrophonie-Aphasie • Dysarthrophonie-Dysglossie • Dysarthrophonie-Dyslalie • Dysarthrophonie-Dysphonie	Gegenüberstellung der verschiedenen Störungsbilder; Einsatz von Fall- und Hörbeispielen sowie Videoaufnahmen; möglichst Patientenvorstellungen vornehmen
Sie besitzen Kenntnisse über Therapiemöglichkeiten.	Therapie - Ziele der Dysarthrophonotherapie - therapeutische Grundprinzipien - Therapiebereiche (Reflexe, Tonus/Haltung, Respiration, Phonation, Artikulation, Prosodie, Verständlichkeit) - Therapieschwerpunkte (respiratorische, laryngeale, velopharyngeale, orofaziale und mandibuläre Bewegungsstörungen; Koordination aller sprechmotorischen Komponenten, Versorgung mit Kommunikationshilfen)	vom jeweiligen Erscheinungsbild ausgehend unter Berücksichtigung der individuellen Situation des Betroffenen; mögliche Zielstellungen für die einzelnen Therapiebereiche sowie die Anwendung von Therapiemethoden aus der Stimm- und Artikulationstherapie diskutieren
Sie kennen verschiedene Therapiekonzepte sowie Kriterien zur Einführung von Kommunikationshilfen in die Therapie.	- kommunikative und alltagsorientierte Therapieansätze - neurophysiologische Behandlungskonzepte (Bobath-Therapie, PNF)	Vorstellung ausgewählter therapeutischer Vorgehensweisen (nach Tschirren, Eisenson, Förster, Robertson/Thomson usw.); Aufzeigen und ggf. Demonstration kompensatorischer Möglichkeiten: Kommunikationsstrategien und -hilfen wie z. B. Kommunikationstafeln, elektronische Hilfen;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
		Übungen zur Therapieplanung; Wissen aus den Lerngebieten Stimmbildung und Sprecherziehung einbeziehen; Hinweise auf spezielle Lagerungen geben; Notwendigkeit einer interdis- ziplinären Zusammenarbeit mit Physio- und Ergotherapeuten usw. ansprechen
6.13.7 Frühkindliche zerebrale Bewegungsstörungen (ca. 15 Stunden)		
Die Schüler erfassen die Bedeutung der Gruppentherapie.	- Gruppentherapie	Vorteile, Nachteile, Zeitpunkt des Beginns der Gruppentherapie; Bedeutung weiterer Therapie- elemente der Konsolidierungsphase (wie Rollenspiele, In vivo Training, Gesprächskreise, Selbsthilfe- gruppen) hervorheben
Sie besitzen Kenntnisse über	- Prognose	Anwendung von Kenntnissen über die Gesprächsführung; Erarbeitung eines Gesprächs- konzeptes (Berücksichtigung der individuellen familiären, beruf- lichen und sozialen Bedingungen des Betroffenen); Partner- und Kleingruppenübungen kindliche Dysarthrophonien unter 6.13.6.2 behandeln
- das störungsspezifische Beratungsgespräch;	Patienten- und Angehörigenberatung - Zielstellung - Inhalte	
- Ursachen, Symptomatik, Formen und Folgen zerebraler Bewegungsstörungen;	Ätiologie zerebral bedingter Störungen der Sprachentwicklung Formen und Symptome zerebraler Bewegungsstörungen (Spastik, Athetose, Ataxie, zentrale Hypotonie, Mischformen und MCD)	Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Phoniatrie, Pädiatrie und Neuropädiatrie, Neurologie und Psychiatrie, Psychologie und klinische Psychologie, Pädagogik und Sonderpädagogik; Problematik der möglichen Mehrfachbehinderung ansprechen
- Besonderheiten in der allgemeinen und sprachlichen Entwicklung bei zerebralen Bewegungsstörungen.	allgemeine und sprachliche Entwicklung des zerebral- paretischen Kindes (motorische Entwicklung, Nahrungsaufnahme, taktil- kinästhetische Sensibilität, Atmung, Stimme, rezeptive und expressive Sprachleistungen)	intensive Auseinandersetzung mit der Symptomatik bezüglich Atmung, Phonation, Artikulation und Mimik sowie Gegenüberstel- lung normaler und pathologischer oraler Reflexe
Sie verfügen über reaktivierte Kenntnisse und die Fähigkeit zur Abgrenzung kindlicher Dys- arthrophonien gegenüber anderen Sprach- und Sprechstörungen.	Differentialdiagnostik (Dysarthrophonie gegenüber Dyslalie, kindlicher Aphasie, Dysglossie usw.)	kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Störungsbildern

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit bei der Betreuung zerebralparetischer Kinder.	Untersuchung des zerebralparetischen Kindes - interdisziplinäre Befundung (neurologische Untersuchung, HNO-Status usw.)	Überblick über korrespondierende Lerngebiete und Begründung der Kooperation
Sie besitzen die Fähigkeit zur - störungsspezifischen Anamneseerhebung;	- logopädische Untersuchung • Aufbau und Inhalte eines störungsspezifischen Anamnesegesprächs (Saug-, Schluck-, Bewegungs- und Haltungsprobleme, Verhalten, kognitive Entwicklung, familiäre Situation, Umgang mit der Behinderung usw.)	Anwendung von Kenntnissen zur Anamnese; spezifische Anamneseinhalte ableiten, formulieren und begründen lassen; Einbeziehen von Verdachtszeichen für die Frühdiagnose
- Anwendung spezifischer Beobachtungs- und Prüfverfahren;	• störungsspezifische Befunderhebung (allgemeiner Entwicklungsstand, Verhaltens- und Bewegungsmuster, rezeptive und expressive Sprachleistungen, myofunktioneller Status, Atmung, Phonation, Artikulation usw.)	Aufzeigen und Begründen der Untersuchungsinhalte, der Einschätzungskriterien und des methodischen Vorgehens; Komplexität des Störungsbildes berücksichtigen; intensives Üben des Anamnesegesprächs und des Untersuchungsgangs sowie der Befundauswertung; Arbeit mit Fallbeispielen; Zusammenarbeit mit verschiedenen medizinisch-therapeutischen und pädagogisch-sonderpädagogischen Berufsgruppen
- kritischen Einschätzung der erhobenen Daten im Vergleich mit Normwerten der allgemeinen Entwicklung und Ableitung von Konsequenzen für die logopädische Arbeit im Rahmen der ganzheitlichen Betreuung;	• Auswertung der diagnostischen Daten (Untersuchungsergebnisse, Störungs-/Therapieschwerpunkte, Therapiebedürftigkeit, Prognose usw., Förderplan)	
- Übertragung der Grundsätze der SES- und Dysarthrophonotherapie.	störungsspezifische logopädische Therapie	Darstellen indirekter und direkter Therapiemethoden, ihrer Vor- und Nachteile; Demonstration und Übungen
Sie haben Verständnis für Möglichkeiten, Notwendigkeit und Grenzen des Einsatzes von Übungen und Techniken.	- sprechvorbereitende Therapieformen (Mund-, Ess-, Trinktherapie; Verbesserung der Sensibilität, der Koordination von Atmung und Stimmgebung)	
Sie sind fähig zur individuellen Methodenauswahl.	- Anbahnung/Förderung der Sprach- und Sprechentwicklung (indirekte, ganzheitliche Stimulierung; direkte Stimulierung von Sprachlauten bzw. ganzheitlichen Äußerungen)	
Sie kennen therapieunterstützende Mittel und sind fähig zum Stellen logopädischer Indikationen für Kommunikationshilfen.	- kompensatorische Kommunikationshilfen (Bildtafeln, Bliss-Symbole, Computer usw.)	Demonstration der Hilfsmittel und Kommunikationshilfen sowie ihres Einsatzes
Sie erkennen die Grenzen der logopädischen Arbeit und die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit oder einer Kompetenzerweiterung durch Zusatzausbildungen.	- therapiespezifische Hilfsmittel (Lagerungshilfen, Trink-, Esshilfen usw.) - spezielle Therapiekonzepte (z. B. nach Vojta, Bobath, Padovan, Pörnbacher, Castillo-Morales, PNF)	Vorstellen der bekanntesten Konzepte, Auswahl und Umfang im Ermessen der Lehrkraft

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	Förder- und Rehabilitations-einrichtungen - Formen und Ziele verschiedener integrativer, sonderpädagogischer Förder- bzw. Rehabilitations-möglichkeiten Selbsthilfegruppen - Ziele und Aufgaben der Selbsthilfegruppen (z. B. Spastikerverein)	Aufzeigen des Stellenwertes spezieller Beratungsstellen und Fördereinrichtungen sowie der Rolle von Selbsthilfegruppen im Rahmen der Rehabilitation von zerebralparetischen Kindern
Sie kennen die Grundprinzipien und Inhalte eines kompetenten Beratungsgesprächs. Sie sind zur Durchführung einer Beratung fähig.	Angehörigenberatung - Anforderungen - Inhalte (Reha-Maßnahmen und -einrichtungen, Fördereinrichtungen, Rechte für Behinderte, Bundessozialhilfegesetz usw.)	Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Sonderpädagogik, Psychologie und klinische Psychologie, Sprecherziehung sowie Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde; Strukturierung eines störungs-spezifischen Beratungsgesprächs; Übungen im Rollenspiel

6.13.8 Funktionelle und organische Störungen der Nasalität (ca. 15 Stunden)

Die Schüler verfügen über aktivierte, erweiterte und gefestigte Vorkenntnisse.	- Nasalität - Näseln • suprapalatinalen Räume des Ansatzrohres und Lautbildung • Physiologie des velopharyngealen Verschlusses • organisch und funktionell gestörter velopharyngealer Verschluss und seine Auswirkungen • Folgen einer behinderten Nasenhöhlen-/Nasenrachenpassage	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Pathologie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Phoniatrie, Phonetik/Linguistik und Kieferorthopädie, Kieferchirurgie; Abgrenzung Nasalität und Näseln; Aufzeigen möglicher Begleitstörungen (Hörstörungen, Störungen der Atmung, Phonation und Artikulation, Dysphagien usw.)
Sie kennen die verschiedenen Formen und Ausprägungsgrade des Näsels. Sie haben Verständnis für die interdisziplinäre Problematik.	- Charakteristika der verschiedenen Näselformen • Rhinophonia aperta (Formen, akustische Symptome, Rhinophonolalie) • Rhinophonia clausa (Formen, akustische Merkmale) • Rhinophonia mixta (Formen, akustische Merkmale)	Beschreibung der charakteristischen Symptome der verschiedenen Formen der Rhinophonia aperta, der Rhinophonolalie (Auswirkungen von submukösen Spalten und Spalten des primären und sekundären Gaumens), Rhinophonia clausa und mixta; Einsatz von Hörbeispielen und Videos
Sie sind fähig zur störungs-spezifischen Modifikation der Anamneseerhebung und besitzen reaktivierte und vertiefte Kenntnisse und Fähigkeiten.	- logopädische Anamnese	Erarbeitung und Diskussion möglicher Fragestellungen; Rollenspiele

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie verfügen über die Voraussetzungen zum Erfassen der Symptomatik, zur Einschätzung einer vorliegenden Störung und sicheren Abgrenzung der verschiedenen Näselformen. Sie haben gefestigte Kenntnisse und Fertigkeiten bezüglich der logopädischen Befunderhebung und können die eigenen Kompetenzen abgrenzen.	- logopädische Befunderhebung • Inhalte (Überprüfung der Atmung, Stimmklangbeurteilung, Nasalitätsprüfverfahren wie z. B. a-i-Probe, Wangenaufblasen, Probe nach Schlesinger, Kopfdrehprobe nach Nadoleczny ; Hilfsmittel wie Phonendoskop, Hauchspiegel, Spirometer usw.; Sprachstatus, Überprüfung der Mundmotorik) • Auswertung und Befunddokumentation	besonderer Schwerpunkt: Nasalitätsprüfverfahren; Erarbeitung der theoretischen Grundlagen, Demonstration der Durchführung und der einsetzbaren instrumentellen Hilfsmittel; Partnerübungen Klassifizierung des Näsels nach Symptomen und Schweregrad, Mühler'sches Schema (R, D, V, M); Übungen zur Auswertung und Dokumentation der Ergebnisse
Sie besitzen einen Überblick über objektive Verfahren.	- objektive Verfahren - Überprüfung des Gehörs	informative Vermittlung objektiver Verfahren
Sie besitzen die Fähigkeit zur richtigen Wertung von Anamnese- und Untersuchungsergebnissen. Sie verfügen über anwendungsbereite, erweiterte Kenntnisse.	- Ableitung von Aussagen zur Behandlungsbedürftigkeit und Prognose (Kriterien)	Arbeit mit Fallbeispielen
Sie erkennen die Möglichkeiten und Grenzen einer logopädischen Therapie im Rahmen der Rehabilitation offen näseler Kinder und Erwachsener.	- Behandlung des Näsels • Therapiemöglichkeiten bei organisch bedingten Störungen der Nasalität (chirurgisch, konservativ, kombiniert) • logopädische Aufgabenstellungen im interdisziplinären therapeutischen Team (Elternarbeit, manuelle Stimulationstherapie zur Verbesserung der Saug- und Schluckfunktion, tonusregulierende Maßnahmen, Wahrnehmungsförderung, Atem-, Stimmtherapie, MFT, Übungen zur Luftstromlenkung, Lautbildung und auditiven Kontrolle)	bezüglich des Einsatzes von Prothesen, Biofeedbackverfahren, sprechverbessernden Operationen sowie einer medikamentösen Zusatztherapie sollten Kenntnisse aus den Lerngebieten Kieferorthopädie, Kieferchirurgie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde und Phoniatrie reaktiviert werden; Frage der psychologischen Betreuung diskutieren; Berücksichtigung der Hörproblematik (pädaudiologische bzw. audiologische Betreuung); Möglichkeiten zur Unterstützung der Selbstkontrolle aufzeigen
Sie sind fähig zur Auswahl und Anwendung störungsadäquater Übungsgruppen und können Entscheidungen begründen.	• Therapiemöglichkeiten bei funktionell bedingten Störungen der Nasalität (Übungen zur Beseitigung einer funktionellen Fehlfunktion des Gaumensegels bei einer Über- bzw. Unterfunktion des velopharyngealen Sphinkters)	Beschreiben und Demonstration bekannter Übungsgruppen aus den Lerngebieten Stimmgebung und Logopädie 6.13.1 (Nasalierungs-, Summübungen, usw.; Aktivierung des velopharyngealen Verschlusses durch aktive und passive Maßnahmen)

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie können sich mit verschiedenen therapeutischen Vorgehensweisen auseinandersetzen.	• ausgewählte Therapiekonzepte (nach Fröschels, Wängler, Fühling-Lettmayer, Gutzmann, Seeman, Weinert, Wulff/Wulff/Ammann, Stern usw.)	Gegenüberstellung
Sie beherrschen die Fähigkeit zur	• Therapieplanung (Therapieziele, -bereiche, -schwerpunkte, Methoden, zeitliche Gliederung der Behandlung)	Lösen von Fallbeispielen in Gruppenarbeit
- individuellen, altersadäquaten störungsspezifischen Therapie; - fachgerechten Beratung.	• Patienten- und Angehörigenberatung (Inhalte)	Anwendung von Wissen aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie und Sprecherziehung; Rollenspiele

6.13.9 Störungen des Redeflusses wie Stottern und Poltern (ca. 90 Stunden)

Die Schüler kennen verschiedene Definitionen und Erklärungsmodelle zur Ätiologie und Aufrechterhaltung des Stotterns.	Stottern - Definitionen des Stotterns - Erklärungsansätze zur Verursachung und Aufrechterhaltung des Stotterns • somatische Theorien • Neurosetheorien • lerntheoretisches Modell • Modell der interaktiven Beziehungen physiologischer, psycholinguistischer und psychosozialer Variablen (Johannsen/Schulze) • Anforderungs- und Kapazitätenmodell (Starkweather) usw.	Einführung in die Problematik; Darstellung des äußerst vielschichtigen Problems Stottern; Reaktivieren und Vertiefen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Phoniatrie, Neurologie und Psychiatrie sowie Psychologie und klinische Psychologie
Sie können das Stottern als multidimensionales Problem erkennen und verstehen.		
Sie besitzen einen Überblick über mögliche Risikofaktoren.	- Risikofaktoren	Herleiten der Risikofaktoren für das Entstehen des Stotterns beim Kind
Sie kennen Primär- und Sekundärsymptomatik beim Stottern auf der sprachlichen und nichtsprachlichen Ebene und sind sensibilisiert für die Klientel.	Kennzeichnung des Stotterns - Symptomatik • Grundsymptome • Begleitsymptome - Sprachcharakteristika - beobachtbare Regelmäßigkeiten (Konsistenz- und Adaptationseffekt, Variabilität) - kommunikative Verantwortlichkeit des Stotterers - Stottern als soziales Verhalten - Persönlichkeitsmerkmale des Stotterers	Beobachtungsaufgaben wie z. B. Sprechfluss bei Normalsprechern, Verhalten von Personen, die mit Stottern kommunizieren; Einsatz von Video- und Tonaufnahmen; Vorstellen und diskutieren von Fallbeispielen; Durchführung von Rollenspielen; Übungen zur Selbsterfahrung: „absichtliches Stottern“
Sie besitzen die Fähigkeit zur Darstellung der Symptomatik und Einteilung des Stotterns.		
Sie kennen die psychosozialen Folgen des Stotterns.		
Sie besitzen Kenntnisse der Merkmale für normale und pathologische Sprechunflüssigkeiten, der Entwicklungsstadien und Ausprägungsgrade.	- Entwicklung des Stotterns • entwicklungsbedingte Unflüssigkeiten	Erarbeiten der unterschiedlichen Symptomatik der verschiedenen Entwicklungsstadien; Einsatz von Video- und Tonkassetten;

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die Kriterien für die Gefahr eines chronischen Stotterverlaufes beim Kind.	• beginnendes Stottern • chronisches Stottern (bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen) • Gruppeneinteilung der Stotterer nach van Riper	Arbeit mit Fallbeispielen
Sie sind fähig zur	- Differentialdiagnose bei Sprechunflüssigkeiten (vor allem Poltern, Aphasien, Dysarthrien, spastische Dysphonien, Mutismus, temporäre Entwicklungsunflüssigkeiten)	Gegenüberstellung der wichtigsten Störungsbilder und Erarbeiten differentialdiagnostischer Kriterien
- Abgrenzung des Stotterns von anderen Störungen der Sprache und des Sprechens;		
- Erhebung der störungsspezifischen Anamnese, Diagnostizierung, Differentialdiagnostik und Schweregradbestimmung.	Untersuchungsgang beim Stottern	Berücksichtigung vorhandenen Wissens aus den Lerngebieten Phoniatrie, Psychologie und klinische Psychologie sowie Sprecherziehung (Gesprächsgestaltung); Erarbeiten adäquater Fragestellungen; Herausarbeiten der Bedeutung der gewonnenen Daten für die Diagnostik und Therapie; Partnerübungen zur Durchführung eines Erstgesprächs; Erarbeiten der Vorgehensweise bei der Befunderhebung bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen; Vorstellen verschiedener Diagnoseschemata; Demonstration eines Untersuchungsgangs; Übungen zur Anamneseerhebung, Diagnostik und Ableitung von Therapiezielen und -schwerpunkten anhand von Fallbeispielen und im Rollenspiel; Erarbeiten von Hilfen zur Ableitung der Behandlungsbedürftigkeit
Sie verfügen über Kenntnisse des diagnostischen Vorgehens bei Kindern, Jugendlichen und Erwachsenen mit Refluxstörungen.	- Anamnese	
Sie besitzen die Fähigkeit zur Beschreibung der Inhalte des speziellen Befundes und Bewertung der ermittelten Daten.	- logopädische Untersuchung (Beschreibung der Sprechstörung, Datenerhebung, Tests, Beurteilungsskalen und apparative Hilfsmittel in der Stotterdiagnostik, Ableitung von Therapieschwerpunkten, Kriterien zur Beurteilung der Behandlungsbedürftigkeit)	
Sie sind vertraut mit verschiedenen Tests, Beurteilungsskalen und apparativen Hilfsmitteln sowie deren Einsatz und Auswertung.		
Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit einer ganzheitlichen Erfassung der Stottererpersönlichkeit.		
Sie besitzen die Fähigkeit zur Ableitung von Therapieschwerpunkten.		
Sie kennen	therapeutisches Vorgehen beim Stottern	Diskussion über notwendige Voraussetzungen eines Logopäden für eine Stottertherapie; Erarbeitung von Zielstellung und Interventionspunkten der einzelnen Therapieformen; Vorstellen, Vergleich und Diskussion ausgewählter Ansätze; Einsatz von Videos
- die Kriterien zur Einschätzung der Behandlungsbedürftigkeit;	- Anforderungen an den Therapeuten	
- die persönlichen und fachlichen Voraussetzungen eines Stottertherapeuten.	- Einteilung der Therapieansätze (indirekte, symptomorientierte/ direkte, methodenkombinierte)	Begriffe: primäre, sekundäre, tertiäre Prävention; Vermitteln von Empfehlungen zur Stotterprävention (nach Fiedler/ Standop, Heidemann/Schönfelder usw.);
Sie besitzen die Fähigkeit zum Beschreiben verschiedener Therapieziele und Methoden unterschiedlicher Therapieansätze.	- Vorgehen bei entwicklungsbedingten Sprechunflüssigkeiten	
Sie kennen verschiedene Vorgehensweisen bei temporären Unflüssigkeiten und haben Überblick über Möglichkeiten der Vorbeugung.	• Elternberatung • Eltern-Kind-Therapie	

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen die verschiedenen Vorgehensweisen bei stotternden Vorschul- und Schulkindern und sind fähig zur Auswahl eines auf den Patienten und das Therapieziel abgestimmten geeigneten therapeutischen Vorgehens. Sie besitzen einen Überblick über unterstützendes Therapiematerial.	- Therapie bei kindlichem Stottern • frühzeitige Intervention • indirekte Therapie (Indikation, Entwicklung psychischer, physiologischer und linguistischer Voraussetzungen für flüssiges Sprechen, Eltern als Co-Therapeuten, Behandlungs- und Beratungskonzepte für Eltern, weitere Therapieformen: analytische und klientenzentrierte Spieltherapie, Musiktherapie) • symptomorientierte/direkte Therapie (Indikation, Verstärkungstechniken zur Ausweitung flüssig gesprochener Redeanteile, Techniken zur Auflösung von Blockierungen) • methodenkombinierte Ansätze (z. B. van Riper, Dell, Wendlandt; Zielstellung, Vorgehensweise) • Schulfähigkeit und Stottern • Therapiematerial	Diskutieren sprachfördernder Verhaltensweisen; Rollenspiele (Selbsterfahrung; Wirkung sprachfördernder und sprachhemmender Verhaltensweisen) mögliche Ziele (auf das Kind bezogene, auf die Umwelt bezogene) darstellen und diskutieren; Aufzeigen der unterschiedlichen Behandlungsschwerpunkte für die Therapie des beginnenden Stotterns und des Stotterns mit Sekundärsymptomatik Vorstellen ausgewählter Therapieansätze für die Kindertherapie; Einsatz von Videoaufzeichnungen; Demonstration von Therapiematerial
Sie besitzen die Fähigkeit zum groben Beschreiben von weiteren Behandlungs- und Beratungsansätzen. Sie haben Einsicht in die Notwendigkeit weiterführender Wissensvertiefung.	- Elternberatung und Elterntraining • theoretische Grundlagen • Zielstellung • Methoden (Innerhofer, Motsch, Wendlandt, Katz-Bernstein, Zollinger usw.)	Anforderungen, Inhalte und Gestaltungsmöglichkeiten von Angehörigenberatungen erarbeiten und begründen; Partner- und Kleingruppenübungen; Einbeziehung von Kenntnissen und Fertigkeiten aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie, Sprecherziehung und Stimmbildung
Sie besitzen Kenntnisse über theoretische Grundlagen, Therapieformen, -ziele und -methoden verschiedener therapeutischer Konzepte sowie ihrer Vor- und Nachteile bei der Behandlung stotternder Jugendlicher und Erwachsener.	- Therapie bei Jugendlichen und Erwachsenen • Therapieziele • Therapieformen (kausale Therapie, symptomatische Therapie) • Grundmodelle der Behandlung des chronischen Stotterns (Stottermodifikation, Fluency Shaping, Kombination)	Darstellung und Diskussion unterschiedlicher Therapieansätze sowie ihrer Konsequenzen, Vermittlung von Methoden zur Verbesserung der Körperwahrnehmung und körperlichen Entspannung, zur Verbesserung der Selbst- und Symptomwahrnehmung, Methoden zur Angstreduzierung, zur Variation und Modifikation der Stotter-symptomatik

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen die Fähigkeit zur individuellen Therapieplanerstellung.	- Therapieansätze beim chronischen Stottern im Jugend- und Erwachsenenalter (Atemtherapie/spannungsregulierende Methoden, Sprechhilfen/-techniken, Logopädischer Rhythmus, Akzentmethode, Psychotherapie, VAR usw., computergestützte Stottertherapie, medikamentöse Zusatztherapie) - Elemente der Therapie (Selbstwahrnehmung, Desensibilisierung, Modifikation, Stabilisierung und Generalisierung, Nachsorge) - Planung einer Therapie unter Berücksichtigung der psychosozialen Situation des Patienten	zur Einstellungsänderung und zum Aufbau einer zunehmenden Selbstkontrolle sowie zum Transfer neuer Fertigkeiten in den Alltag; Demonstration ausgewählter Vorgehensweisen; Erarbeiten und Üben von Sprechhilfen und -techniken; Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie, Phoniatrie und Musiktherapie; Einsatz von Video- und Hörkassetten Übungen zur Therapieplanung
Sie besitzen die Kenntnis über Indikation, Vor- und Nachteile der Einzel- und Gruppenbehandlung sowie ausgewählte Konzepte.	Einzel- und Gruppentherapie - gruppentherapeutische Konzepte	Diskutieren der Möglichkeit von Einzel- und Gruppentherapien; Vorstellen ausgewählter Konzepte (z. B. nach van Riper, Wendlandt)
Sie erfassen den Stellenwert der Selbsthilfegruppe zur Unterstützung der professionellen Stottertherapie.	Stottererselbsthilfegruppe - Zielstellung - Aufgaben	Rolle der Selbsthilfegruppe bei der Vorbereitung auf eine Therapie sowie bei der Stabilisierung von Therapieergebnissen und Möglichkeit der Zusammenarbeit diskutieren; Kontaktaufnahme zu einer Selbsthilfegruppe
Sie haben Kenntnis von Hilfen für die prognostische Einschätzung des Therapieverlaufs.	Prognosekriterien für die Einschätzung des Therapieverlaufs (Form und Schweregrad, Dauer und Konstanz des Stotterns, Vermeideverhalten, Leidensdruck, Motivation und Kooperationsbereitschaft, Unterstützung durch die Familie)	Berücksichtigung der Möglichkeit des Auftretens resistenter Fälle oder von Rezidiven; Arbeit mit Fallbeispielen
Sie besitzen Kenntnisse über Ätiologie und Symptomatik des Polterns sowie die psychosozialen Auswirkungen der Störung.	Poltern - Störungsbild • Ursachen • Symptome • Formen des Polterns • charakterologische Merkmale des Polterers	Reaktivieren von Vorkenntnissen aus dem Lerngebiet Phoniatrie; Erarbeiten der vielfältigen Symptome und der begleitenden Auffälligkeiten wie z. B. Konzentrationsstörungen, Wahrnehmungsstörungen, visuomotorische Koordination; Arbeit mit Hörbeispielen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen die Fähigkeit zur Strukturierung eines störungs-spezifischen Anamneseschemas. Sie kennen den Untersuchungsgang.	- Diagnostik • Anamnese • logopädische Untersuchung (Inhalte, Prüfverfahren)	Ableitung der Inhalte der Anamnese und des speziellen Befundes (Selbstwahrnehmung, Artikulations- und Stimmstörungen, Sprechgeschwindigkeit sowie begleitende Auffälligkeiten usw.); Darstellung verschiedener Diagnoseverfahren (z. B. nach Liebmann, Weiss, VAR, Silbenschnelligkeitstest); Übungen zur Anamneseerhebung und logopädischen Befundung des Polterers
Sie sind fähig zur sicheren Abgrenzung des Polterns gegenüber anderen Sprech- und Sprech-ablaufstörungen.	- Differentialdiagnose des Polterns	Vergleich der Symptomatik, Persönlichkeit sowie des Verhaltens von Polterern und Stotterern, Abgrenzung des Polterns vom Stammeln, der Dysarthrie, Dysglossie sowie Nuscheln und reiner Tachylalie
Sie besitzen Kenntnisse über den Aufbau und das methodische Vorgehen beim Polter-Syndrom und sind fähig zur Therapieplanung und Therapigestaltung. Sie erkennen die Notwendigkeit einer interdisziplinären Zusammenarbeit.	- therapeutisches Vorgehen beim Poltern • Zielstellung • Therapieprinzipien (Beratung, Bewusstmachung, systematische Einübung gesteuerter Sprach- und Artikulationsabläufe) • Therapieschwerpunkte (Wahrnehmungstraining, Reduzierung des Sprechtempos, Artikulationstherapie usw.) • Methodik • Therapie bei Kindern und Erwachsenen • altersadäquate Therapieplangestaltung • ausgewählte Therapiekonzepte	Prinzipien des Aufbaus eines speziellen Sprechprogramms, Methoden zur Verbesserung der Selbstkontrolle und Veränderung der Sprechweise sowie Prinzipien der Generalisierung erarbeiten; Darstellung, Diskussion, Erprobung verschiedener Sprechtechniken und des Einsatzes instrumenteller Hilfen
Sie kennen die Prognosekriterien und besitzen die Fähigkeit zur Anwendung dieser. Sie haben Verständnis für	Prognose	Diskutieren des Stellenwertes der Motivation und Patienteneinsicht; Herausarbeiten der Transferprobleme
- die Einbeziehung von Angehörigen; - unterschiedliche therapeutische Vorgehensweisen.	Kombination Poltern und Stottern - therapeutisches Vorgehen bei Polter-Stottern - Behandlung bei Stotter-Poltern	Gegenüberstellen der verschiedenen Behandlungsabläufe

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.13.10	Entwicklungsdyslexien und Entwicklungsdysgraphien (ca. 15 Stunden)	
Die Schüler besitzen Kenntnisse über Besonderheiten des Schriftspracherwerbs.	Begriffsklärung Entwicklungsdyslexie und -dysgraphie, Lese-Rechtschreib-Schwäche (LRS), Legasthenie Besonderheiten der Schriftsprache, Prinzipien der deutschen Orthographie: - phonologisches Prinzip - morphologisches Prinzip - grammatisches Prinzip usw. Phasen des Schriftspracherwerbs Lese- und Rechtschreibunterricht in der Schule Bedeutung der visuellen Differenzierungsfähigkeit und auditiven Voraussetzungen (phonologische Bewusstheit)	Abgrenzung von Entwicklungsstörungen zu Lese- und Schreibstörungen nach dem vollendeten Schriftspracherwerb Kenntnisse aus der Linguistik (Sprachverarbeitungsmodelle) einbeziehen Kenntnisse aus den Lerngebieten Phonetik/Linguistik und Logopädie 6.13.3
Sie kennen die Ursachen, Formen und Symptomatik der Entwicklungsdyslexie und -graphie.	Störung des Schriftspracherwerbs - Ursachen - Formen - Symptome	Bedeutung von Sprachentwicklungsstörungen hervorheben; Darstellung der multifaktoriellen Ätiologie und unterschiedlichen Erklärungsansätze sowie der auftretenden Fehlerarten
Sie erkennen die Notwendigkeit einer Früherkennung.	Früherkennung der Risikogruppe (Differenzierungsprobe nach Breuer/Weuffen, Bielefelder Screening usw.)	Vorstellung ausgewählter Verfahren
Sie haben Kenntnisse über den Diagnostikprozess und können die Notwendigkeit einer interdisziplinären Diagnostik erfassen.	Diagnostik - Anamnesegespräch - logopädische Untersuchung • Diagnostikbereiche • Behandlungsbedürftigkeit innerhalb der Logopädie (Kriterien)	störungsspezifische Inhalte herausarbeiten; Aufzeigen diagnostischer Möglichkeiten, z. B. Vorstellung und Demonstration verschiedener Tests, wie z. B. Zürcher Lesetest, Subtests des PET, Lautdiskriminationstests, diagnostische Rechtschreibtests; Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie
Sie kennen die verschiedenen therapeutischen Möglichkeiten und sind befähigt zum kreativen Umgang.	Therapie - Rahmenbedingungen und Prinzipien - Therapieansätze • Förderung der visuellen Wahrnehmung (Frostig) • Förderung der auditiven Wahrnehmung (psycholinguistische Ansätze) • computergestützte Therapie	Verweis auf die unterschiedlichen Regelungen der einzelnen Bundesländer bei der Diagnose LRS Diskussion weiterer Ansätze wie z. B. den Kieler Leseaufbau, Rechtschreibprogramme, Text- und Regelprogramme

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie sind zur gezielten Elternberatung fähig.	Elternberatung und Elternanleitung - Aufbau, Ziele und Inhalte eines Beratungsgesprächs - Zusammenarbeit Eltern-Schule-Therapeut	Stellenwert der Elternarbeit herausarbeiten; Partnerübungen zum Beratungsgespräch
Sie kennen weitere Fördermöglichkeiten.	schulische und außerschulische Förderung Bundesverband Legasthenie e. V.	Nutzung der Kenntnisse aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie, Pädagogik sowie Sonderpädagogik
6.13.11 Dysphagien (ca. 25 Stunden)		
Die Schüler verfügen über reaktivierte Kenntnisse.	physiologischer Schluckakt (orale Vorbereitungsphase, orale, pharyngeale und ösophageale Phase)	vgl. auch Lerngebiete Anatomie und Physiologie
Sie haben konsolidierte Kenntnisse über Ursachen und Erscheinungsformen der Dysphagie.	gestörter Schluckakt - Dysphagie: Definition und Epidemiologie - Schluckstörungen v. v. Schluckfehlfunktionen - Ursachen der Dysphagie (zentrale und periphere neurologische Erkrankungen, Kopf-Hals-Erkrankungen, Ösophaguserkrankungen) - Symptomatik der Dysphagie in den einzelnen Phasen - Zusammenhang Fazialisparese, Dysarthrophonie, Dysphagie	Bezug zum Lerngebiet Phoniatrie Verbindung zu myofunktionellen Störungen sowie den erworbenen zentral bedingten Sprach- und Sprechstörungen
Sie kennen diagnostische Möglichkeiten und sind zur logopädischen Beurteilung fähig.	Diagnostik - phoniatisch-logopädische Beurteilung - instrumentelle Diagnostik (videoendoskopische und radiologische Funktionsdiagnostik wie: Videofluoroskopie, Magnetresonanztomographie, Ultraschalldiagnostik, Laryngoskopie, Stroboskopie)	siehe auch Lerngebiet Phoniatrie, Untersuchungsmethoden bei Dysphagie; Anamnese- und Befundbögen vorstellen (Bartolome, Schalch usw.)
Sie besitzen die Fähigkeit zum Aufbau und zur Durchführung einer Schlucktherapie.	Therapie - Indikation - Therapiewege (konservative, chirurgische Maßnahmen) - Ziele und Inhalte einer funktionellen Schlucktherapie - kausale Therapie (Techniken zur Verbesserung der oralen Sensomotorik)	Entscheidungskriterien für bzw. gegen eine Therapie Hinweis auf die interdisziplinäre Zusammenarbeit, unter anderem Physiotherapie und Diätetik ausgewählte Behandlungsmethoden und -konzepte vorstellen (PNF, thermale Stimulation; Schlucktherapie nach Bartolome, Logemann, Schalch, usw.); auf Verhalten bei Patienten mit Tracheostoma und Patienten ohne Schutzreflexe hinweisen; Demonstration und Übung der Methoden bzw. Techniken

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	- kompensatorische Therapie (Haltungsaufbau, -änderung, Haltungstechniken, Schluckmanöver, diätetische Maßnahmen) - Hilfsmittel und deren Einsatz (Ess- und Trinkhilfen, intraorale Prothesen, Eisstäbchen, Saugschlauch, Kausäckchen, Nahrungsmittelverdicker, Lebensmittelfarbe usw.)	Demonstration
Sie besitzen Kenntnisse über den Aufbau und die Inhalte eines störungsspezifischen Beratungsgesprächs.	- Beratungsgespräch mit Betroffenen und Angehörigen	Regeln zur Sicherheit des Patienten mit Schluckproblemen

6.14 Phonetik/Linguistik (100 Stunden)

Lernabschnitte

- 1 Phonetik, Phonologie
- 2 Linguistik

Zeitrichtwerte

- ca. 40 Stunden
ca. 60 Stunden

6.14.1 Phonetik, Phonologie (ca. 40 Stunden)

Sie können die Bedeutung des Lerngebiets für den Beruf des Logopäden erfassen.	- Einführung (allgemeine Sprachwissenschaft) - Sprachsystem und Äußerung (Hauptebenen von Sprachstruktur und Sprachverwendung) - Aufgaben der Phonetik (allgemeine und angewandte Phonetik) Phonetik als Natur- und Geisteswissenschaft in Beziehung zu anderen Wissenschaften historische Entwicklung der Phonetik und Phonologie artikulatorische Phonetik - Bau und Funktion des äußeren und inneren Atemapparates (Ruhe- und Stimmatmung, Atemformen, Atemzentren, Atemstütze)	Motivation für das Lerngebiet
Sie haben Kenntnisse zur Wissenschaftsgeschichte.	- Phonation (anatomische Voraussetzungen: Kehlkopfknorpel und -muskulatur, Stimmerzeugungstheorien, Indifferenzlage; Register)	einleitender Überblick
Sie besitzen reaktivierte und erweiterte Grundkenntnisse über Anatomie und Physiologie der Funktionskreise, Respiration, Phonation, Artikulation.	- Artikulation (anatomisch-physiologische Grundlagen; Artikulationsorgane: bewegliche und unbewegliche Teile, Veränderungen der Dimensionen des Ansatzrohres; Artikulationsbasis)	Einbeziehung der Kenntnisse aus anderen Lerngebieten (z. B. Anatomie und Physiologie, Phoniatrie und Stimmbildung)
Sie sind sensibilisiert und befähigt zum funktionellen Hören.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen die Fähigkeit zur Gliederung und phonetischen Umschreibung der Laute.	Lautklassen, Lautverschriftung, Anwendung	Lautbildungsformen und Lautbildungsfehlformen;
Sie können das Transkriptionssystem anwenden.	- Vokale - Diphthonge - Konsonanten - Koartikulation und Assimilation	Einsatz von Hörbeispielen: Übungen zum Erfassen und Einschätzen sprechsprachlicher und stimmlicher Eigenschaften; Übungen in phonetischer Umschrift (IPA);
	stilistische Varianten der Standardaussprache	Beschreibung abweichender Artikulation (z. B. dialektale Besonderheiten)
Sie besitzen reaktivierte und erweiterte Kenntnisse über Anatomie und Physiologie des peripheren Hörorgans und der Hörzentren sowie Perzeption lautsprachlicher Zeichen.	akustische und auditive Phonetik - Grundkenntnisse über Bau und Funktion des Hörorgans - Grundlagen zur Akustik des Sprechens - Grundkenntnisse zu auditiven Sprachperzeptionstheorien	in Abstimmung mit den Lerngebieten Audiologie und Pädaudiologie, Elektro- und Hörgeräteakustik Schwerpunkte z. B.: Schallentstehung, -formen, -veränderungen, -untersuchung, Charakteristika der Formanten
Sie haben Kenntnisse über notwendige Einsichten in die phonologischen Grundlagen der deutschen Sprache sowie die Fähigkeit zur Ableitung der Voraussetzungen für korrekte orthoepische und orthographische Sprachleistungen und können diese erfassen.	Phonologie - phonemtheoretische Grundlagen • Lauteigenschaften und distinktive Funktion • Phonembegriff • Allophon und Variationsarten • phonetisch-phonologische Merkmale • phonologische Untersuchungsmethoden	Darstellung von Beispielen klinisch relevanter segmentaler Störungen
	- Phoneme der deutschen Gegenwartssprache • Vokalphoneme (distinktive Merkmale, Minimalpaarlisten der wichtigsten Oppositionen, Sonderprobleme, z. B. Affrikate, r-Allophone) • Darstellung des Konsonantensystems	Beschreibung und Diskussion von phonetisch-phonologischen Fehlleistungen z. B. im Bereich von Sprachentwicklungsstörungen, Aphasie und LRS
	- phonologische Regeln und Prozesse - Phonem-Graphem-Beziehung - phonetisch-phonologische Störungen	Hör-, Transkriptionsübungen und Analyse von gestörter Lautsprache
Sie erkennen die Bedeutung der Intonation als Satzbildungs- und Ausdrucksmittel.	Intonation/Satzphonologie	logopädisch relevante klinische Beispiele suprasegmentaler Störungen: z. B. Veränderungen von prosodischen Parametern bei psychiatrischen und neurologischen Erkrankungen
Sie besitzen die Fähigkeiten im Gebrauch der sprecherischen Mittel.	- Gemeinsamkeiten und Unterschiede geschriebener und frei gesprochener Texte	
Sie erfassen die innere Textgestalt sowie die Intonation als Charakteristik der Satzart.	- Form und Funktion der Intonation (Begriff und Intonationsmittel) • Wortakzentuierung in deutschen und fremden Wörtern • Wortgruppen- und Satzakzentuierung • Gliederung	
Sie besitzen reaktivierte und erweiterte Kenntnisse über die Kundgabeart der Gefühle der Sprechenden und der Einstellung zum Hörer.		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	• Rhythmisierung (Besonderheiten der rhythmischen Gruppen beim produzierenden Sprechen) • Melodisierung (Besonderheiten der Endphasenmelodie in rhythmischen Gruppen)	
6.14.2	Linguistik (ca. 60 Stunden)	
Die Schüler erkennen den Zusammenhang von Kommunikation-Sprache-Sprechen und der Bedeutung der Linguistik für die Logopäden.	Kommunikationsmodell Definition Sprache - Zeichenfunktion der Sprache - Normbegriff in Bezug auf Hochsprache, Umgangssprache, Dialekt Modalitäten Sprechen – Verstehen, Schreiben – Lesen Definition Linguistik Teilgebiete (Morphologie, Lexikologie, Syntax, Semantik, Textlinguistik, Stilistik, Neuro- bzw. Psycholinguistik) - Morphologie • Definition Morphem • Morphemanalyse • Wortarten und deren Eigenschaften und Funktionen • Wortbildung (Komposition, Derivation, Kürzungen)	
Sie haben Kenntnisse über den Gegenstand der Linguistik und deren Teilgebiete.		anhand einer Textanalyse können die Teilgebiete und ihr Gegenstand erarbeitet werden
Sie besitzen vertiefte Kenntnisse über die Struktur des Wortes und die Fähigkeit zur Wortanalyse.	- Lexikologie/Wortschatz • passiver Wortschatz • aktiver Wortschatz • Wortfamilien • Wortfelder • Synonyme, Homonyme • Antonyme • Wortschatzentwicklung	Wortartenklassifikationen orientiert sich an der Schulgrammatik dieser Lernabschnitt soll einen intensiven Übungsteil zur Morphem- und Wortartenanalyse einschließen
Sie haben Kenntnisse über den Wortschatz einer Sprache und dessen Gebrauch.	- Syntax • Valenz des Verbs • Satzglieder (Prädikat, Subjekt, Ergänzungen, adverbiale Ergänzungen) • Satzgliedteile • Satzbaupläne (Parataxe, Hypotaxe, Funktion und Einteilung der Nebensätze)	Verbindung zur Kindersprache herstellen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen vertiefte Kenntnisse über die Struktur des Satzes als nächst größere Einheit und die Befähigung zur Satzanalyse.	- Grammatik-Konzeptionen • Schulgrammatik • generative Grammatik (nach Chomsky) • Valenzgrammatik	Satzgliedanalyse orientiert sich an der Schulgrammatik
Sie kennen die verschiedenen Grammatik-Konzeptionen.		dieser Lernabschnitt sollte einen intensiven Übungsteil zur Bestimmung der Satzglieder und der Nebensätze einschließen
Sie haben Kenntnisse über die Bedeutung des Wortes, des Satzes.	- Semantik • Wortsemantik • Semanalyse • Polysemie • Satzsemantik	Verbindung zur Kindersprache und Entwicklung der Begrifflichkeit herstellen
Sie erkennen die Ganzheitlichkeit der Sprache.	- Textlinguistik/Stilistik/Pragmatik • Textsorten und deren Verwendung	
Sie haben gefestigte und erweiterte Kenntnisse über die Ontogenese der Sprache.	Sprachentwicklung des Kindes - präverbale Phase • Schreiphase • 1. und 2. Lallphase - verbale Phase • Einwortsätze • Mehrwortsätze • Grammatikentwicklung	In Abstimmung mit dem Lerngebiet Logopädie/Kindersprache können die Schwerpunkte genau definiert werden.
Sie besitzen Kenntnisse über die Modellvorstellungen der Sprachproduktion.	Sprachverarbeitungsmodelle - serielle Modelle • Logogen-Modell • Sprachverarbeitung nach Levelt - Netzwerkmodelle	Da die Neuroanatomie zu diesem Zeitpunkt noch nicht vorausgesetzt werden kann, werden die speziellen Prozesse im Gehirn nur angerissen.
Sie haben erste Kenntnisse über die gestörte Sprache und entwickeln die Fähigkeit zur linguistischen Analyse gestörter Sprache.	Formen der gestörten Sprache auf allen linguistischen Ebenen und in allen Modalitäten - Paraphasien - Dysgrammatismus - Agrammatismus - Paragrammatismus	Hier geht es noch nicht um störungsspezifische Symptome, sondern um Einsicht in die Grundlagen der Patholinguistik. phonologische Paraphasien werden hier ausgeklammert.
Sie besitzen reaktivierte Kenntnisse und Überblick über Aufbau und Funktion der Schrift.	Hypothesen zum Schrift-Lautsprach-Verhältnis - Dependenz-Hypothese - Autonomie-Hypothese - Misch- oder Mehrwegmodell	Begriffe: Graphem, Phonem, Buchstabe
Sie haben Kenntnisse über Annahmen zum Verhältnis von Schrift- und Lautsprache.	Phonem-Graphem-Korrespondenzregeln	Hervorheben der großen Bedeutung für die Orthographie; Komplexität der Korrespondenzregeln an Beispielen aufzeigen; Diskutieren der Neuregelung der Rechtschreibung (Vor- und Nachteile)
Sie besitzen Kenntnisse über den physiologischen Erwerb von Einsichten und Fertigkeiten bei der Rechtschreib- und Leseentwicklung, insbesondere das phonologische und morphematische Prinzip beim Schriftspracherwerb.	Voraussetzungen zum Schriftspracherwerb	Eingehen auf Beherrschung der Muttersprache, Motivation sowie das allgemeine Niveau der kognitiven und sozialen Entwicklung; Einbeziehen von eigenen Erfahrungen der Schüler

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
	Modelle des Rechtschreiberwerbs - Wiener Modell der Verschriftungsstufen - Entwicklungsphasen nach Scheerer-Neumann - Modell des „developmental spelling“ nach Brown - Lese-Stufenmodell nach Scheerer-Neumann - genetisches Vier-Phasenmodell der Worterkennung nach Gibson usw.	Vorstellen und Diskutieren ausgewählter neuerer Lese- und Rechtschreibmodelle; Abstimmen mit den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie, Phoniatrie, Pädagogik und Logopädie; Aufzeigen charakteristischer Fehlerarten in den jeweiligen Stufen; Kenntnisse der Symptomatik der LRS reaktivieren und Abgrenzen der entwicklungsbedingten Fehler, z. B. von leichtgradigen Schreib- und Lesefehlern der LRS; Arbeit mit Fallbeispielen (Fehleranalysen)

6.15 Psychologie und klinische Psychologie (150 Stunden)

Lernabschnitte	Zeitrichtwerte
1 Grundlagen der Psychologie	ca. 6 Stunden
2 Entwicklungspsychologie	ca. 18 Stunden
3 Wahrnehmungspsychologie	ca. 20 Stunden
4 Lernpsychologie	ca. 10 Stunden
5 Sozialpsychologie	ca. 6 Stunden
6 Psychologie der Sprache	ca. 20 Stunden
7 Einführung in die Psychodiagnostik	ca. 10 Stunden
8 Spezielle Psychometrie bei Hör-, Stimm- und Sprachstörungen	ca. 10 Stunden
9 Einführung in die Verhaltenstherapie und andere psychotherapeutische Verfahren	ca. 50 Stunden

6.15.1 Grundlagen der Psychologie (ca. 6 Stunden)

Die Schüler haben Kenntnisse über Arbeitsfelder, Ziele und Methoden der Psychologie.	- Gegenstand, Aufgaben und Ziele der Psychologie - wissenschaftliche Psychologie v. v. Alltagspsychologie - Disziplinen - Methoden • Beobachtung • Befragung • Tests • Experiment - Datenerhebung und Interpretation - Bedeutung der Psychologie für die logopädische Tätigkeit	Abgrenzung zu anderen sozialwissenschaftlichen Disziplinen
--	--	--

6.15.2 Entwicklungspsychologie (ca. 18 Stunden)

Die Schüler besitzen Kenntnisse über den allgemeinen Entwicklungsverlauf des Menschen.	- Gegenstand, Aufgaben und Methoden der Entwicklungspsychologie - Bedingungen der menschlichen Entwicklung unter Berücksichtigung von Vererbung, Umwelt, Selbststeuerung - Modelle der psychosozialen Entwicklung und der entsprechenden Persönlichkeitskonzepte	Reaktivieren von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Pädiatrie und Neuropädiatrie; Einbeziehen der eigenen Sozialisation
--	--	--

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben einen Überblick über die Entwicklungsstadien des Menschen.	- Entwicklungsstadien • Säuglingszeit • Kindheit • Adoleszenz • Erwachsenenalter	Schwerpunkt sollte die Entwicklung im Kindesalter unter Berücksichtigung der kognitiven Entwicklung sein
Sie setzen sich mit kritischen Lebenssituationen auseinander.	- Umgang mit Sterben und Tod - Störungsfaktoren der menschlichen Entwicklung • genetische • soziale • psychische - Möglichkeiten der psychologischen Intervention	Verbindung zur logopädischen Arbeit

6.15.3 Wahrnehmungspsychologie (ca. 20 Stunden)

Die Schüler verfügen über Kenntnisse der Wahrnehmungspsychologie	- Grundlagen der Wahrnehmungspsychologie • Wahrnehmungskette • Organisation der Wahrnehmung • Wahrnehmungsgesetze • Wahrnehmung von Raum, Zeit und Bewegung	Einbeziehen von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Anatomie und Physiologie; Darstellung der Aufnahme, Verarbeitung und Integration von Reizen mittels Fallbeispielen
Sie besitzen reaktivierte Wissen über das sensorische System und Kenntnisse bezüglich Wesen und Ablauf der Informationsgewinnung.		
Sie haben Kenntnisse über Ursachen, Formen und Auswirkungen von Wahrnehmungsstörungen.	- Wahrnehmungsstörungen und -täuschungen • Ursachen • Einteilung (Formen der Wahrnehmungsstörungen in der kindlichen Entwicklung; Gliederung nach den Sinnesmodalitäten)	Problem Wahrnehmungsstörung und Intelligenz; Begriffe Teilleistungsstörung/ Integrationsstörung abgrenzen; besonders auf Auswirkungen von Wahrnehmungsdefiziten bezüglich des Sprach-, Laut- und Schriftspracherwerbs eingehen
Sie können Zusammenhänge erkennen und verstehen.	• Folgen der Wahrnehmungsstörungen in den verschiedenen Bereichen	

6.15.4 Lernpsychologie (ca. 10 Stunden)

Die Schüler verfügen über Grundkenntnisse.	- Grundlagen der Lern- und Gedächtnispsychologie - Lernarten und Lerngesetze • klassisches Konditionieren • operantes Konditionieren - Gedächtnis • Gedächtnisarten • Erinnern und Vergessen • Gedächtnis und verbales Lernen - Gedächtnisstörungen	Abstimmung mit dem Lerngebiet Pädagogik Beispiele aus der Logopädie einbeziehen
--	---	--

6.15.5 Sozialpsychologie (ca. 6 Stunden)

Die Schüler verfügen über Grundkenntnisse.	- Sozialverhalten und Auswirkungen auf sozialpsychologische Entwicklungsdeterminanten (Vorschuleinrichtungen, Schule, Familie)	Abstimmung mit den Lerngebieten Pädagogik, Sonderpädagogik und Soziologie
--	--	---

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie sind befähigt zum Umgang mit sozial auffälligen Patienten.	- Störungen im Sozialverhalten (z. B. Umgang mit Aggression, psychosoziale Deprivation) - Personenwahrnehmung - Individuum und Gruppe - Gruppeneinflüsse und Gruppendruck	eigene Erfahrungen der Schüler aus den Praktika nutzen
6.15.6 Psychologie der Sprache (ca. 20 Stunden)		
Die Schüler können die Einzigartigkeit der menschlichen Sprache erfassen und kritisch bewerten.	- Definition Sprache - sprachähnliche Phänomene aus dem Tierreich (Sprache der Bienen, Wale, Delphine, Papageien)	Einführung in die Thematik; sprachliche Erscheinungen im Tierreich
Sie verfügen über aktivierte und vertiefte Kenntnisse zur Sprachpsychologie.	- Kommunikation bei Affen - Sprachlernfähigkeit der Affen	
Sie haben Kenntnisse über die Entstehung von Sprache.	Sprachursprungsforschung	Problematic „Kaspar Hauser“ und Wolfskinder sowie experimentelle Überlegungen zur Erbe-Umwelt-Frage vorstellen und diskutieren
Sie können kritisch zur Erbe-Umwelt-Frage bei Spracherwerb diskutieren und die Bedeutung der sprachlichen Anregung erkennen.	- Phylognese-Ontogenese (Urgermanisch-Indogermanisch-Steinzeitsprache-Ursprache) - Isolierung von Kindern	
Sie besitzen gefestigtes und erweitertes Wissen zur Sprachphysiologie, besonders über die kortikalen Aspekte der Sprachverarbeitung und -produktion.	Psychophysiologie der Sprache - Sprechapparat - Gehör - Gehirn (Hemisphärendominanz, evozierte Potentiale)	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Phoniatrie, Audiologie und Pädaudiologie sowie Logopädie; Vorstellen verschiedener EEG-Studien zu den rezeptiven und expressiven Sprachleistungen
Sie erfassen den Zusammenhang von Sprache und Denken.	Modelle zur Erklärung der Beziehung Sprache-Denken	Eingehen auf das Problem von Differenzen in verschiedenen Sprach-Welten;
Sie besitzen die Fähigkeit zur kritischen Diskussion der unterschiedlichen Ansätze.	- Whorfsche Hypothese - Sapir Hypothese - Sprachfunktionen	Erarbeiten der verschiedenen Sprachfunktionen
Sie haben Einblick in die Funktion paralinguistischer Phänomene innerhalb der Sprache.	paralinguistische Phänomene - Lachen-Weinen - Gähnen - Fluchen - Lombard-Effekt und Lee-Effekt - Auswirkungen auf Sprechtempo, Pausengestaltung und Intonation	Abstimmen mit den Lerngebieten Phonetik/Linguistik und Logopädie; Vorstellen von Curare-Experimenten; Gruppenarbeit
Sie kennen verschiedene Ansätze zur Erklärung des Spracherwerbs sowie psychologischer und neuropsychologischer Modelle zur Entstehung von Sprachentwicklungsstörungen.	Spracherwerb - psycholinguistische Theorien zum Spracherwerb - Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung (psychische, soziale, organische) - Ursachen für den individuellen Sprachentwicklungsverlauf	Darstellung der Spracherwerbstheorien; Diskussion möglicher Einflussfaktoren auf die Sprachentwicklung; Merkmale der Motherese; Eingehen auf das Entstehen individueller Unterschiede in der Sprachentwicklung
Sie haben Verständnis für das Auftreten individueller Unterschiede in der Sprachentwicklung.	- Verlauf des Spracherwerbs unter besonderen Entwicklungsbedingungen (genetische Syndrome usw.)	(soziale Interaktion, soziokulturelle Einflüsse usw.); Arbeit mit Fallbeispielen; Abstimmung mit den Lerngebieten

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
		Phonetik/Linguistik, Phoniatrie, Logopädie sowie Pädiatrie und Neuropädiatrie
Sie erkennen den Zusammenhang von Sprache und Milieu.	Gruppenzugehörigkeit und Sprache - Frauensprache - Jugendsprache - Gaunersprache Werbung	Erarbeiten der Zusammenhänge der jeweiligen spezifischen Sprachstile und ihrer Besonderheiten
6.15.7 Einführung in die Psychodiagnostik (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler haben Einblick in das Aufgabengebiet und die Funktion der Psychodiagnostik.	- Aufgabengebiet - Funktionen	Einführung in die Thematik
Sie verfügen über Kenntnisse zu einzelnen diagnostischen Verfahren sowie zu Grundlagen der Testgütekriterien.	diagnostische Verfahren - Interview • strukturiert • semistrukturiert - Exploration - Verhaltensbeobachtung	Vorstellung der diagnostischen Verfahren, Zielgruppen und Indikationen; Aufzeigen von Inhalten, Methodik und Einflussfaktoren sowie Interpretation der Ergebnisse und Grenzen gängiger Konzepte
Sie besitzen die Fähigkeit zur Verwertung psychologischer Befunde in der logopädischen Praxis und können Zusammenhänge erkennen.	Testgütekriterien ausgewählte Tests des Kinder-, Jugend- und Erwachsenenalters (allgemeine Entwicklungs-, Intelligenz-, Leistungs-, Persönlichkeitstests)	Demonstration; Arbeit mit Fallbeispielen
6.15.8 Spezielle Psychometrie bei Hör-, Stimm- und Sprachstörungen (ca. 10 Stunden)		
Die Schüler besitzen einen Überblick über die Einsatzbereiche und Einsicht in die Notwendigkeit psychometrischer Untersuchungen.	entwicklungsdiagnostische Untersuchungen - Indikation	Eingehen auf Schuleingangsuntersuchungen, Diagnostik der LRS usw. Vorstellung und Demonstration ausgewählter Testverfahren und -materialien;
Sie kennen zugrunde liegende Konzepte und Modelle ausgewählter Untersuchungsverfahren.	spezielle Psychometrie - Sprachdiagnostik (formal-analytische, sprachinhaltsanalytische Verfahren) - neuropsychologische Verfahren zur Bewertung von Teilleistungsstörungen - Interpretation von Testergebnissen	Interpretation von Testbefunden unter Einbeziehung von Fallbeispielen
6.15.9 Einführung in die Verhaltenstherapie und andere psychotherapeutische Verfahren (ca. 50 Stunden)		
Die Schüler haben einen Überblick über verschiedene therapeutische Ansätze.	Paradigmen der klinischen Psychologie - Physiologie - Psychoanalyse - Behaviorismus - kognitive Ansätze - humanistische Ansätze	Beschreiben des Störungsverständnisses der einzelnen Ansätze und Ableitung der Entwicklung der Therapieansätze

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie besitzen Grundkenntnisse über psychotherapeutische Verfahren und die Fähigkeit zur Differenzierung dieser in Bezug auf ihre Indikation.	psychotherapeutische Therapieformen - verhaltenstherapeutische Vorgehensweisen • lerntheoretische Grundlagen (z. B. Konditionierung, Modell lernen) • systematische Desensibilisierung Selbstsicherheitstraining usw.	Vorstellung verschiedener psychotherapeutischer Verfahren; genaueres Eingehen auf für die Logopädie praxisrelevante Techniken; Herausarbeiten von Berührungspunkten Psychologie-Logopädie; Aufzeigen von Unterschieden zur logopädischen Therapie; Abstimmung mit den Lerngebieten Neurologie und Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie sowie Logopädie, vgl. auch 6.15.4
Sie sind sensibilisiert für eine interdisziplinäre Zusammenarbeit und können die Möglichkeiten und Grenzen der Logopädie erkennen.	weitere psychotherapeutische Verfahren - Psychoanalyse - klientenzentrierte Gesprächstherapie - Musiktherapie - Soziotherapie - Spieltherapie - Rollenspiel - Entspannungstechniken usw.	
Sie haben einen Überblick über Möglichkeiten der psychologischen Intervention bei ausgewählten Störungsbildern.	psychologische Intervention bei ausgewählten Störungsbildern - Psychosen • neurotische Belastungs- und somatoforme Störungen - psychosomatische Störungen - Persönlichkeits- und Verhaltensstörungen - Suchterkrankungen - Aufmerksamkeitsdefizit- und Aufmerksamkeitsdefizit-Hyperaktivitätsstörung - Mutismus, elektiver Mutismus - psychogene Dys- und Aphonie - psychische Störungen bei organisch bedingten Erkrankungen • angeborene und erworbene Hirnschäden • Hörbehinderungen • Mehrfachschädigungen • Apoplexie • maligne Erkrankungen	Darstellen von Interventions-techniken der Verhaltens- und systemischen Therapie sowie weiterer psychotherapeutischer Verfahren bei den wichtigsten berufsrelevanten Störungsbildern; Vorstellen von Therapie-, Beratungs- und Selbsthilfemöglichkeiten unter Berücksichtigung von Störungsform und sozialer Lage des Patienten; Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Neurologie und Psychiatrie, Kinder- und Jugendpsychiatrie, Phoniatrie, Logopädie und Soziologie

6.16 Soziologie (40 Stunden)

Lernabschnitte

- 1 Einführung in das Lerngebiet Soziologie
- 2 Grundbegriffe der Soziologie
- 3 Sozialisation
- 4 Familiensoziologie
- 5 Medizinische Soziologie
- 5.1 Gesundheit und Krankheit
- 5.2 Soziologie des kranken Menschen
- 5.3 Die Beziehung zwischen Patient und Logopäden
- 5.4 Rehabilitation

Zeitrichtwerte

- ca. 1 Stunde
- ca. 2 Stunden
- ca. 3 Stunden
- ca. 4 Stunden
- ca. 30 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.16.1 Einführung in das Lerngebiet Soziologie (ca. 1 Stunde)		
Die Schüler haben einen Überblick über das Aufgabengebiet der Soziologie. Sie besitzen Kenntnisse über die Soziologie als Wissenschaft und deren Abgrenzung zu anderen Sozialwissenschaften. Sie verfügen über Grundlagen.	- Definition und Gegenstand der Soziologie - Abgrenzung zu anderen Sozialwissenschaften - Unterschiede zwischen Alltags- und wissenschaftlicher Soziologie - sozialwissenschaftliche Methoden	Unterschiede und Gemeinsamkeiten der verschiedenen Sozialwissenschaften verdeutlichen; Methoden der Sozialwissenschaften im Vergleich und in Abstimmung mit dem Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie
6.16.2 Grundbegriffe der Soziologie (ca. 2 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse sozialwissenschaftlicher Begriffe und ihre wechselseitige Verbundenheit.	- Norm und Sanktion - Institution und Organisation - soziale Rollen und Rollenkonflikte - soziale Schichten - Sozialschicht und Krankheit	Einführung in die wesentlichen Grundbegriffe der allgemeinen Soziologie; Aufzeigen und Diskussion der berufsbezogenen Bedeutung; Reflexion von Rollenerwartungen; Untersuchungsergebnisse zu Sterberaten nach Geschlecht und Sozialschicht darstellen und diskutieren; Abstimmung mit den Lerngebieten Pädagogik, Psychologie und klinische Psychologie
6.16.3 Sozialisation (ca. 3 Stunden)		
Die Schüler verfügen über Kenntnisse der Sozialisationsvorgänge und -wirkungen.	- Inhalte der Sozialisation - Phasen der Sozialisation - Sozialisationsdefizite - schichtspezifische Sozialisation	Einbeziehen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie sowie Pädagogik; Verdeutlichen der Wechselbeziehung zwischen Sozialisation, Enkulturation und Personalisation
6.16.4 Familiensoziologie (ca. 4 Stunden)		
Die Schüler haben Kenntnisse über Familie als Sozialinstanz.	- die Familie in der Industriegesellschaft - der Phasenverlauf der Familie - Funktionen der Familie	Auseinandersetzung mit aktuellen Wandlungstendenzen, wie z. B. Vielfalt der Familienformen, Liberalisierung und Demokratisierung im familiären Binnenverhältnis; Arbeit mit Fallbeispielen (siehe Tabellen Statistisches Jahrbuch)

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.16.5	Medizinische Soziologie (ca. 30 Stunden)	
6.16.5.1	Gesundheit und Krankheit	
Die Schüler besitzen Überblick und Wissen über Grundaussagen zur Erklärung von Gesundheit und Krankheit.	- Gesundheit und Krankheit - Erklärungsmodelle von Krankheit und Kranksein (WHO Gesundheitsbegriff, salutogenes Gesundheitsmodell nach Antonovsky usw.)	Darstellung des aktuellen Gesundheitszustandes der Bevölkerung; Vergleichen unterschiedlicher Definitionen und Diskutieren ihrer Auswirkungen, Voraussetzung ist die kritische Reflexion des WHO-Gesundheitsbegriffs
6.16.5.2	Soziologie des kranken Menschen	
Die Schüler verfügen über reaktivierte und vertiefte Kenntnisse.	- Stadien des Hilfesuchens - Rechte und Pflichten des Kranken - die Rolle des Patienten	Reaktivieren und Vertiefen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Logopädie, Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde, Psychologie und klinische Psychologie, Pädiatrie und Neuropädiatrie, Pädagogik, Sonderpädagogik
Sie haben Einblick in das Rollenverhalten des Patienten und der Angehörigen.	- Krankheitsgewinn - die Rolle der Angehörigen	Berichte von Schülern über Eigen- und Fremderfahrungen; Diskussion zu verschiedenen Ansichten über die Patientenrolle; kritische Auseinandersetzung unter anderem mit dem Krankenrollenkonzept von Parsons
6.16.5.3	Die Beziehung zwischen Patient und Logopäden	
Die Schüler besitzen Kenntnisse über das Beziehungsgeschehen zwischen Logopäde und Patienten.	- die Rolle des Therapeuten - Interaktionsformen und -probleme - Asymmetrie der Beziehung - Patientenführung und Compliance - partnerzentrierte Gesprächsführung	Vermittlung der interaktiven Schlüsselrolle des Logopäden und Bewusstmachen deren Bedeutung für die erfolgreiche Mitarbeit des Patienten an seiner Gesundung; Einbeziehen von Schülererfahrungen; Berücksichtigung vorhandenen Wissens besonders aus den Lerngebieten Logopädie, Psychologie und klinische Psychologie sowie Sprecherziehung
6.16.5.4	Rehabilitation	
Die Schüler besitzen einen Überblick über die Rehabilitation.	- Definition von Rehabilitation - Behinderung nach WHO-Klassifikation - Arten der Behinderung - Integration Behinderter - Bereiche der Rehabilitation - rechtliche Grundlagen - Rehabilitation Sprach-, Sprech-, Stimm- und Hörgestörter	Reaktivieren und Vertiefen von Kenntnissen aus den Lerngebieten Sonderpädagogik, Phoniatrie, Logopädie, Berufs-, Gesetzes- und Staatsbürgerkunde; Einbeziehen von Schülererfahrungen; Arbeit mit Fallbeispielen
6.17	Pädagogik (60 Stunden)	
Die Schüler haben Kenntnisse über die Pädagogik als Wissenschaft.	- Begriffsbestimmung - Gegenstand der Pädagogik - Aufgaben und Methoden - Disziplinen der Pädagogik	Einführung in das Lerngebiet; eigene Erfahrungen der Schüler mit pädagogischen Prozessen einbeziehen; Berücksichtigung logopädischer Aufgabenfelder

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Verständnis für den Zusammenhang von Bildung und Erziehung.	- Inhalte der Erziehung - Inhalte der Bildung - Wechselbeziehung zwischen Bildung und Erziehung	
Sie können die Ziele und Inhalte der Pädagogik in Bildung und Erziehung abstimmen.		
Sie besitzen Kenntnisse über anthropologische und andere Grundannahmen zur Erziehbarkeit, Erziehbedürftigkeit und Lernfähigkeit.	Grundannahmen - naturwissenschaftliche, geistes- und sozialwissenschaftliche Erkenntnisse - Folgen fehlender und unzulänglicher Erziehung	Abstimmung mit den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie, Logopädie sowie Soziologie
Sie sind befähigt zum Erkennen von Möglichkeiten und Grenzen in der Erziehung.	- Bedingungen der Erziehung - Auffassungen von Erb-, Milieu- und Interaktionstheoretikern - Rolle der Selbststeuerung	
Sie haben Kenntnisse über Grundlagen der Erziehung.	Inhalte der Erziehung - Erziehung als soziale Interaktion und Kommunikation - Autorität und Erziehung - Erziehung als Hilfe zur Kulturation, Sozialisation und Personalisation - das pädagogische Verhältnis – (Nohl) pädagogischer Bezug	Einbeziehung von Kenntnissen aus den Lerngebieten Soziologie sowie Psychologie und klinische Psychologie; Einfluss der Erziehung auf die Entwicklung und die Sprache herausarbeiten
Sie besitzen einen Überblick über Erziehungsziele.	Erziehungsziele - Erziehungsziele gestern und heute - „Erziehungsziel“ als wesentliches Merkmal der Erziehung - Funktion und Probleme von Erziehungszielen - Erziehungsziel „Mündigkeit“	
Sie haben Kenntnisse über	Erziehungsstile und -verhalten	kritische Auseinandersetzung mit den verschiedenen Theorien; Erfahrungsberichte der Schüler
- Erziehungsstile und –verhalten;	- Erziehungsstile - Bedeutung der Beziehung in der Erziehung - Auswirkungen und Ursachen von Erziehungsverhalten	
- Erziehungsmaßnahmen.	Erziehungsmaßnahmen - Begriffsbestimmung - unterstützende und gegenwirkende Erziehungsmaßnahmen - Erziehungsmaßnahme „Spiel“ und seine besondere Bedeutung für die Erziehung	Diskussion und kritische Auseinandersetzung; Fallbeispiele; Rollenspiele therapeutische Einsatzmöglichkeiten des Spiels
Sie sind zur richtigen Auswahl therapieunterstützender Erziehungsmaßnahmen befähigt.	therapieunterstützende Erziehungsmaßnahmen - Lob und Tadel - alternative Erziehungsmaßnahmen	Arbeit mit Fallbeispielen; Rollenspiele

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Kenntnisse über Erziehung in verschiedenen pädagogischen Einrichtungen.	- Erziehung in der Familie • Funktion und Probleme familiärer Erziehung - Kindertagesstätten als familienergänzende Einrichtungen • Aufgaben und Probleme der Kindertagesstätten-Arbeit - familienersetzende Einrichtung Heim • Aufgaben, Formen und Probleme der Heimerziehung - schulischer Bereich	Einbeziehung von Kenntnissen aus den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie sowie Soziologie
Sie sind fähig, verschiedene Lerntheorien zu beschreiben und zu differenzieren.	Lerntheorien - klassisches Konditionieren - operantes Konditionieren - sozialkognitive Lerntheorie - Lernen durch Einsicht	Bezug zum Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie (z. B. Gedächtnis, Vergessen, Behalten); Bedeutung lebenslangen Lernens
Sie sind zum Formulieren geeigneter Lernziele befähigt.	Lernziele - Definition und Aufgaben - Stunden-/Therapieziele und Feinziele für die logopädische Therapie bei unterschiedlichen Störungen	Arbeit mit Fallbeispielen; Erarbeiten von Therapiezielen; Gruppenarbeit
Sie erkennen grundlegende pädagogische Prinzipien.	Methodik/Didaktik - pädagogische Prinzipien - spezifisch logopädische Arbeit: z. B. Lernprozesse auch bei Erwachsenen	Bedeutung der Eigenverantwortung; Einbeziehung von Kenntnissen aus dem Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie

6.18 Sonderpädagogik (80 Stunden)

Lernabschnitte

- 1 Grundlagen
- 2 Hörgeschädigtenpädagogik
- 3

Zeitrichtwerte

ca. 40 Stunden
ca. 40 Stunden

6.18.1 Grundlagen (ca. 40 Stunden)

Die Schüler besitzen die Fähigkeit zur Abgrenzung und Zielbestimmung der Sonderpädagogik.	- Begriffsklärung (Heil-, Sonder- und Rehapädagogik) - Abstufung der Beeinträchtigungen - Begriff „Behinderung“ - Ursachen von Behinderungen - allgemeine und spezielle Ziele der Sonderpädagogik	Für und Wider des Begriffs diskutieren
Sie haben Kenntnisse über Behinderungsarten.	Behinderungsarten - allgemeiner Überblick mit Einteilungsversuchen	Einbeziehen von Wissen aus den Lerngebieten Logopädie, Pädiatrie, Neuropädiatrie und Phoniatrie
Sie besitzen reaktivierte und vertiefte Kenntnisse über Ursachen und sonderpädagogische Aufgaben.	- Kurzdarstellung der Behinderungsarten (Lernbehinderte, Verhaltensbehinderte, Sehbehinderte, Blinde, Schwerhörige, Gehörlose, Sprachbehinderte, Mehrfachbehinderte)	Verweis auf das Lerngebiet Sonderpädagogik

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie haben Kenntnisse über die Besonderheit und Vielfalt geistiger Behinderungen.	- geistige Behinderungen (Ursachen, Grade, Kombinationen, sonderpädagogische Aufgaben)	exemplarisch vertieft; Kenntnisse aus dem Lerngebiet Kinder- und Jugendpsychiatrie einbeziehen
Sie besitzen reaktivierte und vertiefte Kenntnisse über Verhaltensstörungen.	Verhaltensstörungen - Definitionen - Störungsbereiche - Verhaltensstörung als Abweichung von der Norm - Erscheinungsformen von Verhaltensstörungen - Ursachen von Verhaltensstörungen - Probleme Verhaltensgestörter - Maßnahmen zur Vorbeugung und Behandlung von Verhaltensstörungen - Maßnahmen zur Gesunderhaltung des Therapeuten	Bezug zum Lerngebiet Psychologie und klinische Psychologie, Soziologie sowie Kinder- und Jugendpsychiatrie allgemeiner Überblick; Bezüge zu den Lerngebieten Psychologie und klinische Psychologie, Logopädie, Soziologie; Reaktivierung und Vertiefung: logopädische Arbeit mit dem verhaltensgestörten Kind
Sie haben Kenntnisse über - Behinderung als Lebenserschwerung;	- Erschwerung im unmittelbaren Lebensvollzug - soziale Folgeerscheinungen als Lebenserschwerung - Notwendigkeit besonderer Erziehungs- und Fördermaßnahmen - Besonderheiten im alltäglichen Leben	
- die Aufgabenfelder der Sonderpädagogik sowie Möglichkeiten und Grenzen der Integration.	Aufgabenfelder der Sonderpädagogik - Prävention - Früherkennung und Frühförderung - Förderschulen - sonderpädagogische Berufsausbildung - Integration von Behinderten - Wohnformen für Behinderte	Überblick geben; Arbeit mit Fallbeispielen (siehe einzelne Störungsbereiche, z. B. Gehör und Sprache)
Sie besitzen einen Einblick in ausgewählte sonderpädagogische Diagnose- und Therapieverfahren sowie weitere sonderpädagogische Interventionsmöglichkeiten.	- sonderpädagogische Aspekte der Diagnostik und Therapie	Auswahl im Ermessen der Lehrkraft (z. B. LRS); Erarbeiten und Auswerten von Fallbeispielen verschiedener Behinderungen in den Bereichen von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Hörstörungen
Sie besitzen Fähigkeiten und Fertigkeiten im Umgang mit weiteren Behinderungen und besonderen Störungen.	- logopädische Arbeit mit dem verhaltensgestörten Kind - Umgang mit Patienten mit infauster Prognose	Arbeit mit ausgewählten Beispielen: z. B. Tumorpatienten; Problem Sterben/Tod; Bezüge zur Psychologie und klinischen Psychologie sowie Soziologie herstellen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.18.2	Hörgeschädigtenpädagogik (ca. 40 Stunden)	
Die Schüler haben Kenntnisse über die besonderen Aufgaben der Hörgeschädigtenpädagogik.	Gegenstand und Ziele der Hörgeschädigtenpädagogik	Gemeinsamkeiten und Abgrenzung zu den anderen sonderpädagogischen Fördergebieten
Sie besitzen reaktivierte Kenntnisse über die wichtigsten Hörschäden und deren Ursachen.	Hörschäden im Kindes- und Jugendalter - Einteilung - Ursachen - Häufigkeit - Anzeichen von Hörstörungen und Maßnahmen - Hörschäden in Verbindung mit anderen Behinderungen	Wissen aus den Lerngebieten Anatomie und Physiologie, Hals-, Nasen-, Ohrenheilkunde, Phoniatrie, Audiologie und Pädaudiologie sowie Logopädie einbeziehen
Sie erkennen die Auswirkungen von Hörschädigungen im psychosozialen Bereich	Beschreibung der Population - Schwerhörigkeit (Gradeinteilung) - Gehörlosigkeit - Cochlea-Implantat-Träger	Arbeit mit Fallbeispielen
	Folgen von Hörschädigungen	Darstellung ausgewählter Syndrome
Sie haben Kenntnisse über - Förderschwerpunkte, die für den Logopäden bedeutsam sind; - die Einrichtungen für Hörgeschädigte.	sonderpädagogische Konzepte bei Hörstörungen Förderschwerpunkte aus den Bereichen Hören, Sprechen, Kommunikation	Exkursionen in sonderpädagogische Einrichtungen; Herausarbeiten der spezifischen Zielstellungen und des methodischen Vorgehens der verschiedenen Einrichtungen
Sie sind sensibilisiert für eine notwendige interdisziplinäre Zusammenarbeit.	Institutionen und Maßnahmen für die Bildung und Erziehung Hörgeschädigter - pädaudiologische Beratungsstellen - Früherziehung - Vorschulerziehung - Schulen für Schwerhörige und Gehörlose - Berufsausbildung	Demonstrationen; Abstimmung mit den Lerngebieten Audiologie und Pädaudiologie, Elektro- und Hörgeräteakustik
Sie sind befähigt zur Therapiegestaltung für den speziellen Förderbereich.	Hilfsmittel für Hörgeschädigte - manuelle Hilfen • Handzeichensysteme (GMS, PMS) • Mund-Hand-System - apparative Hilfen • Hörgeräte • Cochlea-Implantat therapeutische Fragestellungen - Hörerziehung - Entwicklung von Sprechfertigkeiten (therapeutische Methoden) - rhythmisch-musikalische Erziehung	Verbindung zur Logopädie herstellen; musiktherapeutische Möglichkeiten aufzeigen

6.19 Stimmbildung (100 Stunden)

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Die Schüler verfügen über Kenntnisse zu den Grundlagen der Stimmfunktion.	anatomisch-physiologische Grundlagen	theoretische Einführung; Abstimmung mit den Lerngebieten Phoniatrie, Anatomie und Physiologie und Logopädie;
Sie haben Kenntnisse über die Stimmhygiene der reifen und der in Entwicklung befindlichen Stimme und sind in der Lage, stimmhygienisches Verhalten anzueignen und umzusetzen.	Stimmhygiene (allgemeine und spezielle Maßnahmen)	Erarbeiten stimmhygienischer Verhaltensmaßnahmen; vgl. auch Lerngebiet Logopädie
Sie erkennen die Zusammenhänge von Körper, Atmung und Stimme sowie Stimmung und sind dazu sensibilisiert.	- die körperlichen Voraussetzungen für die Stimmbildung - erste Körper-, Atem- und Stimmerfahrungen - Stimme und deren psychophysische Einflussfaktoren (Körperhaltung, Tonus, Bewegung, Atmung, Persönlichkeit, Intention, Lebens- und Sprechsituation)	praktische Übungen in Einzel- und Partnerarbeit; Vorstellen und Selbsterfahrungen mit verschiedenen Entspannungsmethoden, z. B. Autogenes Training und Progressive Muskelrelaxation nach Schultz (im Ermessen der Lehrkraft); die Schüler lernen, die Spannungsverhältnisse des Körpers bewusst zu kontrollieren und zu verändern bis hin zur eutonon Spannung
Sie verfügen über Kenntnisse der verschiedenen Atemtypen.	- Physiologie der Atmung (Atemablauf; Atemformen: thorakale, abdominale, kostoabdominale, Flanken-, Klavikularatmung; Atemvolumina)	Übungen zur Ruhe- und Stimmatmung; Training des Eigen- und Fremdhörens; Selbst- und Fremdwahrnehmung
Sie erfassen insbesondere die Bedeutung der kostoabdominalen Atmung für die physiologische Stimmgebung.		
Sie beherrschen die Regulierung des Ausatemstroms im Rahmen der Stimmgebung.	- Begriffe: Atem-, Tonstütze, atemrhythmisch angepasste Phonation; Abspannen als Moment der reflektorischen Atemergänzung; Methoden der verlängerten Atem- und Tonstütze	Übungen zum Ansatz nach Middendorf sowie zum Ansatz nach Coblenzer und Muhar; Selbstwahrnehmung; Fremdbeobachtung
Sie kennen die physiologischen Stimmansätze sowie die Stimmrein- und -absätze und können diese beherrschen.	- Begriffe: Stimmansatz, physiologische Stimmreinansätze und -absätze - Prüfen, Beurteilen - Anwendung	theoretische Hinweise; Demonstration und Hörbeispiele zu physiologischen und pathologischen Formen; Erarbeiten über Ableitungen, Vorstellungshilfen usw.
Sie kennen die Fehlformen.		
Sie kennen, die individuelle mittlere Sprechstimmlage und können diese auffinden und stabilisieren.	- Begriff: mittlere Sprechstimmlage - Methoden zum Auffinden und Festigen der mittleren Sprechstimmlage	Reaktivierung von Kenntnissen aus den Lerngebieten Phoniatrie, Phonetik/Linguistik und Logopädie
Sie besitzen die Fähigkeit	- Stimmklang - Schwelltonvermögen - Tonhaltedauer - Steigerungsfähigkeit - Stimmumfang - Registerübergänge	Hörbeispiele; praktische Übungen
- zur Beurteilung stimmtechnischer Fertigkeiten sowie zum selbstständigen Umsetzen dieser;		

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
- zur Beurteilung von physiologischen und pathologischen Stimmen; - des „funktionellen Hörens“, der zentralen Kontrolle der Stimmfunktion.	„funktionelles Hören“ (theoretisch, praktisch) - neuromuskuläre Kontrolle - audiophonatorische Kontrolle	Fähigkeit wird geschult im Verlauf der gesamten stimmbildnerischen Ausbildung
Sie erkennen Resonanz und Tragfähigkeit als Ergebnis von Stimmansatz und Tonsstütze.	- Resonanzbildung - Resonanzräume - Brust- und Kopfresonanz	theoretische Hinweise; praktische Übungen zur Verbesserung der Resonanzfähigkeit; Einsatz von Hilfsmitteln und Vorstellungshilfen
Sie beherrschen die Fähigkeit zur Beurteilung der Intonations-sicherheit.	Intonationssicherheit in Abhängigkeit von Hörfähigkeit und physiologischer Stimmgebung	Hörübungen in Selbst- und Fremdwahrnehmung
Sie haben Kenntnisse über stimm- und gesangspädagogische Methoden.	Methoden der Stimm- und Gesangsbildung (klassische, neuere ganzheitliche bzw. funktionsbezogene und methodenübergreifende Ansätze sowie sonstige Verfahren)	Auswahl im Ermessen der Lehrkraft, z. B. Methoden nach Schlaffhorst/Andersen, G. Alexander, Feldenkrais, Martinsen-Lohmann, Scheidemantel, Smith, Pahn, Krech, Rohmert, Rabine
Sie sind fähig zur Abgrenzung von Sprech- und Singstimme.		
Sie besitzen Grundkenntnisse über die Unterschiede der Sprech- und Singstimme sowie gesangspädagogische Besonderheiten der ausgebildeten Singstimme.	- Verschiedenartigkeit der melodisch-dynamischen Tonbewegungen; - Übergang vom Sprechen und Singen - gesangspädagogische Besonderheiten - Registerausgleich, Vokalausgleich, Stimm- und Stimmumfang	Pahn, Rohmert; Auswahl im Ermessen der Lehrkraft; Anwendung von Kenntnissen und Fertigkeiten aus dem musiktherapeutischen Praktikum

6.20 Sprecherziehung (100 Stunden)

Lernabschnitte

- 1 Sprechgestaltung
- 2 Rhetorik

Zeitrichtwerte

- ca. 50 Stunden
ca. 50 Stunden

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.20.1 Sprechgestaltung (ca. 50 Stunden)		
Die Schüler haben eine entwickelte sprechsprachliche Kommunikationsfähigkeit.	Bedeutung für Logopäden	theoretische Einführung; Diskussion; Einbeziehen von individuellen Kenntnissen und Erfahrungen der Schüler
Sie besitzen Kenntnisse über die Grundlagen der mündlichen Kommunikation sowie die Fähigkeit, diese zu beschreiben und einzusetzen.	mündliche Kommunikation - Kommunikationsmodelle • Modell nach Bühler • Sender-Empfänger-Modell • Kommunikationsaxiome • Quadrat einer Nachricht	theoretische Hinführung; Diskussion; Selbsterfahrung; Fremdbeobachtung
Sie haben eine entwickelte Wahrnehmungsfähigkeit für die Prozesse mündlicher Kommunikation.	- Einsatz sprech-sprachlicher Mitte (entsprechend der Kommunikationsabsicht und der Kommunikationssituation)	
Sie sind befähigt zur Übertragung des eigenen verbesserten Sprechverhaltens und erhöhten Sprechbewusstseins in die logopädische Praxis und können den Stellenwert der eigenen Sprech- und Redevorbildwirkung für die Patienten erfassen.		
Sie haben Kenntnisse über die physischen, psychischen und sozialen Einwirkungen auf mündliche Kommunikationsprozesse und deren Auswirkungen sowie die Fähigkeit zur Anwendung dieser Kenntnisse.	Einwirkfaktoren - physische - psychische - soziale Wirkungszusammenhänge in der Kommunikation	Selbstwahrnehmung Fremdbeobachtung Diskussion zu Sprechwirkungsfaktoren usw.; Einsatz erster allgemeiner (gesprächs-)rhetorischer Übungen zur Sensibilisierung für Kommunikationsprozesse (Vertiefung siehe Abschnitt 6.20.2)
Sie kennen die stilistischen Varianten der Standardaussprache und sind fähig zur Unterscheidung unterschiedlicher Lautstufen. Sie sind befähigt zum funktionellen Hören sowie zum gezielten Isolieren und Einschätzen einzelner Aspekte des Höreindrucks. Sie verfügen über korrekte artikulatorische Fertigkeiten und können die Artikulationskapazitäten im Rahmen der individuellen ökonomischen und vitalen Möglichkeiten einsetzen.	Lautbildung - sprecherische Grundfunktionen (Tonus, Haltung, Atmung, Phonation, Artikulation) - Hörtraining und Deskription - Begriff und Bedeutung der Artikulationsbasis in der Standardaussprache - weitere Aussprachevarianten - allgemeine Ausspracheregeln - Bedeutung und Auswirkungen der Koartikulation in der Standardaussprache - Automatisierung der richtigen Aussprache der Vokale und Konsonanten	Entwicklung der Standardaussprache (nach Schwerpunkten auf Laut-, Wort-, Satz- und Kontextebene); intensives sprechbildnerisches Funktionstraining (Übungen zur Artikulationsschulung, insbesondere zur Überwindung grober dialektgebundener Aussprachemängel in Einzel- und Gruppenarbeit)

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
6.20.2 Rhetorik (ca. 50 Stunden)		
Die Schüler besitzen entwickelte Fähigkeiten im Bereich rhetorischer Kommunikation und entwickelte Fähigkeiten und Fertigkeiten im Einsatz der prosodischen Gestaltungsmittel auf der Basis von individueller optimaler Atmung, Stimmgebung und Artikulation.	Grundlagen des Sprechausdrucks - Definition Intonation - prosodische Elemente • Grundton • Dynamik • Klangfarbe • Sprechtempo • Pausierung	Erarbeiten der wichtigsten prosodischen Elemente in Einzel- und Gruppenarbeit; Darstellen der funktionellen und psychophysischen Zusammenhänge von Sprech- und Singstimme (Schüler sollen dies an sich und anderen erfahren, beschreiben, einordnen und einsetzen können); Anleitung und Übungen zum interpretierenden Textsprechen mit Sach- und literarischen Texten (Prosa, Lyrik), Auswahl liegt im Ermessen der Lehrkraft; Abstimmung mit den Lerngebieten Phonetik/Linguistik, Stimmbildung und Logopädie
Sie verfügen über reaktivierte und vertiefte Kenntnisse zur Intonationslehre und den wichtigsten prosodischen Elementen.	- Grundlagen der Leselehre (Satzakzentuierung, Melodisierung, syntagmatische Gliederung) - Textgestaltung von Sach-, Lyrik- und Prosatexten)	
Sie erkennen Gemeinsamkeiten und Unterschieden von Sprech- und Singstimme.		
Sie beherrschen die innere Sprache und verfügen über Fähigkeiten und Fertigkeiten zum Sprechdenken und Hörverstehen.	- Sprechdenken und Hörverstehen - Erzählen als Mittel der Veranschaulichung	Übungen zum reproduzierenden Sprechdenken (Übungen zur Redevorbereitung); Selbsterfahrung; Fremdbeobachtung
Sie besitzen entwickelte Fähigkeiten des Redens	Rederhetorik - Kommunikationsmodell nach Bühler - Rede als virtueller Dialog mit den Zuhörern - Redeaufbau • Überzeugungsrede • Meinungsrede • Informationsrede - Feedbackkriterien für Sprech- und Redeleistungen - Haupttypen der Argumentation - Argumentsorten und ihre Wirkungsmöglichkeit - rhetorische Stilmittel	theoretische Einführung
- vor Gruppen;		Einführung von Symmetrie und Perspektivenübernahme als Kooperationsprinzip; Einführung in die Redegliederung; Redeübungen (Probereden nach thematischer Vorgabe und Zielgruppendifferenzierung) Feedbackübungen, Redeanalysen; theoretische Einführung; Rollenspiele und deren Analyse; Feedbackübungen; Diskussion zu deren Wirkung und zum praxisrelevanten Einsatz
- in Gruppen.		
Sie kennen grundlegende Kommunikations- und Interaktionsprozesse und sind zum Entschlüsseln von Nachrichten befähigt.	Gesprächsrhetorik - Kommunikationstheorien (Axiome nach Watzlawick, Sender- und Empfängermodell nach Schulz v. Thun) - Kommunikationsstörungen, ihre Ursachen und Klärungen - Begriff der Metakommunikation	theoretische Einführung; Übungen zu elementaren gesprächsrhetorischen Operationen im Small-Talk
Sie verfügen über Kenntnis geeigneter Bedingungen für ein Gespräch sowie über die Befähigung, diese zu schaffen.	- Grundmuster des Gesprächs - Gesprächsbedingungen (störende und fördernde Faktoren) - nondirektives Gesprächsverhalten	Rückmelden der Partneräußerung, verbalisieren der Sach- und Beziehungsebene

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Sie kennen und beherrschen die gebräuchlichen Gesprächstechniken.	- Frageformen • offene und geschlossene Fragen • direkte und indirekte Fragen - partnerorientierte Gespräche • Beratungsgespräch • Kritikgespräch - sachorientierte Gespräche (Ablauf eines Sachgesprächs; Leitung von Besprechungen: Gesprächsleiteraufgaben, Verhandlung) - Problemlösegespräch - Perspektivenübernahme	Gesprächsübungen als Rollenspiele in Partner- und Gruppenarbeit; Feedback; Analyse; Diskussion

6.21 Fachenglisch (40 Stunden)

Kompetenzbezogene allgemeine Lernziele

Die Ausbildung in der Fremdsprache leistet im Konsens mit der Ausbildung in den anderen Lerngebieten ihren Beitrag zur Befähigung der Schüler zu berufsbezogener fremdsprachlicher Handlungskompetenz. Das bedeutet, die Schüler vertiefen und erwerben Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Selbst- und Sozialkompetenz bezogen auf allgemeine und berufsbezogene Handlungsfelder.

Die Schüler

- sind in der Lage, in der Fremdsprache weitgehend sicher typische bzw. häufig auftretende Situationen bezogen auf die Bereiche Leseverstehen, Schreiben, Hörverstehen und Sprechen kommunikativ zu bewältigen.
- verfügen über berufsfeldspezifische Mittel (Fachlexik, fachtextfrequente Grammatik, syntaktische Modelle etc.), die sie gezielt einsetzen, um sich beispielsweise englischsprachige, berufsbezogene Fachtexte zu erschließen oder Therapieanweisungen in der Fremdsprache zu geben.
- beherrschen Gesprächsmanagement sowie die verschiedenen Kommunikationsstrategien in der Fremdsprache und können diese bezogen auf die jeweilige Situation anwenden.
- sind in der Lage, selbstständig Informationen aus englischsprachigen Fachtexten zu erfassen und zu verarbeiten, Aufgaben zu lösen und Texte zu produzieren.
- besitzen die Fähigkeit, Lern- und Arbeitsphasen zu planen und zu gliedern.
- sind in der Lage, ihr verfügbares sprachliches und strategisches Wissen in der Muttersprache und in der englischen Sprache effektiv miteinander zu verknüpfen und einzusetzen (Sprachlernbewusstheit).
- besitzen interkulturelles Verständnis, Aufgeschlossenheit und Toleranz gegenüber anderen Kulturen und Nationalitäten (interkulturelle Kompetenz).

Grundsätzliche Orientierungen für den Fremdsprachenunterricht:

- Der Unterricht knüpft an die Voraussetzungen an, die die Schüler mitbringen.
- Der Unterricht hat realistische Ziele, die im Bildungsgang erreicht werden können. Die Schüler sollen lernen, was sie tatsächlich brauchen.
- Der Unterricht führt zu einer beruflichen Handlungsfähigkeit. Dies bedeutet u. a., dass die Schüler auf die Arbeit mit anders sprechenden Partnern bzw. fremdsprachigen Materialien vorbereitet werden.
- Der Unterricht nutzt authentisches fremdsprachiges Arbeitsmaterial sowie Texte und Unterrichtsmaterialien mit fachspezifischem Inhalt.
- Das Lernen im Fremdsprachenunterricht soll motivieren, z. B. durch adäquate, sinnstiftende und auch interessante Anforderungen, handlungsorientierte bzw. schülerorientierte Aufgaben etc.
- Die Inhalte des Unterrichts zielen vorwiegend auf eine berufliche Orientierung mit allgemein sprachlichen, berufsfeldspezifischen und berufsspezifischen Akzenten.

Hinweise zur Darstellung

Die Entwicklung von Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Selbst- und Sozialkompetenz ist in der Spalte Lernziele konkretisiert und erfolgt im Kontext der Lerninhalte. Diese sind in Form von Themenbereichen aufgeführt. Interkulturelle Handlungsfähigkeit wird innerhalb der Themenbereiche immanent und akzentuiert entwickelt.

Die Inhalte der Themenbereiche und die Behandlung weiterer Lernziele und -inhalte, wie Sprachfunktionen, Sprachmittel (Lexik, Grammatik u. a.) müssen an die Erfordernisse des Fachbereiches sowie an den Kenntnisstand der Klasse angepasst werden.

Die angegebenen Stundenzahlen sind empfohlene Richtwerte. Lerninhalte, die die Entwicklung von Teilkompetenzen (Methodenkompetenz, Selbst- und Sozialkompetenz) sowie von übergreifenden Bereichen des Sprachlernens (Sprachfunktionen, Sprachmittel) betreffen, sind immanent zu realisieren.

Lernabschnitte	Stunden
1 Kommunikative Fertigkeiten: - Hör-/Hör-Sehverstehen, Sprechen/an Gesprächen teilnehmen - Leseverstehen, Schreiben	40
2 Sprachfunktionen	immanent
3 Sprachmittel	immanent
4 Selbst- und Sozialkompetenz	immanent

1 Kommunikative Fertigkeiten (40 Stunden)

Hör-/Hör-Sehverstehen, Sprechen/an Gesprächen teilnehmen

Lernziele	Lerninhalte	Didaktisch-methodische Hinweise
Die Schüler erkennen die Bedeutung der englischen Sprache als Verständigungsmittel, Geschäfts-, Verkehrs- und Konferenzsprache.	- Englisch als internationales Kommunikationsmittel - Englisch in der Medizin - Englisch in der Logopädie	Verwendung traditioneller und neuer Medien zur Erhöhung der Anschaulichkeit
Sie können sich selbst vorstellen und über die Familie sprechen.	Vorstellung der eigenen Person Familie	Darlegen zusammenhängender Sachverhalte „That’s me and my family“
Sie können typische Alltagssituationen bewältigen.	Hotelreservierung Arztbesuch	Hörverstehen dialogisches Sprechen
Sie besitzen die Fähigkeit zur - Führung von Gesprächen, themengebunden und in fachbezogenen Zusammenhängen; - Beratung von Patienten in englischer Sprache.	- Führen von Gesprächen • Berufsbild des Logopäden • Abläufe bei Untersuchungen • Diagnosen von Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen • Beratung von Patienten hinsichtlich der Therapie - Teilnahme an Fachvorträgen und Diskussionen	lerngebietsübergreifender Unterricht Erstellung von Fachvorträgen mit Präsentation Rollenspiele Auswertung von Fachvideos

Leseverstehen, Schreiben

Die Schüler erfassen und verarbeiten den Sinngehalt und Detailinformationen von Fachtexten.	- gesunde Lebensweise - Gesundheitswesen - Anatomie und Physiologie - Erkrankungen ausgewählter Organsysteme	Verwendung authentischer fachspezifischer Texte und Materialien
Sie sind fähig - zur Formulierung von Fachtexten in englischer Sprache; - zum Schreiben von Arztbriefen in englischer Sprache.	- Logopädie • Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen • Bedienungsanleitungen logopädischer Instrumente • Untersuchungsabläufe	Verwendung traditioneller und neuer Medien Internetrecherche Darstellen von Gehörtem (z. B. Fachvideos) oder Erlebtem in berichtender oder beschreibender Form

Lernziele**Lerninhalte****2 Sprachfunktionen (immanent)**

Die Schüler können alle Sprachfunktionen sowohl einsprachig (englisch) als auch vermittelnd in zweisprachigen Situationen (englisch-deutsch) anwenden.

- | | |
|--|---|
| Die Schüler können Kontakte herstellen. | <ul style="list-style-type: none"> - Personen ansprechen, begrüßen, verabschieden - sich und andere vorstellen - Personen nach dem Befinden fragen - Verstehen und Nichtverstehen ausdrücken - Bedauern/Entschuldigung ausdrücken - Verabredungen treffen - Hilfe anbieten - Jemandem etwas wünschen - Danken und auf Dank reagieren |
| Sie sind in der Lage, aufzufordern. | <ul style="list-style-type: none"> - Vorschläge unterbreiten, Ratschläge erteilen - Zustimmung/Ablehnung ausdrücken - Anregungen, Vorschläge, Ratschläge unterbreiten - Warnungen/Verbote formulieren |
| Sie können Gefühle äußern/sich über Gefühle verständigen. | <ul style="list-style-type: none"> - Freude/Begeisterung ausdrücken - Gefallen/Missfallen ausdrücken - Interesse ausdrücken - Hoffnungen/Wünsche ausdrücken - Zweifel/Vermutung/Gewissheit ausdrücken - Erstaunen/Verwunderung/Überraschung ausdrücken - Befürchtungen ausdrücken |
| Sie können beschreiben, erläutern, berichten. | <ul style="list-style-type: none"> - etwas oder jemanden beschreiben - Vorgänge und Abläufe beschreiben, erklären |
| Sie sind in der Lage, Meinungen zu äußern, zu argumentieren. | <ul style="list-style-type: none"> - Meinungen äußern und begründen - Wertungen vornehmen - Bedingungen formulieren - Schlussfolgerungen ziehen |

3 Sprachmittel (immanent)

- | | |
|--|---|
| Die Schüler beherrschen | <ul style="list-style-type: none"> - Gesundheitswesen <ul style="list-style-type: none"> • Facharztbezeichnungen • Vergleich Gesundheitswesen Deutschland – GB/USA • Ausbildung zum Logopäden • ausgewählte medizinische Geräte und Instrumente • Lautsystem und Lautbildung - Anatomie und Physiologie <ul style="list-style-type: none"> • allgemeine Anatomie und Physiologie • Anatomie und Physiologie der Lautbildungsorgane - ausgewählte Erkrankungen <ul style="list-style-type: none"> • Infektionskrankheiten • Schlaganfall • psychische Erkrankungen - Logopädie <ul style="list-style-type: none"> • Sprach-, Sprech-, Stimm- und Schluckstörungen • wichtige logopädische Geräte und Hilfsmittel |
| <ul style="list-style-type: none"> - berufsfeldspezifische und berufsspezifische lexikalische Mittel; - allgemein sprachliche Lexik (reaktiviert und erweitert); | allgemein sprachlicher Wortschatz entsprechend der Sprachfunktionen |

Lernziele	Lerninhalte
- alltagssprachliche und fachfrequente grammatische Strukturen.	- Aussagen, Fragen und Aufforderungen in bejahter und verneinter Form verstehen und formulieren (word order, affirmative and negative phrases and questions) - Handlungen, Ereignisse und Sachverhalte als gegenwärtig, vergangen, zukünftig oder zeitlos, mehrere Geschehnisse als gleichzeitig oder aufeinander folgend bzw. unter Berücksichtigung von Vor- und Nachzeitigkeit erkennen und wiedergeben (tenses, regular and irregular verbs, gerund and infinitive) - Erlaubnis, Möglichkeit, Wunsch, Verpflichtung/Notwendigkeit, Wahrscheinlichkeit, Fähigkeit bzw. das Gegenteil dessen ausdrücken (modal auxiliaries) - räumliche, zeitliche und logische Beziehungen erkennen und herstellen (prepositions) - Handlungsperspektiven verstehen und selbst formulieren (active und passive voice) - Anzahl, Art und Zugehörigkeit von Gegenständen, Personen und Sachverhalten erkennen und beschreiben (countable and uncountable nouns, adjective and adverbs, comparison, definite and indefinite articles, pronouns) - Informationen wörtlich und vermittelt wiedergeben (direct/indirect speech) - Bedingungen und Bezüge formulieren (conditional clauses 1-2)
4 Selbst- und Sozialkompetenz (immanent)	
Die Schüler können im Team arbeiten.	z. B. Planen, Durchführen. Evaluieren von kooperativen Lernphasen, Gesprächstechniken, Toleranz
Sie beherrschen professionelles Selbstmanagement.	z. B. Zeitmanagement, Umgang mit Arbeitsmitteln
Sie können in interkulturellen Prozessen und Situationen bestehen.	z. B. Einblicke in andere Kulturen, Beispiele für kulturelle Unterschiede/Konflikte, interkulturelle Bewältigungsstrategien